

PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE SÃO PAULO
PUC SP

ROSALBA FILIPINI

**Psicoterapia Psicodramática com Crianças: uma
proposta Socionômica**

DOUTORADO EM PSICOLOGIA CLÍNICA

SÃO PAULO
2013

ROSALBA FILIPINI

**Psicoterapia Psicodramática com Crianças: uma
proposta Socionômica**

DOUTORADO EM PSICOLOGIA CLÍNICA

**Tese apresentada à Banca Examinadora
da Pontifícia Universidade Católica de
São Paulo, como exigência parcial para
obtenção do título de doutor em
Psicologia Clínica sob a orientação da
Profa. Dra. Rosane Mantilla de Souza.**

BANCA EXAMINADORA

DEDICATÓRIA

À Julia e Henrique, sempre.

Às minhas irmãs Rosangela, Denise e Cláudia, com as
quais aprendi a brincar, amar e crescer.

AGRADECIMENTOS

Em primeiro lugar, agradeço a todas as crianças e seus familiares que confiaram e compartilharam comigo suas vidas. Com vocês aprendi a ser psicóloga, psicoterapeuta e psicodramatista.

À Rosane, minha orientadora, que sempre me acolheu, ensinou e me incentivou no percurso acadêmico, com seu exemplo de vida e profissional.

À Marcia, minha querida amiga e professora. Obrigada pela incansável dedicação e confiança em meu trabalho. Sua presença afetiva e profissional foram e são imprescindíveis.

À minha banca examinadora: Anibal, Dolores, Flávia e Marcia; Adriana e Valéria, pela disponibilidade e cooperação. Também aos colegas psicodramatistas que trabalham arduamente na coconstrução da obra de J. L. Moreno.

Aos meus alunos que me incentivam à pensar, questionar e sempre escolher o psicodrama.

Aos colegas da SOPSP e PUC, que mesmo quando à distância contribuem para meu crescimento profissional.

Ao Caps e Puc-SP por financiarem esse trabalho.

À Geni, minha assistente na logística da vida e à Sumico pela prontidão em revisar esse trabalho.

Aos 'novos' amigos que me acompanharam especialmente nos últimos dois anos. A alegria, animação e energia do grupo foram essenciais para a finalização desse trabalho.

Às minhas queridas amigas do 'café da manhã', Claudiane, Julieta, Marina e Silvia. Encontros essenciais para revigorar o corpo e o coração. Às meninas do 'clubes do livro' que com paciência me aguardam e me incentivaram a prosseguir.

À dona Landa, sempre atenciosa, interessada e motivadora dos meus projetos.

À dona Lidia e sr. Eliel, pela presença, carinho e acolhida em sua família.

Aos meus queridos pais, Santo e Lourdes, pelo amor, orgulho e confiança que sempre auxiliaram a mim e minhas irmãs a querer e considerar que podemos.

Às minhas queridas irmãs, Rosangela, Denise e Claudia, exemplos de força, amor e dedicação. Aos meus cunhados queridos, Sérgio e Fran; tio Cláudio e tia Andréa, todos irmãos de coração. Aos meus queridos sobrinhos Daniel e Helena.

Aos meus amados filhos Julia e Henrique que sempre acreditam, desafiam e me impulsionam a considerar que a vida vale muito a pena.

Ao meu querido Ed um agradecimento especial: pelo seu amor, parceria de todas as horas e compromissos. Sua presença, paciência e ajuda foram essenciais para realizar e concluir esse trabalho. Obrigada pelas traduções, leitura, serviços de TI, etc.

FILIPINI, Rosalba. Psicoterapia Psicodramática com Crianças: uma proposta Socionômica. 2013. 192 p. Tese (Doutorado em Psicologia Clínica). Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, São Paulo, 2013.

RESUMO

Trata-se de um trabalho teórico de análise dos fundamentos do Psicodrama com crianças. Sendo um trabalho conceitual e focado em uma modalidade específica do psicodrama, foram consultadas as produções literárias da área e analisada a prática psicodramática com crianças. O objetivo foi discutir a estrutura e prática da psicoterapia psicodramática com crianças, analisando como os autores têm realizado essa modalidade de trabalho, em que aspectos há concordância e/ou divergência e qual o alcance, limites e especificidades diante da proposta de psicoterapia psicodramática criada por J. L. Moreno. A reflexão sobre a teoria e a prática clínica infantil pode contribuir com a comunidade científica, clínica e acadêmica, propiciando subsídios sobre a prática profissional. A análise evidenciou que há uma divisão entre os psicodramatistas que trabalham com crianças: os que buscam outros referenciais teóricos e os que consideram que a teoria socionômica tem uma estrutura teórica e prática que fundamentam o trabalho psicoterápico. Há unanimidade em conceber que crianças pré-escolares não invertem papéis; que as escolares necessitam de maior aquecimento para a ação dramática, tal como na psicoterapia com adultos, bem como se beneficiam das técnicas psicodramáticas. A técnica do duplo-espelho é uma proposta da autora, a qual é possibilitada quando o contrapapel exercido pelo psicoterapeuta tem simetria com o papel exercido pela criança. A psicoterapia busca a realização de um projeto dramático que é coconstruído entre criança e psicoterapeuta. O compartilhar é entendido como uma etapa existente e importante no processo psicoterápico delas. Por meio da discussão da prática da psicoterapia psicodramática com crianças, considerou-se que a teoria da espontaneidade e criatividade, a sociometria, a teoria de papéis e a teoria do momento, oferecem subsídios para a ação dramática e para a compreensão do processo psicoterápico da criança.

Palavras chave: psicoterapia com crianças, psicodrama, socionomia.

ABSTRACT

This is a theoretical analysis of the fundamentals of Psychodrama with children. Being a conceptual work and focused on a specific form of psychodrama, literary production in this field was consulted and the practice in psychotherapy with children was analyzed. The goal was to discuss the structure and practice of psychodramatic psychotherapy with children, analyzing how the authors have been performing this type of work, in which aspects there is agreement and / or disagreement and the range, limits and specifics facing the proposed psychodramatic psychotherapy created by J. L. Moreno. The reflection on theory and infant clinical practice can contribute to the scientific, clinical and academic community, providing subsidies on professional practice. The analysis revealed that there is a division between psychodramatists working with children: those who seek other theoretical references and those who believe that the sociodynamics theory has a theoretical and practical framework underlying the psychotherapeutic work. There is unanimity in conceiving that preschoolers do not reverse roles: that the students need greater warming for dramatic action, as in psychotherapy with adults, as well as they benefit from psychodrama techniques. The technique of double-mirroring is an authors proposal, which is made possible when the counter-role played by the psychotherapist has symmetry with the role played by the child. Psychotherapy seeks the realization of a dramatic project that is co-built between child and psychotherapist. Sharing is understood as an existing and important stage in their psychotherapeutic process. Through discussion of the practice of psychodramatic psychotherapy with children, it was considered that the theory of spontaneity and creativity, sociometry, the role theory and the theory of the moment, offer subsidies to dramatic action and to the understanding of the process of child psychotherapy.

Keywords: child psychotherapy, psychodrama, Sociodynamics.

RÉSUMÉ

Il s'agit d'un travail théorique d'analyse des fondements de Psychodrame avec des enfants. Comme il s'agit d'un travail de conception focalisé sur une modalité spécifique du psychodrame, les productions littéraires en ce domaine ont été consultées et les pratiques de psychodrame avec des enfants ont été analysées. L'objectif étant d'analyser une structure et la pratique de psychothérapie psychodramatique avec des enfants, en vérifiant comment les auteurs ont réalisé cette modalité de travail, et en quels aspects il y a concordance et/ou divergence ainsi que la portée, les limites et les spécificités en fonction de la proposition de psychothérapie psychodramatique créées par J. L. Moreno. Une réflexion sur la théorie et la pratique clinique infantile peut contribuer avec la communauté scientifique, clinique et académique, en fournissant des éléments sur la pratique. L'analyse a mis en évidence qu'il y a une division entre les pratiquants de psychodrames qui travaillent avec des enfants: entre ceux qui recherchent d'autres références théoriques et ceux qui considèrent que la théorie "socioéconomique" a une structure théorique et une pratique qui renforce le travail de psychothérapie. Il y a unanimité à admettre que les enfants en situation pré-scolaire n'invertissent pas les rôles, et que ceux en situation scolaire ont besoin d'un entraînement plus important pour l'action dramatique, comme dans la psychothérapie pour adultes, et qu'ils se bénéficient des techniques de psychodrame. La technique du double-miroir est une proposition de l'auteur qui est rendue possible quand le rôle exercé par le psychothérapeute a une symétrie avec le rôle exercé par l'enfant. La psychothérapie cherche la réalisation d'un projet dramatique qui est construit en commun entre l'enfant et le psychothérapeute. Ceci est admis comme une étape importante dans leur processus psychothérapeutique. Grâce aux discussions sur cette pratique de psychothérapie psychodramatique avec des enfants, nous pouvons considérer que la théorie de la spontanéité et de créativité, la "sociométrie", la théorie des rôles et la théorie du moment, offrent des éléments pour une action dramatique et pour la compréhension du processus de psychothérapie de l'enfant.

Mots clef : psychothérapie avec des enfants, psychodrame, "socioéconomie".

SUMÁRIO

INTRODUÇÃO	10
CAPÍTULO 1 – PSICOTERAPIA	17
Conceito de Psicoterapia	17
A Psicoterapia a partir do século XX	20
Psicoterapia com crianças: as primeiras contribuições	23
Psicoterapia no Brasil	29
CAPÍTULO 2 – PSICODRAMA	35
Estrutura da teoria da psicoterapia psicodramática	35
1. Moreno, sua relação com as crianças e a construção da Teoria Socionômica	36
2. Conceitos da Teoria Socionômica: Visão Moreniana de Homem.....	39
Matriz de Identidade: <i>placenta social</i> da criança.....	48
CAPÍTULO 3 – PSICOTERAPIA PSICODRAMÁTICA COM CRIANÇAS	61
Jacob Levy e Zerka Moreno: contribuições ao psicodrama com crianças	61
O Psicodrama com crianças no Brasil	69
CAPÍTULO 4 – A ESTRUTURA DA PRÁTICA DA PSICOTERAPIA PSICODRAMÁTICA COM CRIANÇAS	91
Os Contextos: Social, Grupal e Dramático	92
No Contexto Social:	
1. Indicação	97
2. A sala de atendimento e os materiais	99
3. O contrato de trabalho: com os pais; com as crianças	102
Os Instrumentos.....	105
1. Cenário.....	107
2. Protagonista: o brincar infantil.....	108
3. Diretor e Ego Auxiliar.....	112
4. Plateia.....	114
Início do trabalho psicoterápico.....	115
As primeiras sessões.....	115
1. Primeiras sessões com crianças.....	116
2. Primeiras sessões com os cuidadores.....	121
Etapas da sessão psicodramática.....	123
1. Aquecimento.....	124
2. Dramatização.....	133
3. Compartilhar.....	175
CAPÍTULO 5 – CONSIDERAÇÕES FINAIS.....	181
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS	187

INTRODUÇÃO

Uma escola de fazenda foi o primeiro cenário da construção do meu papel profissional com crianças. Recém-formada, minha tarefa era avaliar alguns alunos e orientar a professora, mas na verdade eu é que era orientada por ela, o seu papel profissional estava muito mais desenvolvido que o meu. Fiz curso de ludoterapia, iniciei trabalho em consultório e paralelamente, por alguns anos, fui diretora de creche. O envolvimento profissional com as crianças foi aumentando e em 1989 ingressei no curso de formação em psicodrama. Psicodrama é o termo que mais se popularizou dentro da Socionomia, ciência criada por Jacob Levy Moreno (1889-1974), que tem como eixo central estudar as leis que regem os comportamentos social e grupal. Da Socionomia advém o Psicodrama que é o tratamento do indivíduo e do grupo por meio da ação dramática (Moreno, 1975).

Participando de um trabalho psicodramático, descobri o *locus* do meu interesse por crianças e psicodrama. Ainda pequena eu e minhas irmãs brincávamos, atrás da nossa casa, de uma emocionante história – *Os elefantes estão chegando!* A espontaneidade e criatividade eram intensas nessa brincadeira e lá podíamos desempenhar nossos papéis psicodramáticos com emoção e bravura. A brincadeira se repetia dia após dia e ninguém reclamava ou enjoava-se disso – havia a que anunciava que os elefantes estavam chegando, a que corria primeiro para o alto do parapeito e a que chorava porque não conseguia subir e seria pisoteada pelos imensos elefantes. Cumplicidade, companheirismo, disputa e muita paixão eram compartilhados pelas três irmãs

mais velhas. Cada uma desempenhava seu papel social e psicodramático de acordo com o lugar que ocupava na família e todas sempre foram salvas da desenfreada manada de elefantes.

No decorrer do curso de psicodrama fiz parte de um grupo de supervisão de atendimento infantil. Apresentei meu primeiro trabalho sobre psicodrama com crianças no Congresso sobre a Infância e Adolescência em Curitiba, em 1993. O título do trabalho foi: O período das “Histórias da oncinha apaixonada” numa criança portadora da Síndrome de Asperger (Filipini, 1994). Nesse trabalho discorri sobre um período do processo psicoterápico de uma criança, com ênfase no vínculo que foi construído entre ela e a psicoterapeuta. Depois vieram os outros congressos de psicodrama onde sozinha, ou em parceria, apresentei alguma contribuição, discussão ou reflexão sobre crianças e psicodrama. Em 2003 concluí meu Mestrado na PUC-SP, que tratou de uma intervenção para crianças na situação de separação ou divórcio parental (Filipini, 2003). Trabalhei com um grupo de crianças em uma escola e, após a construção e desenvolvimento do trabalho, fiz análise do processo desse grupo por meio do psicodrama (Filipini, 2005a).

No Mestrado, o trabalho desenvolvido com as crianças foi um grupo de apoio, que quando pensado numa linguagem psicodramática, aproxima-se de um Sociodrama, ou seja, quando o foco da intervenção está no grupo, no que o origina e o mantém unido. Trabalhar com as crianças, poder auxiliá-las a identificar suas emoções e desenvolver recursos para lidar com as demandas que a situação familiar lhes exigia, foi extremamente gratificante. Pude transpor esse conhecimento para a clínica psicoterápica, onde mais desempenho meu papel profissional.

No trabalho clínico, no exercício do papel de professora, bem como nos congressos e outros eventos científicos, o meu foco é voltado basicamente para crianças e Psicodrama. O exercício profissional como psicoterapeuta de crianças, que se mescla a conhecimentos variados, impulsiona-me a verificar com mais acuidade a estrutura desse tipo de psicoterapia psicodramática, seu alcance, seus limites e como ele se diferencia ou se caracteriza diante do considerado psicodrama “clássico” moreniano.

A prática psicodramática pressupõe o entendimento de Homem inserido numa sociedade, onde o *Eu* se constitui por meio das relações (Moreno, 1975). Para trabalhar terapeuticamente, Moreno criou uma estrutura e conceitos que ficaram conhecidos pelos psicodramatistas como o “tripé” da prática psicodramática: contextos, etapas e instrumentos. O processamento de uma sessão baseia-se na leitura e compreensão dos mesmos, ou seja, identificar o contexto social, grupal e terapêutico; seguir as etapas de aquecimento, dramatização e o compartilhar; utilizar-se dos instrumentos cenário, diretor, ego-auxiliar, protagonista e público (Moreno, 1972; 1975; 1999). Para tal, Moreno desenvolveu técnicas que são utilizadas no percurso do trabalho. Essa é a forma que a maior parte das escolas ensinam e como os psicodramatistas trabalham, seja na sua modalidade individual ou grupal, terapêutica ou socioeducacional.

Quando pesquisei sobre essa prática com crianças no Brasil, encontrei algumas produções que considero mais significativas pela sua contribuição ao conhecimento do psicodrama e à psicologia de forma geral (Ferrari, 1984; Gonçalves, 1988; Tassinari, 1990; Andrade, 1996; Wechsler, 1998, 1999; Petrilli, 2000; Filipini, 2005).

Entretanto, o trabalho de psicodrama com crianças ainda é discutido por esses e outros profissionais da área, seja pela sua especificidade ou pelo questionamento de que Moreno não criou uma teoria do desenvolvimento que abarcasse todas as questões da infância. Ele é considerado prolixo por alguns (Naffah, 1980), desorganizado por outros (Knobel, 2004) ou com obra literária ainda a ser explorada por seus contemporâneos (Petrilli, 2000). A literatura e a prática do psicodrama com crianças têm produção menor, quando comparadas ao trabalho com o público adulto, necessitando de que seja revista, discutida e ampliada.

Além de escassa, a literatura sobre o assunto contém contribuição de vários outros autores não psicodramatistas ou teorias que auxiliam a fundamentar a teoria psicodramática. Dessa forma, o objetivo deste trabalho é discutir a estrutura e prática da psicoterapia psicodramática com crianças, analisando como os autores de psicodrama têm realizado essa modalidade de trabalho, em que aspectos há concordância e/ou divergência e qual o alcance, limites e especificidades diante da proposta de psicoterapia psicodramática criada por J. L. Moreno.

Trata-se de um trabalho teórico de análise dos fundamentos do Psicodrama com crianças. Sendo um trabalho conceitual e focado na modalidade específica do psicodrama, foram consultadas as produções literárias da área e discutida a prática psicodramática com crianças. Usei como ilustração fragmentos e ou vinhetas de casos antigos com o objetivo de mostrar o uso de técnicas. São fragmentos de casos que já foram encerrados, sem possibilidade da identificação das pessoas. Refletir sobre a teoria e a prática de clínica infantil poderão contribuir com a comunidade científica, clínica e acadêmica,

propiciando subsídios sobre a prática profissional e ampliando as possibilidades de pesquisa.

Quando buscamos a origem do Psicodrama é impossível desvinculá-la da *brincadeira de ser Deus* do jovem Moreno, bem como de seus jogos de improviso com as crianças nos jardins de Viena na década de 1910 (Moreno, 1975). A brincadeira de “*ser Deus*” ocorreu quando tinha quatro anos e considerada, quase que romanticamente, como seu primeiro psicodrama. Tratou-se de uma brincadeira que ele e seus amigos, sem nada mais a fazer, resolveram brincar no porão da sua casa. Moreno assumiu o papel de *Deus* e, para isso, empilharam uma série de cadeiras para que ele chegasse o mais próximo possível do *céu*; as outras crianças assumiram o papel de anjos e voavam ao seu redor. No final, a brincadeira rendeu-lhe um braço quebrado, mas muita satisfação. Ora, essa brincadeira não passou de um faz de conta com seus amigos, tal qual os diversos jogos infantis que as crianças desenvolvem (“*Os elefantes estão chegando!*”).

A despeito disso, Moreno valorizou o jogo de improviso e desta forma, para que construísse toda sua metodologia, inicialmente vivenciou, coparticipou observou e dirigiu diversos jogos infantis de faz de conta – daí também a sua concepção de Homem como um ser potencialmente criativo e espontâneo (Moreno, 1999).

A cena narrada oferece subsídios para que compreendamos sua proposta para o psicodrama: a ação, o ‘faz de conta’, a coconstrução, a espontaneidade e criatividade. Desta forma, para discutir sobre a psicoterapia psicodramática com crianças, apresentarei primeiro a concepção que temos

sobre psicoterapia e a partir daí como se inseriu o psicodrama como prática psicoterápica.

No primeiro capítulo, apresento a psicoterapia e como ela surge na prática da saúde mental. Meu foco é a psicoterapia com crianças, assim sendo, as primeiras contribuições que vieram da psicanálise são expostas, bem como a inserção da psicoterapia com crianças no Brasil. As mudanças que foram ocorrendo ao longo do século XX quanto à visão de sujeito e intervenção psicoterápica propiciaram que a psicoterapia psicodramática encontrasse um campo de atuação no Brasil que lhe foi favorável.

No segundo capítulo discuto o psicodrama e a estrutura da teoria da psicoterapia psicodramática. Foco na relação de Moreno com as crianças e a construção da Teoria Socionômica. Para se fazer psicoterapia é necessário uma concepção de sujeito, então, a visão moreniana de *Homem* e os conceitos da Teoria Socionômica são desenvolvidos nesse capítulo no qual também trago a Matriz de Identidade concebida por Moreno como a “placenta social” onde é inserida a criança. Compreendo que Moreno não teve o objetivo de construir uma teoria do desenvolvimento, mas sim, contextualizar o processo de formação da identidade de um indivíduo que se constitui por meio das relações.

Apresento e discuto no segundo capítulo o estudo que Moreno chamou de *Matriz de Identidade* e experimentos que desenvolveu sobre *inversão de papéis*.

As contribuições do psicodrama com crianças no Brasil são apresentadas no terceiro capítulo. Os autores brasileiros discutem sobre a escassez de literatura produzida por Moreno no trabalho com crianças, especialmente pela falta de uma teoria do desenvolvimento. Diante disso, o

referencial da psicanálise e da psicologia psicodinâmica é utilizado por alguns (Gonçalves, 1988; Petrilli, 2000), e em especial, Wechsler (1998, 1999) realiza uma pesquisa correlacionando psicodrama com construtivismo, compondo desta forma, uma compreensão do desenvolvimento infantil nas diversas faixas etárias e a função do jogo na atividade da criança. Sua contribuição é valiosa e seu foco é educacional, ficando a ser explorado o seu valor na psicoterapia.

Há duas autoras que realizaram seus trabalhos de psicoterapia com crianças, fundamentados na teoria psicodramática (Ferrari, 1985; Tassinari, 1990), especialmente a segunda que considero a mais *moreniana* dos autores, com um único artigo na *Revista Brasileira de Psicodrama* no qual apresentou sua forma de pensar e fazer psicodrama com crianças.

Finalizando esta introdução, o quarto capítulo é dedicado à prática da psicoterapia psicodramática com crianças. Moreno construiu a teoria Socionômica por meio de seus trabalhos com grupos, mas a prática da psicoterapia não é designada apenas a grupos. Este capítulo é constituído pela estrutura da prática e, desta forma, subdivido-o, seguindo o considerado psicodrama “clássico”, com seus contextos, instrumentos e etapas.

Capítulo 1

PSICOTERAPIA

Neste capítulo abordo o conceito de psicoterapia, trazendo a definição de duas instituições, uma internacional e outra nacional, as quais representam e congregam profissionais da área da psicologia. A psicoterapia é uma prática que foi se delineando ao longo da história e, discuto nesse trabalho, a psicoterapia com crianças, seus precursores e sua origem no Brasil.

Conceito de Psicoterapia

A doença mental esteve por muito tempo associada ao campo da superstição e a aspectos religiosos, sendo concebida como sinal de cólera divina ou como castigo pelo pecado (Mira y López, 1967). À medida que a medicina foi se desenvolvendo, essa ideia sofreu transformações e, especialmente com o crescimento das ciências naturais no século XVIII, ações terapêuticas no campo da saúde foram se instalando (Mira y López, 1967; Teixeira e Nunes, 2001; Rodegheri, 2011). A prática psicoterápica era uma dessas ações.

Há muitas definições de psicoterapia e a atividade de psicoterapeuta no Brasil, desde seu surgimento no início do século XX até a atualidade, se mantém como um campo de atuação possível de ser exercido por profissionais de diferentes formações (Teixeira e Nunes, 2005). Essa questão é comum no Brasil e em outros países, ou seja, ainda se busca encontrar a unidade na multiplicidade quando se refere ao tema 'psicoterapia'.

Neste trabalho, o foco é a psicoterapia com crianças e não tenho como objetivo discutir as diversas definições e abordagens sobre o tema psicoterapia. Mas, para elucidar o conceito, trago duas definições atuais, a da American Psychological Association, a APA, e do Conselho Federal de Psicologia, o CFP do Brasil, duas instituições que se encarregam de organizar, difundir e sistematizar a prática psicoterápica.

Para a APA define-se como:

“qualquer serviço psicológico fornecido por um profissional treinado que usa principalmente formas de comunicação e interação para avaliar, diagnosticar e tratar reações emocionais, formas de pensamento e padrões de comportamento disfuncionais de um indivíduo, uma família ou um grupo” (2010, p. 765).

Para o CFP a psicoterapia é:

“prática do psicólogo, por se constituir, técnica e conceitualmente, um processo científico de compreensão, análise e intervenção que se realiza através da aplicação sistematizada e controlada de métodos e técnicas psicológicas reconhecidas pela ciência, pela prática, pela ética profissional, promovendo a saúde mental e proporcionando condições para o enfrentamento de conflitos e/ou transtornos psíquicos de indivíduos ou grupos” (2009, p. 17-18).

Nas duas definições não há ênfase na patologia, nelas destacam-se as reações emocionais, pensamentos e comportamentos disfuncionais, conflitos ou transtornos de ordem psíquica, ou seja, fala-se de sofrimento e não de patologia. Nesse aspecto podemos verificar que o conceito de saúde mental prevalece. A prática já é reconhecida pelo CFP como uma intervenção e não necessariamente busca-se um diagnóstico preliminar que caracterize um processo de doença. A expressão “promover a saúde mental” está contida apenas na definição do CFP, o que a distingue do outro conceito especialmente quanto ao seu objetivo, que é

mais abrangente, prevalecendo ainda na outra (APA) a concepção de psicoterapia como tratamento. A prática pressupõe uma relação, mas ela não é determinada, nem delimitada; nota-se que o CFP não menciona mais o termo 'família', mas sim 'grupos', o que parece abarcar todas as formas de cuidado vigentes.

Teixeira e Nunes (2001) e Rodegheri (2011) pesquisaram sobre a história da psicoterapia no Brasil por meio da análise de artigos científicos voltados ao tema. As duas pesquisas incluíram os períodos de 1955 a 2010 e demonstraram como o trabalho psicoterápico está inserido num padrão sócio-histórico e cultural e é uma intervenção que implica numa relação interpessoal. Assim, é um sistema de cuidados que traz em si um posicionamento ideológico também.

Considerando as definições da APA, do CFP, das revisões históricas de artigos sobre o tema (Teixeira e Nunes, 2001; Rodegheri, 2011) e revendo o conceito psicoterapia para outros autores (Myra y López, 1967; Chazaud, 1977; Malan, 1983; Ribeiro, 1986; Naffah, 1982, 1994; Porchat, 1999) é possível inferir que a prática psicoterápica visa a, de forma geral, auxiliar as pessoas que apresentam algum conflito ou transtorno psíquico em graus variados. O empenho e compromisso de cada um dos envolvidos levam, gradativamente, o paciente a se reorganizar. Essa reorganização pode ser no aspecto intrapsíquico e inter-relacional. As práticas psicoterápicas não têm o objetivo de mudar o mundo ou adaptar o sujeito a ele, e sim, torná-lo apto a viver neste mundo, na sua realidade e contexto sócio-histórico, tal como ele é. Desta forma, a prática psicoterápica busca capacitar o indivíduo a fazer escolhas e responsabilizar-se por elas, desenvolver recursos e aprofundar o próprio conhecimento.

Não se diferencia psicoterapia para diferentes faixas etárias, no entanto, a criança depende de seus cuidadores quanto à decisão e andamento do processo psicoterápico, o que é um diferencial no aspecto do engajamento ao mesmo. É necessário o compromisso dos responsáveis pela criança e não somente o dela.

Para elucidar a evolução do conceito de psicoterapia, faço breve histórico sobre o tema, chegando à prática psicoterápica com crianças que é o objetivo deste trabalho.

A Psicoterapia a partir do século XX

No início do século XX, a psicoterapia esteve integrada com a psiquiatria, que por sua vez, ligava-se ao movimento de higiene mental (Mira y López, 1967; Teixeira e Nunes, 2001; Rodegheri, 2011). Este movimento iniciou-se nos EUA, em 1909, e a criação do termo *higiene mental* foi atribuída a Adolph Meyer. Uma das primeiras definições do termo data de 1863 e foca no ato de ‘preservar a saúde do espírito’ contra todos os incidentes e influências capazes de prejudicar suas qualidades, impedir suas energias ou perturbar seus movimentos (Antunes, Barbosa e Pereira, 2002). Havia interesse no cuidado à saúde mental e a profilaxia era uma meta a ser alcançada.

Em 1908, é fundada a *Sociedade de Higiene Mental* de Connecticut, U.S.A. e, em 1909, cria-se o *Comitê Nacional de Higiene Mental*, cujo primeiro

objetivo era ‘proteger a saúde do público em geral’ (Antunes, Barbosa e Pereira, 2002). Em 1922 se constituiu o *Comitê Internacional de Higiene Mental*, chegando ao Brasil em 1923.

De modo genérico, a denominação higiene mental abarca um campo teórico-prático que inclui a *higiene* e as *práticas assistenciais*. Segundo as autoras Antunes, Barbosa e Pereira (2002), a *Liga Brasileira de Higiene Mental* tinha como objetivo melhorar a assistência aos doentes mentais, através da renovação dos quadros profissionais e dos estabelecimentos psiquiátricos, considerados ineficientes e deteriorados naquela época. No entanto, embora o *movimento de higiene mental* tenha se iniciado na primeira década do século XX, seu impulso ocorre após a Primeira Guerra Mundial. O esforço de reconstrução e reorganização social contribuiu para a pretensão de extensão do cuidado a toda a saúde e do cuidado mental à população como um todo, e não somente ao doente mental. Isso demonstra que a função e intenção do movimento de higiene mental contribuíram para um salto qualitativo às práticas da educação e saúde de forma geral.

Para alguns estudiosos da história da psicoterapia (Bicudo, 1988; Antunes, 2004; Bastos, 1998; Rosa e Olivi, 1994; Brozek e Massimi, 1998; Massimi, 2004; Rodegheri, 2011; Campos e Bernardes, 2005; Teixeira e Nunes, 2001), quando ela esteve voltada à prática da psico-higiene, no início, era predominantemente educativa e corretiva, dessa forma, também um pouco *normativa*. Entendo que a psico-higiene estava voltada a uma mudança na prática e forma de pensar dos profissionais da saúde e educação; a “norma” considerada vigente prevalecia até que novos conceitos se instalassem.

A psicanálise era a prática preponderante no início do século XX e é especialmente por meio dela que a psicoterapia se insere no campo da saúde mental. A psicoterapia estava associada à medicina e a prática psicoterápica tinha o objetivo de, além de curar sintomas, buscar a reestruturação da personalidade e do modo de viver do indivíduo, evitando novas desadaptações. A linha divisória entre a cura e a profilaxia era tênue. Tínhamos uma psicoterapia retificadora e a profilaxia estava diretamente associada à prevenção dos considerados problemas psíquicos (Rodegheri, 2011). Outra característica da ação psicoterápica desse período é que o saber se concentrava no médico ou no psicoterapeuta e ao paciente se designava uma postura de entrega aos cuidados do primeiro, com mais passividade e submissão. Essa visão era centrada no indivíduo e nos fenômenos intrapsíquicos.

Nesse período, Moreno criava as bases do psicodrama. Em 1921 traz a perspectiva do psicodrama focada nas relações interpessoais e na concepção de homem inserido e participativo na sociedade. Temos aqui a distinção entre o foco no intrapsíquico e no inter-relacional, com mudanças significativas na postura do psicoterapeuta. No psicodrama o saber não se concentra mais exclusivamente no psicoterapeuta e o paciente passa a ter postura ativa durante o trabalho. Moreno, nessa época, se destacava por suas ideias e práticas pouco ortodoxas para o período, o que causava certa resistência na comunidade científica em considerar que seu trabalho trazia contribuição para a psiquiatria ou para a psicologia (Marineau, 1992).

De forma geral, a psicoterapia ao longo do século XX era mais genérica e com definições múltiplas. É importante para este trabalho como foi o advento da psicoterapia com crianças e como se desenvolveu no psicodrama.

Picoterapia com crianças: as primeiras contribuições

No início do século XX, a psicanálise era o método preponderante com que até então se praticava a psicoterapia e Freud trabalhava exclusivamente com adultos. Em 1908, a importância da criança aumentou na psicanálise, pois, além de ser uma fonte de dificuldades adultas, ela própria passou a ser vista como um ser analisável. Nesse mesmo ano, Sigmund Freud (1909) tratou, através do pai, o filho de um dos membros de seu '*grupo de estudos da quarta feira*'. A análise do menino Hans, de cinco anos, que havia desenvolvido uma fobia a cavalos, fica como referência de marco inicial na psicanálise infantil e, consequentemente, na psicoterapia infantil.

No ano em que Freud publicou o caso do *Pequeno Hans* (1909), e a análise de criança assumia forma, o movimento da higiene mental estava se desenvolvendo. Criou-se nos Estados Unidos, em 1909, a *Comissão Nacional de Higiene Mental*, e a primeira clínica de orientação infantil foi aberta no país (Rodegheri, 2011). Como já mencionado, essas clínicas desenvolveram uma abordagem de equipe no tratamento das crianças, com psiquiatras, psicólogos e assistentes sociais. O foco do trabalho era na psico-higiene, com orientações profiláticas aos pais e tratamento às crianças.

A primeira referência histórica de uma psicanalista de crianças foi Hermine Van Hug-Hellmuth, já que Freud viu apenas uma vez o menino Hans. Hermine nasceu em 1871 e ingressou na Universidade de Viena em 1897, defendendo uma tese de doutorado em ciências médicas em 1908 (Avellar, 2001). Ela conheceu Freud e frequentava o '*grupo de estudos da quarta feira*'. Seis anos antes de Anna Freud e Melanie Klein, Hermine, em 1915, aplicou as

teorias de Freud no atendimento a crianças e adolescentes e se responsabilizou por uma coluna permanente na revista *Imago*, intitulada “Da verdadeira essência da alma infantil”. Porém, seu nome é pouco citado na literatura, talvez por uma questão familiar que ocorreu na época: ela tornou-se tutora de um sobrinho (com 13 anos na ocasião) que aos 18 anos, em 1924, invadiu sua casa, estrangulando-a depois. Segundo Avellar (2001) que em sua Tese de Doutorado resgata a história de Hermine, diz:

“O assassinato, o processo e a condenação de Rudolf tiveram uma grande repercussão na grande imprensa e no meio psicanalítico, levantando um grande debate acerca da educação psicanalítica da criança, motivado pelo fato de Rudolf, em sua defesa, acusar a tia de tê-lo usado como “cobaia” durante seus estudos” (p. 14).

A despeito disso, Hermine trouxe contribuições importantes à psicanálise e apresentou no Congresso Psicanalítico de Haia, em 1921, o texto: *Da técnica da análise de criança*, na qual tratou temas essenciais e atuais referentes à importância de não se cometerem abusos, de evitar sugestão e garantir a confiança da criança num trabalho psicoterápico. Ela considerava a existência das transferências positiva e negativa e a necessidade de seus manejos para favorecer o trabalho clínico. Além disso, valorizava a utilização do brincar e da ação simbólica como forma de permitir o desvelamento dos sintomas e da problemática da criança.

Nesse mesmo Congresso também estiveram presentes Anna Freud, Melanie Klein, Karen Horney e outros analistas, mas não há referência de que Hermine tenha encontrado interlocutores (Boukobza, 1993).

Em 1924, Anna Freud sucedeu Hermine no Centro de Consultas Pedagógicas do Ambulatório da Sociedade de Viena. E, segundo Boukobza (1993), apesar de ter retomado muitos dos pontos de vista da primeira, Anna

Freud pareceu não ter se sentido em dívida com a antecessora. Ao contrário, Melanie Klein num texto de 1927 (*Colóquio sobre a análise de crianças*) reconheceu o trabalho de Hermine e também lhe fez críticas.

Anna Freud e Melanie Klein

As controvérsias entre Anna Freud e Melanie Klein possibilitaram que a psicanálise da criança ganhasse destaque no meio científico e no seu desenvolvimento. Segundo Abrão (2009), que pesquisou sobre a origem da psicanálise com crianças no Brasil, suas obras são construídas no início, uma contra a outra e estabeleceram ao mesmo tempo oposição e apoio.

Anna Freud nasceu em Viena, em 1895, última dos seis filhos de Sigmund e Martha Freud. Cedo, Anna interessou-se pelo trabalho com crianças, ensinando durante cinco anos em uma escola primária, a mesma em que havia estudado na infância. Foi secretária do pai, assistindo e anotando suas conferências, e passou a ser membro da Sociedade de Psicanálise em 1922. Realizou sua análise com o próprio pai, provavelmente no período entre 1918 e 1922. Dando maior ênfase à psicanálise infantil, publicou em Viena, em 1926, *Introduction to the technique of the analysis of children*, no qual expõe os fundamentos de sua técnica.

Avellar (2001) desenvolveu sua Tese de Doutorado sobre a intervenção e interpretação na abordagem Winnicottiana. Nesse trabalho, faz uma pesquisa sobre alguns marcos históricos da psicanálise da criança, realizando síntese das obras de Melanie Klein, Anna Freud e Hermine von Hug-Hellmuth.

Trago alguns pontos considerados essenciais na obra de Anna Freud sobre psicanálise infantil e assinalados por Avellar:

- a criança não tem consciência de sua patologia nem desejo de curar-se, isto significa que sua situação é diferente da do adulto. É necessário um período preparatório *não analítico*, pois ela não tem capacidade de transferência;
- o tratamento deve ocorrer sob transferência positiva. Ela ainda está ligada aos primeiros objetos de amor e não tem capacidade de fazer uma neurose de transferência. Os pais estão presentes na sua vida e o analista é um novo personagem nessa situação;
- a análise também tem a tarefa pedagógica. O analista deve assumir a orientação da criança para assegurar a conclusão do tratamento, completar o trabalho interno com uma ação exterior;
- ela se utiliza da interpretação de sonhos e dos desenhos produzidos nas sessões de análise. A atividade lúdica na sessão é vista como técnica auxiliar.

Em 1936, na obra *O eu e os mecanismos de defesa*, o interesse central da Autora é o ego e o seu modo de funcionamento diante da angústia. Revisa seu trabalho então, dez anos depois, fazendo algumas modificações em sua técnica (Freud, 1996).

Melanie Klein teve seu primeiro paciente Fritz, de cinco anos e meio de idade, antes de 1920, e escreveu artigos sobre esse trabalho em 1921 e 1923. Inicialmente, ela adotou o método que Freud utilizara com o *Pequeno Hans*, e achou que seria suficiente influenciar a atitude da mãe da criança. Sugeriu que a mãe incentivasse o filho a discutir livremente com elas as várias questões que estavam claramente prejudicando o seu desenvolvimento intelectual. Percebeu

que isso ajudou apenas parcialmente. Ao mesmo tempo, verificou que a criança expressava as suas fantasias e ansiedades principalmente por meio do brinquedo, a partir do qual então, conseguiu interpretar. Assim, descobriu que o brincar correspondia às associações livres do adulto (Klein, 1969; Glenn, 1996).

Em 1925 tratou uma menina muito pequena, Rita, de dois anos e nove meses. Foi uma experiência nova e que foi conduzida na casa da menina. Por meio desse trabalho descobre que as imagos parentais, baseadas na projeção e na introjeção, haviam sido construídas no mundo interno da criança. Estas imagos, para Melanie Klein, formam a base de transferência na análise de crianças e adultos (Glenn, 1996).

Avellar (2001) apresentou pontos centrais da técnica de Melanie Klein, os quais foram escritos em 1927, no texto *Simpósio sobre a análise infantil*. Nesse trabalho, Melanie Klein apresenta ideias que se contrapõem ao trabalho de Anna Freud:

- é possível 'sondar' o complexo de Édipo até suas profundidades no trabalho analítico com crianças;
- não é possível ser analista e educador ao mesmo tempo;
- a proposta do manejo analítico é o da transferência, seja ela positiva ou negativa e de investigá-la até sua fonte (considerada o Édipo);
- o brinquedo é a forma de acesso ao inconsciente da criança, pois só de vez em quando é possível contar com as associações verbais da criança;

- ênfase na interpretação como fator auxiliar na técnica de análise, que tem como função suavizar a ansiedade da criança e ter acesso ao inconsciente e à sua fantasia.

Para ela, o tratamento visava a ajudar o paciente a ficar menos enraizado na posição esquizoparanóide, menos dominado por processos de cisão e, a situar-se mais firmemente no caminho que permitia a integração e aumento da capacidade de se interessar e se relacionar positivamente. Para tal, utilizava o brinquedo como forma de expressão da criança e a interpretação.

Anna Freud (1971) considerava que o processo psicoterápico implicava num esforço do terapeuta em ganhar afeição e cooperação da criança, levando-a a considerar que o papel do analista também era o de um educador. O processo da psicoterapia situava-se na remoção de obstáculos situados no caminho do desenvolvimento normal e os efeitos terapêuticos eram uma mudança no equilíbrio de forças entre id, ego e superego, um aumento de tolerância recíproca para com as finalidades de cada um e, com isso, uma harmonia maior entre eles (Freud, 1971). Interpretava seus sonhos e o brincar era técnica secundária.

Segundo Avellar (2001), a obra de Melanie Klein produziu um maior impacto na psicanálise, introduzindo alguns conceitos que se integraram perfeitamente ao arcabouço teórico da psicanálise, como os conceitos de relações objetais e identificação projetiva. Os processos de análise pressupunham distúrbios sob tratamento: o conflito intrapsíquico como principal agente patogênico e as relações interpessoais consideradas 'defeituosas', ocupavam um lugar secundário na psicoterapia.

Muitos outros analistas da infância surgiram a partir dessas primeiras, tais como Françoise Dolto, Maud Mannoni, Donald Winnicott, Erik Erikson, dentre outros. Porém, não é objetivo deste trabalho discorrer sobre eles, mas sim, deixar clara a influência da psicanálise para o trabalho psicoterápico com crianças e seu desdobramento ao longo da história da psicoterapia.

Psicoterapia no Brasil

As primeiras informações sobre psicoterapia no Brasil datam do início da década de 1900 e trazem temas relacionados a uma psicologia voltada às questões da fisiologia e à psiquiatria médica (Rodegheri, 2011). A atividade de psicoterapia tinha a função de auxiliar nos procedimentos da medicina exclusivamente. Em 1913 criou-se o *Laboratório de Psicologia da Escola Normal* em São Paulo, colocando os alicerces para o desenvolvimento de uma psicologia clínica e, em 1923, com o nascimento da *Liga Brasileira de Higiene Mental*, no Rio de Janeiro, a psicologia começou a se associar à prática da psiquiatria (Castro, 1999).

É na década de 1930, com reformas educacionais promovidas no país sob a rubrica do movimento conhecido como '*Escola Nova*' que se encontraram as condições necessárias para a introdução da psicanálise de crianças, até então única modalidade psicoterápica que aqui se praticava. Nessa mesma época foram criadas *clínicas de orientação infantil*, que eram instituições dos serviços de higiene mental escolar, surgidos no Brasil nessa década cuja finalidade era dar atendimento ao aluno deficitário e pesquisavam as questões etiológicas dos problemas de conduta (Abrão, 2009). Dessa forma, a

psicoterapia com crianças no Brasil teve origem médica e pedagógica. Ao mesmo tempo, seu referencial era a psicanálise, influenciada por analistas brasileiros que fizeram sua formação com Melanie Klein e que tinham vínculo com a prática higienista, enfoque do Brasil até então.

Tal como em outros lugares do mundo, o conceito de saúde mental foi se impondo, a psiquiatria e a psicologia clínica ampliando sua forma de ação e trazendo propostas de trabalho que permitiam um maior alcance à demanda populacional. De 1951 até 1957, tivemos no Brasil uma concentração de experiências e relatos de estudos sobre Psicoterapia de Grupo e Grupos Terapêuticos realizados em hospitais, serviços de assistência aos doentes mentais, centros de estudos especializados e entidades de ensino (Rosa e Olivi, 1994). O Psicodrama já havia chegado ao Brasil nesse período, mas ainda era representado por um pequeno número de psicoterapeutas espalhados pelo país.

Quanto à psicoterapia infantil, em 1953, na *Clínica de Orientação Infantil* do Instituto de Psiquiatria do Rio de Janeiro, instituiu-se a “*Hora do Brinquedo*”, que se baseava nas ideias de Melanie Klein (Genn, 1996). A atividade tinha a função de permitir a livre expressão da criança, considerando que por meio do brinquedo ela estaria liberando conteúdos inconscientes, sendo esse um caminho para a resolução ou prevenção de seus conflitos. A prevalência dos trabalhos no Brasil mantém-se de orientação psicanalista.

O final dos anos de 1950 e início dos de 1960 foram marcados pela implantação de clínicas psicológicas vinculadas a instituições de ensino. Em 24 de agosto de 1959 foi inaugurada pelo Dr. Enzo Azzi, a clínica psicológica do Instituto de Psicologia da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (IPPUC-SP), dirigida por Ana Maria Poppovic. Formada em pedagogia, Ana Maria

Poppovic tinha forte relação com a psicologia que se evidenciava desde o início da década de 1950, ao organizar e fundar a Sociedade Pestalozzi de São Paulo para atendimento a crianças com distúrbios neurológicos em 1953; fundar uma clínica psicológica na mesma instituição, bem como trabalhar como psicóloga num abrigo social com crianças abandonadas. A contribuição de Ana Maria Poppovic para a psicoterapia infantil é importante, pois ela teve grande atividade clínica e de pesquisa voltadas à psicologia e educação ¹.

A clínica do Instituto de Psicologia da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo tornou-se uma referência devido ao seu pioneirismo em atendimento aberto ao público e também se destacou por ter sido o primeiro centro especializado no diagnóstico e tratamento da disfunção cerebral mínima (DCM)². Sob a direção de Ana Maria Poppovic, a clínica tinha avançados equipamentos e material psicotécnico e eram desenvolvidos trabalhos multidisciplinares. Os objetivos da clínica na época eram restritos, mas mantinha três finalidades básicas: ensino, pesquisa e prestação de serviços (Pereira Rojas Boccalandro y Queiroz Pérez-Ramos, 2004).

Em 1960 foi inaugurada a Clínica Psicológica Prof. Durval Marcondes na Faculdade de Filosofia do Departamento de Psicologia Clínica do Instituto de Psicologia. O histórico dessa clínica remonta ao ano de 1953, quando foi criado o primeiro Curso de Especialização em Psicologia Clínica na Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da Universidade de São Paulo, a USP ³. A clínica da

¹ www.pucsp.br/clinica/historia.html

² www.pucsp.br/clinica/clinica/poppovic.html

³ www.usp.br/clinica/historia.html

USP tinha os mesmos objetivos da clínica da PUC, ou seja, ensino, pesquisa e prestação de serviços à comunidade.

A década de 1960 ainda é iniciada com os higienistas que, com base na psicanálise, passaram a dar maior consideração aos primeiros anos de vida, como o período mais importante para o procedimento profilático. Nessa época organizaram-se também clínicas de orientação pré-natal, infantil, orientação de noivos, creches, etc. todas com o intuito de levar aos pais, mestres e a todos os cuidadores de crianças, novas atitudes para com elas (Bicudo, 1988). A psicologia tem o foco na profilaxia e no tratamento dos distúrbios que interferem no desenvolvimento.

Na mesma década de 1960 foram ocorrendo mudanças nas intervenções em Saúde Mental em todo o mundo. Essa década é um marco na história da psicoterapia. Na Itália o movimento antimanicomial foi iniciado e com ele se ampliaram visões de homem e sua relação com o mundo (Rodegheri, 2011). Segundo a pesquisadora, com essa abertura e questionamento aos modelos anteriores de atenção na psiquiatria e psicologia, floresceram outras abordagens que procuravam considerar o homem inserido em seu contexto histórico, buscando compreendê-lo em constante interação e participante da construção social.

No Brasil, em 1962, houve a promulgação da Lei 4.119, a qual regulamenta a Profissão de Psicólogo e os cursos de Psicologia no Brasil (Teixeira e Nunes, 2005). Esse fato estava diretamente associado ao percurso da psicoterapia no país, pois ele abriu a possibilidade de institucionalização da profissão de psicólogo, criando mais condições para a *formação* e exercício da psicoterapia.

Na psicoterapia com crianças algumas intervenções diferentes do modelo psicanalítico tradicional começaram a apontar. Oliveira (1999), pesquisando sobre a psicoterapia psicodinâmica, assinala que em 1967, Lester, um psicoterapeuta brasileiro, propôs uma intervenção no momento de crise, por meio da Psicoterapia Breve de crianças. Esse modelo de intervenção se manteve e em 1969, Proskauer, profissional da psicoterapia breve, propôs um trabalho de ajuda à criança que tinha que lidar com a patologia dos pais e diferenciar-se deles. Historicamente esses dados foram importantes, porque apontaram para uma mudança na psicoterapia, não somente na orientação teórica, mas também em como se compreendia o funcionamento da criança e que tipos de intervenções eram possíveis.

Em 1976, Célia Maria Sodré Dória, a Madre Cristina, fundou o Instituto Sedes Sapientiae, sendo o primeiro instituto brasileiro voltado à formação em psicoterapia. Antes da fundação do instituto, já existia a Clínica Psicológica, mas Madre Cristina assim afirmava:

“O próprio nome – Clínica Psicológica foi um escândalo na época, ninguém sabia o que era. Naturalmente dizíamos que não era para atender nem para prestar serviços, era um local para aprendermos. Então, convidávamos amigos, parentes e fazíamos experiências. Tínhamos parte do diagnóstico, orientação de pais e professores, orientação vocacional e trabalho corretivo de aprendizagem escolar” (1984, p. 42).

O contexto sociopolítico, que permeava o Brasil nos anos 1970, o engajamento de Madre Cristina nas questões humanitárias fizeram com que não se vinculasse o Instituto Sedes Sapientiae ao Ministério da Educação e Cultura do Brasil, o MEC. O objetivo era defender a preservação da liberdade do pensamento e ideologia política do Instituto. Assim, a finalidade do Instituto, a de oferecer melhores condições de desenvolvimento e transformação do ‘Ser

Humano', tanto pelo ensino, quanto por ações sociais ou por lutas políticas permaneceu. A psicoterapia com crianças era um dos trabalhos da clínica e assim continua sendo até a atualidade⁴.

Com o florescimento de outras abordagens e a visão de *homem* sócio-histórico, o psicodrama se ampliou na prática psicoterápica brasileira. E foi entre as décadas de 1970 e 1990 que a inserção da Psicologia no campo da saúde pública no Brasil cresceu, e outras formas de psicoterapia alcançaram destaque.

Em 1970 ocorreu o Congresso de Psicodrama no Masp, que foi um marco histórico do Psicodrama no Brasil (Navarro, 1988; Cesarino, 1999; Pamplona da Costa, 2001; Assunção, 2005; Malaquias, 2007; Motta, 2008; Cepeda, 2010). O aprofundamento das práticas era permeado pelo novo olhar, o compromisso com o histórico, com o social e o político do momento, e é deste prisma que se fundamenta o psicodrama e se faz a psicoterapia psicodramática.

⁴ Madre Cristina. *Psicol. cienc. prof.* [online]. 1984, vol. 4, n.2, pp. 40-43. ISSN 1414-9893.

Capítulo 2

PSICODRAMA

Estrutura da teoria psicodramática

Definida a psicoterapia como uma prática da saúde mental, que ao longo da história foi se transformando e ampliando suas possibilidades, neste capítulo, será apresentado o psicodrama de Jacob Levy Moreno. Ele constrói sua obra ao longo da vida, baseando-se inclusive em experiências pessoais que culminaram no desenvolvimento de conceitos que fundamentam sua teoria: espontaneidade e criatividade.

Ele tem uma compreensão de *Homem* considerada 'otimista', pois refere-se a ele como um "gênio em potencial". O *Homem* moreniano é dotado de aspectos muito positivos, o que não significa que não sofra e não adoça. Constituído por meio de papéis, vive no entrelaçamento de relações sustentadas por uma cultura que contém normas, valores, e que nem sempre lhe são favoráveis. O *Homem* moreniano apresenta seu *Drama*, que contém seus conflitos e contradições. São papéis exigidos e não atuados, forças que se entropem e impedem ou dificultam-lhes o desenvolvimento. A psicoterapia psicodramática busca desvelar esse *Drama* e, para que se compreenda como isso é realizado, apresento primeiro os conceitos da teoria psicodramática que fundamentam a prática psicoterápica.

1. Moreno, sua relação com as crianças e a construção da Teoria Socionômica

Dentre as definições de psicodrama na obra de Moreno, destaco que é um método de ação profunda, lidando com as relações interpessoais e as ideologias particulares, ou ainda, o método que penetra a verdade da alma através da ação (Moreno, 1975). No processo de criação do psicodrama, ele retrata em seu trabalho, ideias de coparticipação, complementaridade e interdependência total entre todos os seres, cada um sendo um cocriador do/no universo (Moreno, 1975, 1983, 1999). Considerar a construção do saber de forma conjunta é um diferencial entre a obra de Moreno e as que têm foco no intrapsíquico. Moreno tem uma história pessoal e profissional impulsionada ao grupo e às relações interpessoais.

A construção de sua obra data desde a juventude e as crianças tiveram importância em sua vida, porque foi por meio delas que foi delineando sua compreensão do Homem e criando os conceitos básicos de sua teoria, tais como espontaneidade e criatividade. No parque público Augarten, em 1908, ele contava-lhes histórias. Seus registros sobre isso retratam especialmente o clima afetivo que permeava esse contato, mas, além disso, percebendo o poder da espontaneidade e da criatividade, ele estava construindo suas ideias (Moreno, 1975). Moreno explorou muitos outros grupos e relações, mas a semente estava plantada e o *locus* do Psicodrama assim estabelecido.

“Atrás do disfarce de contar histórias de fadas às crianças eu estava tentando plantar as sementes de uma pequena revolução criadora... Aos poucos, foi ficando claro para mim que deveria deixar o reino das crianças e passar-me para o mundo, o vasto mundo, mas, é claro, sempre conservando a visão que o trabalho com as crianças tinha me dado. Entretanto, sempre que eu estava numa nova dimensão da vida, as formas que eu tinha visto com os meus olhos naquele mundo virginal permaneciam diante de mim. As crianças eram meus modelos,

tentasse eu prever uma nova ordem das coisas ou criar uma nova forma. Quando entrava numa família, numa escola, numa igreja, num edifício do Parlamento ou em qualquer outra instituição social eu me rebelava. Sabia quão distorcidas nossas instituições tinham se tornado, mas tinha um modelo pronto para substituir os velhos: o modelo da espontaneidade e da criatividade, aprendido com a proximidade que tive com as crianças.” (Moreno, 1985, p. 34)

Foi na infância e adolescência, quando brincava com as crianças, onde se fez contador de histórias nos jardins de Viena, que Moreno viveu mais espontaneamente e verificou pela sua experiência, o alcance da espontaneidade e da criatividade para a superação de conflitos, da dor e da doença (Marineau, 1992). O conceito de *conserva cultural*, compreendida como valores, crenças e normas que norteiam o comportamento da criança e cerceiam sua espontaneidade, também teve seu *locus* nessas experiências. (Moreno, 1975). O que o impulsionava no teatro espontâneo com as crianças era seu desejo de propiciar-lhes a experiência da espontaneidade e criatividade, e foi o que chamou de *revolução criadora*.

Passada essa etapa de sua vida, Moreno continuou investindo em seus trabalhos com grupos e fundou o “Teatro da Espontaneidade”, em 1921, em Viena (Moreno, 1984). Nesse período, sua intenção era diferenciar-se do teatro tradicional, alcançando uma forma de expressão onde o ator se tornasse o autor e criador de sua história no momento da ação, para assim transformá-la (Moreno, 1984). O teatro terapêutico estava nascendo e muito inspirado no teatro espontâneo que foi iniciado com as crianças. Moreno percebeu a eficácia do desempenho de papéis por meio do caso Bárbara e Jorge⁵. Depois desse caso,

⁵ Moreno realizava teatro espontâneo com pacientes, em 1923, em Viena. Bárbara era uma atriz que participava do Teatro da Espontaneidade, famosa por desempenhar papéis doces, românticos e ingênuos. Jorge era um jovem poeta e autor teatral, que se apaixonou por Bárbara. Os dois se casam. Tempos depois, Jorge procura Moreno alegando que Bárbara é uma mulher muito difícil em casa, agressiva e temperamental. Moreno resolve solicitar que Bárbara interprete a partir de então, papéis que lhe possibilitem expressar sua raiva, agressividade e violência. A partir disso ela começa a modificar seu

ele foi transformando o teatro espontâneo em terapêutico até chegar à estrutura de funcionamento que se estabeleceu no meio psicodramático.

Essa estrutura será discutida no capítulo quatro deste trabalho. Moreno realizou seu trabalho prático baseado em três eixos básicos: os contextos, as etapas e os instrumentos. Essa estrutura de funcionamento ficou conhecida no meio psicodramático como o psicodrama 'clássico'. Ela se repete nos psicodramas psicoterápicos, bem como nos socioeducacionais. Com o público adulto ela é seguida sem questionamentos, mas com as crianças há divergências de opinião e prática entre os psicodramatistas.

Porém, antes disso, apresento a visão moreniana de Homem, que é o sujeito da psicoterapia. Quanto ao público infantil, verificaremos que a diferença maior reside no fato de a criança estar em pleno desenvolvimento físico e mental, tendo formas de expressão condizentes com sua faixa etária.

Moreno criou a proposta sicionômica durante o século XX, especialmente na primeira metade, tanto na Áustria quanto nos Estados Unidos, e foi profundamente influenciado pelas duas Grandes Guerras. Compreender o homem em sociedade, suas relações, escolhas e motivações o impulsionaram a trabalhar com grupos sociais. O interesse e dedicação em investigar o indivíduo social em relação culminaram com a criação da Socionomia, ciência que estuda as leis que regem o comportamento social e grupal (Moreno, 1999).

Para fundamentar a psicoterapia psicodramática com criança, apresento a teoria moreniana, discutindo os conceitos básicos do psicodrama: como Moreno concebeu o Homem e seu funcionamento, ou seja, quem é o sujeito da psicoterapia

comportamento com o marido e ele afirma que Bárbara estava mais calma e, quando começava a enfurecer-se, ria e percebia que já tinha representado uma cena semelhante no teatro. Moreno disse: “Analisei o desenvolvimento de seu psicodrama, sessão por sessão, e relatei-lhes a história de sua cura”.

psicodramática, o que o leva ao sofrimento, à demanda psicoterápica e como isso ocorre com o público infantil.

2. Conceitos da Teoria Socionômica – Visão Moreniana de Homem

O indivíduo é um ser social que se constrói na relação com o outro. Moreno o concebeu e estudou por meio de suas relações interpessoais e para investigá-las criou a Socionomia, palavra proveniente do latim *sociu* = companheiro, grupo, e do grego *nomos* = regra, lei. Socionomia, portanto, significa a ciência que se ocupa das leis que regem o comportamento social e grupal (Moreno, 1992).

A Socionomia se divide em três grandes eixos: Sociodinâmica, que estuda o funcionamento e dinâmica das relações interpessoais; Sociometria, que tem o objetivo de medir as relações entre as pessoas; e Sociatria, que constitui a terapêutica das relações sociais. Cada uma delas tem seu método e ocupa-se de determinada área nas relações interpessoais. A Sociodinâmica tem como método o *role playing*, que tal como o nome diz, permite ao indivíduo jogar dramaticamente diversos papéis, possibilitando o resgate de um papel mais espontâneo e criativo (Moreno, 1983).

Quando pensamos em crianças, o *role playing* pode ser utilizado em trabalhos terapêuticos, tanto para crianças pequenas, as pré-escolares, quanto para as maiores. O jogar papéis flui com facilidade e é prazeroso para as crianças. Sendo assim, ele tem sido utilizado no atendimento de crianças que apresentam disfunções ou dificuldades de ordem afetiva. Isso é referido nos artigos sobre psicoterapia com crianças de alguns psicodramatistas (Gonçalves,

1988; Ferrari, 1982; Tassinari, 1990; Petrilli, 2000). Observo na minha prática psicoterápica com crianças que jogar papéis é favorável ao processo terapêutico, propiciando mudanças nas relações interpessoais da criança (Filipini, 2005). Isso é referendado por Wechsler (1998, 1999) que discute o 'jogo' no psicodrama fazendo uma correlação com o construtivismo e demonstrando em sua pesquisa o uso do *role playing* com um grupo de crianças e a importância do jogo na construção da identidade.

A Sociometria tem como método o *teste sociométrico* e o seu objetivo é quantificar as relações pessoais. Moreno desenvolveu este método por meio de intervenções que realizou em instituições como a Comunidade de Hudson, que trabalhava com jovens delinquentes (Moreno, 1975). Por meio do meu trabalho clínico que possibilita ter contato com escolas, posso afirmar que muitas delas utilizam o 'princípio' da Sociometria (escolha, rejeição e indiferença) para reorganizar os grupos de crianças para o ano letivo subsequente. Por fim, a Sociatria, que é a terapêutica, tem como métodos a *psicoterapia de grupo*, o *psicodrama* e o *sociodrama* (Moreno, 1975, 1983, 1984). Todos esses métodos terapêuticos podem ser aplicados à população infantil, de forma privada ou institucional. A psicoterapia de grupo prioriza o tratamento das relações interpessoais inseridas na dinâmica grupal; o psicodrama é o tratamento do indivíduo e do grupo por meio da ação dramática e o sociodrama, o tratamento do grupo enquanto protagonista (Moreno, 1983).

Embasando esses três eixos da Socionomia, Moreno desenvolveu alguns conceitos que foram se delineando e se articulando ao longo de sua obra. Uma questão primordial para a compreensão do homem como um ser social são os fatores *e* (*espontaneidade*) e *t* (*tele*), considerados inatos. Há muitas

definições de espontaneidade, e pesquisando a obra de Moreno, Gonçalves, Wolff e Almeida (1988) a sintetizam como:

“(...) a capacidade de agir de modo” adequado” diante de situações novas, criando uma resposta inédita ou renovadora ou, ainda, transformadora de situações preestabelecidas. (...) Mas é preciso compreender o espírito dos escritos de Moreno: sua proposta primordial é a da adequação e do ajustamento do homem a si mesmo. Nesse sentido, ser espontâneo significa estar presente às situações, configuradas pelas relações afetivas e sociais, procurando transformar seus aspectos insatisfatórios.” (p. 47)

Assim, a criatividade é indissociável da espontaneidade, ou seja, é o fator que permite ao potencial criativo atualizar-se e manifestar-se. A brincadeira infantil é um exemplo da criatividade sendo manifestada livremente. A imaginação da criança é fértil e ela utiliza o seu potencial criativo em diversos momentos do seu cotidiano. Paralelo ao processo espontâneo e criativo, temos outro que se lhe opõe - as conservas culturais, que são objetos, comportamentos, usos e costumes que se mantêm idênticos em uma dada cultura e que podem interferir nesse processo espontâneo/criativo (Moreno, 1992). É comum na sociedade a conserva se ‘naturalizar’ e ser mais importante do que a capacidade de construir conserva. A educação de uma criança implica na presença de conservas culturais e é nesse processo de inserção de normas e valores que se veem desafiadas sua espontaneidade e criatividade.

A descoberta do Homem Espontâneo para Moreno ocorreu por meio de observações e intervenções que realizou com crianças, seja nos Jardins de Viena, com sua filha Regina, do casamento com Florence, sua primeira esposa, ou com seu filho Jonathan, de seu casamento com Zerka Toeman. No entanto, antes disso tudo, ele afirmou:

“Descobri o homem espontâneo pela primeira vez com a idade de quatro anos, quando tentei brincar de Deus, caí e quebrei meu braço direito. Descobri-o novamente quando, aos dezessete anos, fiquei à

frente de um grupo de pessoas. Eu havia preparado um discurso; era um discurso bom e inteligente, mas quando fiquei lá de pé tomei consciência de que não conseguiria proferir nenhuma daquelas coisas boas e educadas que me preparara para dizer. Percebi que seria injusto para o momento e para as pessoas à minha volta se eu não compartilhasse com elas daquele momento e se eu não me expressasse de modo como o exigiam a situação e as necessidades presentes das pessoas ali reunidas. Novamente descobri o homem espontâneo quando comecei a dirigir sessões de role playing e de psicodrama. (...)” (Moreno, 1983, p. 154)

Foi também por meio desse contato com crianças, que Moreno pôde verificar a existência de outro fator, a Tele. A capacidade de percepção da criança vai se desenvolvendo após o nascimento, e isso possibilita que ela distinga objetos materiais e seres humanos como separados dela. A manifestação dessa capacidade vai ocorrendo no processo do seu desenvolvimento. O fator Tele lhe possibilita distinguir essas pessoas e esses objetos, sem distorcer seus aspectos essenciais, ou seja, características e qualidades desse indivíduo ou objeto.

“Tele é definida como um processo emotivo projetado no espaço e no tempo em que podem participar uma, duas ou mais pessoas. É uma experiência de algum fator real na outra pessoa e não uma ficção subjetiva. É, outrossim, uma experiência interpessoal e não o sentimento ou emoção de uma só pessoa. Constitui a base emocional da intuição e da introvisão. Surge dos contatos de pessoa a pessoa e de pessoa a objeto, desde o nível do nascimento em diante, e desenvolve gradualmente o sentido das relações interpessoais. O processo tele é considerado, portanto, o principal fator para determinar-se a posição de um indivíduo no grupo.” (Moreno, 1975, p. 295, rodapé)

Assim, Moreno (1975) esclarece também que a Tele é empatia recíproca, compreendendo a empatia como captação, pela sensibilidade, dos sentimentos e emoções de alguém ou contidas, de alguma forma, em um objeto.

Gonçalves, Wolff e Almeida (1988) complementam:

“É a tendência que o sujeito sente em si mesmo de se “adentrar” no sentimento com o qual toma contato. A palavra vem do grego: em (dentro) e pathos (sentimento). No Dicionário Aurélio, encontramos

uma definição que provavelmente agradaria Moreno, pois lembra claramente a associação com a espontaneidade e com a capacidade de inverter papéis: “Tendência para sentir o que se sentiria caso se estivesse na situação e circunstâncias experimentadas pela outra pessoa”. (p. 49)

Da mesma forma que a presença da Tele favorece uma relação ‘real’, ou saudável entre os indivíduos, no seu oposto ocorre a transferência. Tele é determinante na atração e repulsão entre as pessoas e é por meio dela que podemos “medir” o quanto há empatia por alguém ou por um grupo de pessoas. Perazzo (1994) fez uma revisão sobre o tema e acrescenta:

“(...)ser um fenômeno da interação, viabilizado entre seres humanos; incluir percepção (criticamente), mas não se limitar a ela; abranger mutualidade, complementaridade, coesão, globalidade vivencial e polimorfismo de desempenho de papéis; guardar correlações com posição sociométrica; e até também depender dos processos intrapsíquicos que envolvem qualquer relação.” (p. 52)

Knobel (2004) complementa que tele não tem natureza própria. Ela é um elemento de comunicação invisível que Moreno percebeu por meio dos trabalhos que realizou. Segue afirmando que tele não tem como qualidade o caráter de escolha, rejeição ou indiferença; não tem natureza própria, mas indica um processo que ocorre nos grupos, entre as pessoas, e pode ser percebido apenas a partir de seus efeitos sociais, as mutualidades nas escolhas, a coesão grupal, a expansividade social e afetiva.

Além disso, Fonseca (2000) afirma que tele e transferência não aparecem exclusivamente no *setting* analítico ou psicoterapêutico, podendo ocorrer em outras relações humanas. A característica primordial da transferência é a unilateralidade, embora tanto tele como transferência possam ser vistas como um sistema que o autor denominou como teletransferência. A ideia central desse sistema é compreender teletransferência em conjunto, ou separadamente, como processos que têm níveis de manifestação na relação. Ou seja, existe um

movimento no aparecimento desses fenômenos que se modifica em cada relação.

As relações nas quais a criança está inserida podem ter prevalência da tele ou da transferência, ou, como afirma Fonseca (2000), teletransferência. É um fenômeno mutável e vulnerável às circunstâncias da vida. Um exemplo disso são as situações transitórias na família que podem gerar crises e mudanças sociométricas. O que gera essa crise e mudança são as relações pessoais que ora são rompidas, estabelecidas, transformadas, mas sempre alteradas sociometricamente. Quando há mutualidade nas escolhas, coesão, supomos que o fator tele é um elemento presente e isso auxilia os sujeitos a transitarem de forma mais favorável nesse processo de transformação familiar. E, quando a transferência é a que tem presença maior nessas relações, geram-se situações conflituosas para os envolvidos e as crianças, por vezes, são as protagonistas desse 'drama' familiar.

Havendo preponderância de elementos télicos na relação, pode-se chegar ao *Encontro* moreniano que abrange diferentes esferas da vida. Compreendo que significa estar junto, ter contato, ver e observar, tocar, sentir, participar, ou seja, tornar-se um só. Para Moreno (1999), *Encontro* é um conceito em si, único e insubstituível. Então, tele e transferência são pressupostos de uma relação, ou seja, os dois podem estar presentes, com um ou outro tendo prevalência sobre o mesmo. Considerando que o princípio fundamental subjacente a todas as formas de psicoterapias em psicodrama é o *Encontro*, significa que no processo psicoterápico busca-se uma relação baseada na *Tele* e não a *Transferência*.

Outro conceito essencial na teoria moreniana é o *Momento* (Moreno, 1983), compreendido como uma espécie de curto circuito; vivido como se a duração (tempo cronológico) fosse alterada subitamente e permitisse um destaque para um *instante* que transforma as pessoas envolvidas (Gonçalves, Wolff e Almeida, 1988). Isso é possível quando há o *Encontro* moreniano, ou seja, quando na relação existe a entrega, o compartilhar, a compreensão do outro ao ponto de se alcançar a união. Assim, na psicoterapia psicodramática o tempo presente é privilegiado, sabendo-se que nele as correntes afetivas tais como estão ocorrendo e sendo captadas no *aqui e agora*, carregam toda a história do indivíduo. O passado se faz presente no *Momento* moreniano.

“(...) Mas permite-me salientar, novamente, a posição crucial que o conceito do momento tem em minha teoria da personalidade. Tudo na vida é existencial no “aqui e agora”, hic et nunc. “Meu objetivo é a psicologia do momento, do homem em ação, momento não como parte da História, mas história como parte do momento, sub species momenti” (Moreno, 1931, p. 21) (...) “O momento não é um pedaço da História, mas a história é um pedaço do momento, (...). Vivências impressionantes do passado se exteriorizam de alguma forma nas vivências atuais.” (Moreno, 1999, p. 85)

Assim, na psicoterapia psicodramática, o ‘drama’ trazido, ou seja, o conflito poderá ser representado no ‘aqui e agora’, sem necessariamente conter cenas “pregressas”. As cenas atuais contêm elementos do passado e é isso que também ocorre com as crianças. Mais do que o passado, o ‘aqui e agora’ representa aspectos de sua história e busca-se o *Encontro* na relação terapêutica. Isto significa que numa sessão ela poderá, por meio da ação dramática, trazer seus conflitos, dúvidas, contradições, medos, ou seja, as dificuldades presentes em sua vida. Conteúdos significativos serão trazidos e trabalhados no ‘aqui e agora’ e não importa necessariamente quando se originaram porque são atualizados na cena.

Para compreendermos o conceito *Momento*, outros necessitam ser considerados: os estados *coconsciente* e *coinconsciente*. Eles se referem a vivências, sentimentos, desejos e até fantasias comuns a duas ou mais pessoas e se dão em “estado inconsciente” (Moreno, 1975). Esse estado não é propriedade de um único indivíduo, ele é produzido na relação.

Moreno compreendeu o Homem como um indivíduo espontâneo/criativo e capaz de manter relações télicas. Ao mesmo tempo, esse mesmo sujeito, diante das circunstâncias da sua história, também chamado por Moreno de processo de *matrização*, e da presença das conservas culturais, poderá, ou não, utilizar seu potencial espontâneo e télico nas relações. Com o objetivo de favorecer que o potencial seja experimentado nas relações, Moreno (1999) criou métodos de trabalhos para tal. Esses métodos (Psicodrama, Sociodrama e Psicoterapia de Grupo) pressupõem uma teoria da ação: a ação livre do indivíduo, espontânea. Esta ação espontânea equivale à criação e ao desempenho de papéis que correspondem a modelos próprios de existência, é a busca do que Moreno chamou de *convalidação existencial*. O psicodrama é o caminho pelo qual se dá o tratamento, a terapêutica das relações, e o grande objetivo desse método é alcançar a catarse, ou a catarse de integração para libertar o indivíduo das conservas culturais e resgatar sua espontaneidade.

Segundo Moreno (1975):

“A catarse, como conceito, foi introduzida por Aristóteles. Ele empregou o termo para expressar o efeito peculiar exercido pelo teatro grego sobre os seus espectadores. Na Poética, sustentou que o teatro tende a purificar os espectadores, ao explicitar artisticamente certas emoções que agem como uma espécie de alívio, ou descarga de suas próprias paixões egoístas.” (p. 38)

Moreno percebeu que esse efeito era favorável não só à plateia, mas também aos próprios “atores-produtores”, que criam o drama e ao mesmo tempo

se libertam dele. Quando um ator atua espontaneamente e cria sua própria história, ele está favorecendo que seus conflitos sejam explicitados, vividos no *aqui e agora* e reintegrados na relação. Dessa forma, catarse, espontaneidade e criatividade estão intimamente ligadas.

Na catarse há sensação de alívio, de limpeza, e na catarse de integração, há transformação daquilo que incomodava, pois não é uma 'limpeza' somente, mas a retirada do incômodo em sua essência. Almeida (2006, p. 184) diz: *“Significa abrigar, no contexto dramático, as dimensões vividas e não vividas, dando-lhes nexos e significado, compreendendo-as, integrando-as”*.

Considero que esses conceitos nos possibilitam compreender o Homem moreniano, um ser que se constitui por meio das relações. Também será nas relações que experimentará sua capacidade télica e poderá ter relacionamentos mais télicos ou mais transferenciais. Tudo isso dependerá do fato de estar mais, ou menos livre, para liberar sua espontaneidade e criatividade.

A criança nasce num contexto socioafetivo que poderá ser favorável ou não ao seu desenvolvimento. Alguns fatores estão presentes nesse processo, dentre eles, os seus próprios cuidadores que constituem os sujeitos com os quais irá se relacionar inicialmente e formará o seu *Eu*. Quem são e como estão essas primeiras pessoas com as quais viverá, quais são seus valores e normas de conduta, implicarão nos padrões de relacionamento nos quais a criança está sendo inserida. É inerente à vida a existência das conservas culturais, bem como não ter relações absolutamente télicas. Desta forma, crescer implica em levar em conta esses fatores presentes e todos eles contribuirão para a formação do *Eu*.

Moreno não construiu uma teoria do desenvolvimento, mas descreveu algumas fases do processo de constituição do *Eu*, ao qual chamou de Matriz de Identidade. Ele não acreditava ser necessária uma teoria de desenvolvimento para poder trabalhar psicodramaticamente. O psicodrama tem seu foco no inter-relacional e não no intrapsíquico. O processo de desenvolvimento que será descrito a seguir, tem o objetivo de mostrar como o sujeito vai adquirindo sua identidade por meio das relações, no desenvolvimento de papéis. E esse é um caminho que considero necessário identificar: a criança se constitui por meio dos papéis que representa. E é importante Identificá-los, explorá-los, expandi-los, compreender seus limites, alcance e lugar na sociometria familiar.

Para isso, compreendemos que ela é um ser provido de espontaneidade e criatividade, de capacidade télica e teve esses potenciais mediados pelas conservas culturais. Ela também compartilha consciente e inconscientemente com seus próximos e isso se atualiza no 'aqui e agora' morenianos.

MATRIZ DE IDENTIDADE: a *placenta social* da criança

Uma das críticas que persistem na teoria psicodramática é a de que Moreno não criou uma teoria do desenvolvimento do *EU* e que isso dificulta a compreensão do *Homem* moreniano. Dentre os psicodramatistas, a questão da falta de uma teoria do desenvolvimento é discutida por alguns (Gonçalves, 1988, Petrilli, 2000); a proposta de Matriz de Identidade é ampliada ou correlacionada com outros autores (Fonseca, 1980, 2000; Jardim, 1988; Wechsler, 1998, 1999); referida como processo coletivo e não individual (Tassinari, 1990); e também, considerada desnecessária a existência de uma teoria do desenvolvimento para o psicodrama (Perazzo, 1994; Aguiar, 1998).

Especialmente Jardim (1988) e Wechsler (1998, 1999), ao correlacionarem o trabalho de Moreno com Gesell e Piaget, demonstram que há concordância entre os autores. As características que Moreno atribui a cada fase da Matriz de Identidade são similares aos aspectos trazidos por Gesell e Piaget que especificaram fases do desenvolvimento tanto orgânico, quanto cognitivo e afetivo, não desenvolvidas por Moreno; mas, este abordou aspectos da inter-relação da criança com seu(s) cuidador(es) e o que isso contribui para a formação de sua identidade.

Fonseca (1980) amplia as fases da Matriz de Identidade moreniana, possibilitando compreensão mais específica de suas relações, e traz noções de psicopatologia ao psicodrama. Identifica quando o indivíduo se relaciona apenas com outro, com dois, três, e assim por diante, até alcançar o processo de socialização, chamado por ele de 'circularização'. Sua última contribuição (Fonseca, 2012) foi localizar o 'Ele' no processo de formação da identidade, utilizando conceitos lacanianos. A utilização de outra linha teórica fundamentada no intrapsíquico trouxe à discussão de Fonseca a noção de *falta*, que entendo que Moreno não valorizava como elemento na relação. Não 'valorizar' não equivale a desprezar, invalidar, mas sim, voltar-se para outras questões, tais como expansividade e complementaridade de papéis.

Compreendo que Moreno investiu menos no estudo e desenvolvimento da Matriz de Identidade, exatamente porque não considerava que fosse necessário ao seu trabalho. Ele delineia as fases da Matriz de Identidade para mostrar o que chamou de processo de 'matrização' da criança inserida num contexto social e afetivo, geralmente uma família. A esse contexto ele chama de

‘placenta social’ e contém todos os aspectos culturais, sociais e afetivos que engendram esse núcleo de relações.

Tassinari (1990) escreve em seu artigo:

“É a esse processo de introdução de um novo integrante ao grupo familiar, e conseqüentemente re-acomodação deste, que dou o nome de matrização da identidade, responsável por um estabelecimento de padrão de relacionamento para todo o grupo. Esse padrão constitui o “status nascendi” de um modelo relacional.” (p. 99)

Por isso, a autora se refere a um processo coletivo e não individual, o que está de acordo com a proposta moreniana.

Na mesma linha de pensamento de Tassinari, temos Perazzo (1994) e Aguiar (1998) que não consideram que Moreno construiu ou teve o objetivo de construir uma teoria de desenvolvimento infantil. Os autores são contrários às ideias de Fonseca, que defende que Moreno criou, sim, uma teoria de desenvolvimento e justifica, trazendo fragmentos dos escritos de Moreno. Para Perazzo e Aguiar, o núcleo teórico principal do psicodrama é constituído pela articulação entre Sociometria, Teoria de Papéis e Teoria da Espontaneidade e Criatividade. A defesa dos autores em afirmar que foi intencional a inexistência de uma teoria de desenvolvimento, de personalidade e de uma psicopatologia na obra de Moreno é coerente com o fato de o psicodrama voltar-se para o inter-relacional.

Entendo que Moreno, de fato, não teve o objetivo de construir uma teoria do desenvolvimento, isso muitos outros autores já o tinham feito e ele não discordava necessariamente dos mesmos (vide o exemplo de Gesell e Piaget discutidos por Jardim em 1988 e Wechsler em 1998). Moreno sempre investiu na compreensão da relação, no que ocorre ‘entre’ os indivíduos.

Desta forma, apresento de forma breve, o que Moreno produziu sobre a Matriz de Identidade, que no meu trabalho tem a função de compreender a criança inserida num contexto familiar, seu lugar sociométrico. Como ocorreu esse processo de formação de sua identidade nos dá acesso à concepção de papel para Moreno e esse é um aspecto importante na compreensão do sujeito que vem como emergente terapêutico.

J. L. Moreno – Matriz de Identidade

Para Moreno, o bebê humano é um ‘gênio’ em potencial, ou seja, um ser que nasce provido do que ele chama de *espontaneidade* que lhe possibilita dar uma resposta adequada à situação do nascimento. Mesmo considerando que o bebê humano é um ser que depende de um cuidador para sobreviver, Moreno insistiu na ideia e no foco da resposta positiva que é dada após o nascimento. A fim de adaptar-se ao mundo presente, o bebê deve realizar um rápido ajustamento para que sobreviva, então para o psicodrama, o nascimento é o seu primeiro ato espontâneo (Moreno, 1975).

“Não é um trauma mas o estágio final de um ato para o qual foram requeridos nove meses de preparação. A criança é o ator. Tem de atuar em papéis sem possuir um ego ou personalidade para desempenha-los. Tal como o ator improvisado, cada passo que dá no mundo é novo.” (Moreno, 1975, p.105)

Para Garrido Martín (1984), se Moreno tivesse parado nessa definição, estaria criando uma psicoterapia existencial, mas ele insere o indivíduo numa dimensão maior: a existência do indivíduo se realiza pelo desempenho de um papel na sociedade e esta se insere numa cultura.

O bebê não dispõe de nenhum modelo relacional com o qual possa dar forma aos seus atos; essa resposta tem que ser positiva e sem falhas; pode ser mais ou menos adequada, mas o suficiente para que viva, ou seja, alguma espontaneidade já é necessária no seu primeiro dia de vida (Moreno, 1975). E é esta capacidade de sobrevivência, que também poderia ser considerada como reflexo, instinto, ou mecanismo de autorregulação, como afirma Gesell (1985), para Moreno é um ato espontâneo, a manifestação do fator e.

Essa primeira manifestação básica de espontaneidade do bebê é o seu aquecimento preparatório para o novo ambiente. Para isso, deverá utilizar dispositivos físicos tais como o choro, mobilizando os que estão ao seu redor para atender às suas necessidades de cuidado. Isso significa que nesse processo estão presentes o *arranque físico* do bebê e o *arranque mental* dos seus cuidadores.

“O processo de aquecimento manifesta-se em toda e qualquer expressão do organismo vivo, na medida em que este se esforça no sentido de um ato. Possui uma expressão somática, uma expressão psicológica e uma expressão social. As variedades de sua expressão dependem da diferenciação do organismo e do meio em que ele existe.” (1975, p.106).

Isto significa que a qualquer manifestação do bebê é necessária uma expressão do seu cuidador, ou seja, a prontidão para atender às necessidades do recém-nascido. Esse cuidado é compreendido como uma expressão psicológica, pois inclui a disponibilidade, sensibilidade, ou seja, o afeto que permeia a ação do cuidador. A expressão social é a relação estabelecida entre o cuidador e o bebê. Sempre com o foco no relacional, Moreno traz o conceito de ‘placenta social’ para contextualizar socialmente o bebê desde o seu nascimento.

O bebê vem ocupar então, um espaço físico, psíquico e social na vida dos que o recebem. Ao mesmo tempo ele é recebido por um espaço que podemos chamar de *virtual* que contém aspectos da mesma ordem, ou seja, desde as condições socioeconômicas, geográficas e afetivas que permeiam a vida dessas pessoas que recebem a criança, até todas as expectativas que esse grupo humano carrega sobre o novo membro familiar. Esse contexto constitui o meio no qual ela viverá o processo de ir, aos poucos, se reconhecendo como semelhante aos demais e como um ser único, *idêntico* a si mesmo (Gonçalves, 1988). Dessa forma, Moreno define Matriz de Identidade como a “placenta social da criança, o *locus* em que mergulha suas raízes” (Moreno, 1978, p. 114).

Moreno compreende e distingue a fase do desenvolvimento da criança em dois grandes períodos, aos quais chamou de ‘universos’; o primeiro está dividido em dois tempos, assim nomeados: o da Matriz de Identidade Total Indiferenciada e o período da Identidade Total Diferenciada. No segundo universo temos a fase chamada de Matriz da Brecha entre a Fantasia e Realidade. Cada um desses três períodos compreende uma série de características que vão se somando, transformando e formando a identidade da criança. Tudo isso ocorre por meio da interação com o que a circunda: seus cuidadores, o ambiente e todos os aspectos que os contém. Esse é o seu processo de ‘matrização’ (Moreno, 1975).

Dessa forma, a criança que depende de seus cuidadores, tem que se adaptar a certas normas de convivência que lhe impõem uma maneira de agir, condutas. O modo concreto e encontrado de aceitar essas normas é por meio do desempenho de papéis. Isto significa que Moreno fala da constituição de um *Eu* que se *experimenta*, que interpreta papéis.

Na primeira fase da Matriz de Identidade, a Total Indiferenciada, a criança não diferencia pessoas e objetos, nem fantasia de realidade; o único tempo é o presente; todas as relações são de proximidade. Moreno diz que nessa etapa ela desempenha seus papéis psicossomáticos, ou seja, é por meio de seu corpo e das vivências que tem - comer, dormir, urinar, defecar - que se relaciona com o outro. Deste modo, ele traz os conceitos de zona e foco:

“Toda a zona é o ponto focal de um dispositivo físico de arranque no processo de aquecimento preparatório de um estado espontâneo de realidade, sendo tal estado ou estados componentes na configuração de um “papel”. Cada zona é formada no interesse de uma função indispensável da criança. Por vezes, converte-se na fonte de um dispositivo de arranque – físico ou mental – no processo de aquecimento para um estado espontâneo de realidade. Além de ser uma zona vinculada a um dado organismo, converte-se no lócus nascendi de dispositivos de arranque que a aquecem para objetos e pessoas. Torna-se o ponto focal do próprio ato espontâneo. No nível físico, uma zona nunca está inteiramente separada de cada uma das outras zonas; envolve, em certa medida, todo o organismo, no momento de funcionar.” (Moreno, 1975, p. 108)

Assim, a criança vai exercitando seus papéis psicossomáticos, mediados pelo processo de aquecimento preparatório, visando ainda apenas à dimensão presente, às situações imediatas. A duração do próprio ato é que lhe dá a noção psicológica de tempo. Com a interação das diversas zonas corporais, assegurada pela interação dos processos de aquecimento preparatório, há a possibilidade de unificação das várias áreas do corpo que até então eram experimentadas como partes fragmentadas.

“Portanto, o organismo da criança, que consistia originalmente num dado número de segmentos separados, sobrepostos às várias zonas do organismo, começará a fundi-los em vastas áreas do corpo. (...) A criança começará se identificando ora com uma vasta área do corpo, ora com outra vasta área do corpo, ignorando que, na realidade, elas estão unidas entre si, e distante ainda de descobrir que, algum dia, ele será indicado como proprietário individual de todas elas.” (Moreno, 1978, p. 109)

Segundo Moreno (1978), todo esse processo é uma coação e coexperimentação entre a criança e seu cuidador. E essa relação do bebê com as pessoas e objetos à sua volta são características da matriz de identidade, que lança os alicerces do primeiro processo de aprendizagem emocional da criança. Então, nesse processo de desenvolvimento, a primeira fase consiste em que a outra pessoa é, formalmente, uma parte da criança, é a completa e espontânea identidade.

Essa é uma fase de indiferenciação e a relação da criança com seus cuidadores se dá por meio do que Moreno chamou dos papéis psicossomáticos. Ou seja, ela é um organismo, um corpo indiferenciado que se manifesta e se relaciona por meio das suas necessidades. O conceito de papel psicossomático é discutido e criticado por Mezher (1980), com base nas ideias de Rocheblave-Spenlé (1969), que traz a noção de papel na psicologia social. Mezher propõe a substituição do termo papel psicossomático, por zonas corporais em interação, considerando que são aspectos, partes da criança que estão em relação. Considero pertinente a proposta do Autor, e mais coerente com a fase de indiferenciação em que ela se encontra; o desenvolvimento de papéis implica na interação entre dois indivíduos e a criança ainda não se identifica como tal.

Ainda em relação aos primeiros meses de vida e preocupado em criar uma teoria no psicodrama que abarcasse conceitos da psicopatologia, Rojas-Bermúdez (1970), criou a Teoria do Núcleo do Eu. Ela era apoiada no conceito de papéis psicossomáticos de Moreno e também na teoria da integração de áreas de Pichon-Rivière (1895). Essa teoria procura estabelecer conexão entre o intrapsíquico e o inter-relacional por meio da compreensão da estrutura do Eu

que se articule com a noção de papel concebida por Moreno. Em meu trabalho não utilizo essa teoria, desta forma, não farei referências a ela quando discutir sobre a prática da psicoterapia com crianças.

Retomando as fases da Matriz de Identidade de Moreno - passados alguns meses do nascimento e próximo ao primeiro ano de vida, inicia-se o segundo tempo do Primeiro Universo ou Matriz de Identidade Total Diferenciada ou de Realidade Total.

Assim afirma Moreno (1975):

“na fase primitiva da matriz de identidade, a criança ainda não distingue entre próximo e distante. Mas, gradualmente, o sentido de proximidade e distância vai-se desenvolvendo e a criança começa a ser atraída para pessoas e objetos ou a afastar-se deles. Este é o primeiro reflexo social –indicando o aparecimento do fator tele, e é o núcleo dos subseqüentes padrões de atração-repulsão e das emoções especializadas – por outras palavras, das forças sociais que cercam o indivíduo ulteriormente.” (p. 119)

O fator tele, tal como a espontaneidade, é considerado inato e vai se desenvolvendo conforme a criança diferencia pessoas e objetos, sem distorcer seus aspectos essenciais, características próprias. Moreno (1975) define o fator tele como a capacidade de se perceber de forma objetiva o que ocorre entre as pessoas. Também a define como percepção interna mútua entre dois indivíduos, ou seja, a capacidade de essas pessoas perceberem os sentimentos e expectativas do outro em relação a ela.

“(...) Análoga à unidade biogenética, o gene, a tele pode ser concebida como a unidade sociogenética, facilitando a transmissão de nossa herança social.” (Moreno, 1972, p. 220)

Assim, a tele é um fator importante para o desempenho de papéis, pois ela é responsável pela qualidade dessa relação. Moreno (1975) faz um paralelo

entre tele e transferência e, para ressaltar a importância da tele na relação, destaca algumas qualidades e propriedades. Para ele, tele é um fenômeno primário que atua quase desde o nascimento; origina-se no presente, no aqui e agora, no momento em que duas pessoas se encontram; é um sentimento de mão dupla. Com o surgimento da tele e a capacidade de a criança distinguir pessoas e objetos, inicia-se o processo de desenvolvimento dos papéis sociais e psicodramáticos. Para se inserir no grupo do qual faz parte, a criança interage, joga papéis. A consciência do desempenho de um papel é que lhe oferece a noção da existência de um *Eu*. Disso se origina a afirmação de Moreno: “*o papel é o aspecto tangível do que chamamos eu*” (1992, p.178).

Com essa afirmação, Moreno diz que uma criança só poderá ter consciência do seu *Eu*, se desempenhar papéis. O seu *Eu*, sua identidade, se forma por meio dos papéis. Esses papéis são jogados com seus cuidadores primários e é assim que ela realiza a introjeção da cultura. Logo ao nascer, quando Moreno diz que ela desempenha os papéis psicossomáticos, não distinguindo pessoas, então, há o que ele chama de ‘reciprocidade da identidade’, seguindo para a ‘inversão de identidade’. A criança reconhece aos poucos que a outra parte não é idêntica a ela e este distanciamento aumenta progressivamente, chegando a poder inverter os papéis.

O segundo universo se inicia quando se formam, na criança, dois conjuntos de processos de aquecimento preparatório que vão se organizando: um, de atos de realidade e outro, de atos de fantasia. Se antes ela tinha representado apenas o mundo da realidade total, agora ela tem a capacidade de distingui-los. Nesse momento, a criança já alcançou um amadurecimento que lhe permite relacionar-se com pessoas e objetos reais, ou pessoas e objetos que

ela pode imaginar. Com isso, experimenta o mundo de forma mais ampla, o que lhe possibilita exercitar dois novos ‘cachos’ de papéis, os sociais e os psicodramáticos, os quais se referem ao mundo da realidade e ao mundo da fantasia. Os papéis sociais estão associados, no psicodrama, ao “como é”, e os papéis psicodramáticos, ao “como se”.

Moreno (1975) faz um diagrama onde retrata os três tipos de papéis que são os precursores do *Eu*. Coloca os psicossomáticos num círculo central e outros dois ao redor desse primeiro. Depois dos papéis psicossomáticos temos os sociais, aos quais é atribuído um espaço menor, já que estão menos intensamente desenvolvidos que os psicodramáticos.

“Em termos evolutivos, os papéis psicossomáticos (papel de comedor, eliminador, dormente etc.) surgem primeiro. Os papéis psicodramáticos e sociais desenvolvem-se mais tarde, sendo o predomínio dos papéis psicodramáticos muito mais intenso e acentuado que o dos papéis sociais. Estabelecida a ruptura entre fantasia e realidade, os papéis sociais e psicodramáticos, até então misturados, começam se diferenciando. Os papéis de mãe, filho, filha, professor, etc. são denominados papéis sociais e separados das personificações de coisas imaginadas, tanto reais como irreais. A estes dá-se o nome de papéis psicodramáticos.” (Moreno, 1975, p. 129)

Nesta etapa do desenvolvimento, a criança já reconhece que ela e o outro estão presentes de maneira concomitante, então, ela já pode experimentar tomar o papel do outro. E, em seguida, já pode também haver concomitância na troca de papéis entre a criança e a outra pessoa. Essa é considerada a quinta fase do processo de ‘matrização’ e com ela completa-se o ato de inversão de identidade.

Desempenhar papéis possibilita à criança se reconhecer, alcançar sua identidade. Garrido Martín (1984) demarca algumas características do papel: seus aspectos *cognitivo* e *ativo* ou sua perceptividade e representatividade.

Exatamente por ser *experimentado*, ele tem essas características. O de filho, por exemplo, nasceu da interação cuidador-filho e baseado na complementaridade dos dois, ou seja, papel e contra papel. Essa relação inclui o processo de introjeção da cultura que a criança realizou, na qual seu cuidador é o representante maior. E nessa dimensão individual e cultural do papel, outro atributo se apresenta: os elementos individuais e coletivos são inseparáveis, gerando, assim, duas classes de fatores, seus denominadores comuns e suas diferenças individuais. Então, ser filho ou ser mãe tem uma classe de fatores conhecidos e coletivos, porém, ser determinado filho ou determinada mãe, implica em conhecer intimamente características dessas individualidades.

Outra característica do papel é que ele pode ter comunicação com outro, denominada 'expectação de conduta', a identidade como característica. Ela pode ser, por vezes, exagerada e generalizada, por exemplo, papel de pai semelhante ao de professor, policial. Com isso, cria-se o que Moreno chamou de 'cacho' de papéis. Papéis que mantêm semelhanças de conduta, ação e representação.

Como Moreno (1975) diferenciou os papéis em psicossomáticos, sociais e psicodramáticos, ele os classifica quanto a sua origem, grau de espontaneidade, conteúdo, quantidade, tempo, velocidade, consistência, posição e forma. Quanto à origem, classifica-os como papéis coletivos ou individuais. Os psicossomáticos, ele entende como coletivos, mantendo padrões comuns de resposta; os psicodramáticos e sociais são classificados como papéis individuais, que podem ter características próprias.

Os psicossomáticos têm espontaneidade menor, já que o grau de liberdade de escolha na representação é mínimo. Já os papéis sociais possibilitam alto grau de espontaneidade, levando à criação de papéis. Nos

papéis psicodramáticos o grau de espontaneidade é um pouco menor, possibilitando a representação e imitação de papéis.

Além dessas classificações, Moreno também discute sobre as categorias: tempo, velocidade, consistência, posição e forma. Relaciona-as com a generalização que podemos fazer de determinado papel; o tempo que é necessário para uma pessoa representá-lo; a estabilidade com que alguém o percebe; a força com que esse papel domina a conduta de uma pessoa; e à liberdade ou não com que são percebidos e representados (Moreno, 1975).

Isso leva ao que Moreno afirma quanto ao desenvolvimento de papéis: *role taking*, *role playing* e *role creating*, respectivamente, tomar, jogar e criar papéis. A criança, por exemplo, primeiro toma o papel de filha, depois joga esse papel e finalmente pode criar a partir dele mesmo. Na teoria de papéis de Moreno, o sujeito alcança maior liberdade de ação quando os cria, quando consegue se desprender das conservas culturais e criar a partir delas. É estar inserido numa cultura, fazer parte do sócio e ter individualidade. Essa individualidade é mantida ou resgatada por meio da espontaneidade e criatividade.

Com essa compreensão de sujeito que alcança sua identidade por meio do desempenho de papéis, entendo o trabalho de psicoterapia psicodramática baseado na teoria sociométrica, teoria de papéis e teoria da espontaneidade e criatividade. Ou seja, qual o lugar que o indivíduo ocupa na sua rede de relacionamentos? Que papéis ele desempenha? Como os faz?

Capítulo 3

Psicoterapia Psicodramática com Criança

Neste capítulo abordo o que há na obra de Moreno sobre psicodrama com crianças, cuja grande parte foi realizada com sua esposa Zerka. Em seguida, apresento como o psicodrama com crianças chegou ao Brasil e como tem sido praticado pelos psicodramatistas contemporâneos. A influência da psicanálise deixou uma marca importante na prática da psicoterapia psicodramática com crianças, iniciada na França e importada ao Brasil. Foi nomeada como psicodrama analítico. O chamado psicodrama moreniano tem sido praticado por poucos psicodramatistas e de alguma forma, é possível visualizar a prática do psicodrama com crianças, dividido em, pelo menos, duas frentes: a analítica e a moreniana.

Jacob Levy e Zerka Moreno: contribuições ao psicodrama com crianças

Buscando especificamente produções com crianças nos escritos de Moreno, encontrei um trabalho de 1922 sobre tratamento psicodramático do comportamento neurótico infantil, intitulado *O Método do Psicodrama Simbólico* (Moreno, 1975). Pela data da realização desse trabalho sabe-se que a teoria do Psicodrama ainda estava em plena construção e Moreno buscava formas de desenvolvimento da psicoterapia psicodramática, sem tê-las definido até então.

Em Viena, já funcionava nessa época uma clínica psicodramática que tratava crianças em grupos de doze a vinte, na idade de cinco a dez anos. Infelizmente a experiência dessa clínica não está descrita, salvo o trabalho com Karl, um garoto de cinco anos que tinha acessos de raiva contra sua mãe e que

foi tratado individualmente pelo diretor, egos-auxiliares e no final também com a mãe. Moreno chamou-o de *psicodrama simbólico* porque o princípio do tratamento foi sempre representar a situação traumática central em numerosos ensaios e versões para reduzir a um mínimo a tensão angustiada da criança. As sessões eram planejadas anteriormente com o objetivo de que a cena no palco fosse, em cada detalhe, semelhante à situação real.

Como esse é o único trabalho com crianças, descrito por Moreno, muito se discute sobre ele. Alguns psicodramatistas (Fonseca, 2000; Petrilli, 2000) apontam que Moreno dramatiza, inspirado pela teoria comportamental, buscando *dessensibilizar* a criança, utilizando-se de *interpolação de resistência*⁷(uma técnica psicodramática). O tratamento começou com a representação de personagens simbólicos, rei, rainha e príncipe, culminando com a presença da mãe no palco, no seu papel real. Nesse trabalho ele não aborda a história do vínculo mãe-filho ou da família, ataca somente o sintoma. Compreende que, a despeito da pouca descrição do caso e da semelhança com a teoria comportamental, quando utiliza a dessensibilização progressiva, esse trabalho é uma contribuição importante aos psicodramatistas que trabalham com crianças. Moreno trabalhou a partir da fantasia da criança e na constituição do seu papel de filho. O limite e o alcance desse papel são trabalhados dramaticamente e essa ação é que faz diferença no processo psicoterápico da criança em questão.

Apesar de descrever apenas esse trabalho de psicodrama com crianças numa situação psicoterápica, Moreno trabalhou com vários grupos de crianças, pesquisando aspectos diferentes na população infantil. Interessava-lhe

⁷ “(...) ou através de técnica de “interpolação de resistência”, que nós descrevemos aqui, não se aplica apenas às resistências internas do paciente. Ela se situa no campo dos acontecimentos concretos. Trata-se das resistências entre o indivíduo e seu ou seus parceiros: as resistências interpessoais.” (1999 p.294)

compreender o grupo e seu funcionamento; um grupo de crianças oferecia subsídios para investigar aspectos do desenvolvimento e, usando princípios da sociometria, ele pesquisou a sexualidade (Moreno, 1992), classificando-a por faixas etárias e o comportamento sexual apresentado; verificou ainda, o desempenho de papéis e espontaneidade com outros grupos de crianças, ao qual chamou de teste de papéis e teste de espontaneidade (Moreno, 1992). Seu objetivo era mostrar que o desempenho de papéis favorecia a liberação da espontaneidade e criatividade e que trabalhar com as crianças menos aprisionadas às conservas culturais, era ótima forma de desenvolver seus estudos.

Nas pesquisas sobre o desempenho de papéis, ele e sua esposa Zerka Moreno (1999), fizeram algumas afirmações, tais como:

- é um método que permite à criança 'encontrar' e possivelmente, resolver problemas;
- desempenhar papéis corresponde a um método de adaptação ao mundo. É uma tendência observável em toda a criança por volta dos três anos. A criança o usa para aproximar-se cada vez mais de outros seres vivos, e transformar-se ia nesses outros seres se fosse possível;
- é uma forma de colocar a realidade à prova e de preparar-se para o futuro, em situações esperadas e não esperadas;
- é levada a desempenhar papéis por: assombro e estranheza, ansiedade, medo ou expectativa.

Moreno estava experimentando sua teoria e necessitava explorá-la cada vez mais para dar suporte às suas ideias. Juntamente com sua mulher Zerka Toeman Moreno, iniciou a brincadeira de inverter papéis com seu filho Jonathan de apenas três anos de idade (Moreno, 1983). Há longos relatos sobre esse *treino*, bem como questionamentos de psicodramatistas contemporâneos (Gonçalves, 1988; Wechsler, 1998, 1999; Petrilli, 2000) sobre a possibilidade da inversão em tão tenra idade e até mesmo de se fazer psicodrama terapêutico com crianças pequenas. Também concordo com as autoras citadas, de que a criança pré-escolar não inverte papéis, tal como colocaram Moreno e Zerka. Remetendo-me ao que ele escreveu sobre desempenho de papéis, compreendo que em tão tenra idade, a criança consegue jogar ou imitar papeis, ou seja, *role taking* e *role playing*.

No entanto, considero que a despeito da pequena produção, em seu livro Fundamentos do Psicodrama (1983), publicado originalmente em 1959, apresenta algumas conclusões sobre a *inversão de papéis* que são relevantes para a compreensão de alguns processos da psicoterapia com crianças. No capítulo IV, quarta palestra do livro, intitulada: *A descoberta do homem espontâneo com ênfase especial na técnica da inversão de papéis*, Moreno apresenta hipóteses sobre a importância e alcance da técnica de inversão de papéis e depois as submete à crítica de três importantes profissionais da época: P. A. Sorokin, um russo e professor de sociologia da Universidade de Minnesota e de Harvard; Read Bain, sociólogo americano que trabalhou com pesquisas de comportamento e grande crítico às escalas de mensuração de comportamento; e Jiri Nehnevajsa, professor da universidade de Pittsburgh e de Columbia (Moreno, 1983).

Não pretendo neste trabalho, discutir as críticas desses profissionais, mas sim, trazer algumas das hipóteses elaboradas por Moreno. Ele descreveu vinte e seis ao todo (Moreno, 1983, p.171-174), a partir de sua observação sobre a inversão de papéis e relato, a seguir, aquelas que considero relevantes para o trabalho psicoterápico com crianças. Essa relevância está diretamente associada a minha prática psicoterápica, desta forma, são as que pude observar ao longo da experiência profissional e cujos aspectos serão discutidos no capítulo sobre a estrutura da prática.

“a inversão de papel aumenta a força e a estabilidade do ego da criança” Moreno compreendia o ego como identidade da criança e a possibilidade de inverter papéis com alguém requer esta estabilidade. Para ele, também se aplicava o contrário. Os psicoterapeutas usam a técnica na psicoterapia, ou seja, sempre com o intuito de auxiliar a criança a compreender e lidar com seus contrapapéis, o que traz força e estabilidade para o papel.

“a inversão de papel tende a diminuir a dependência que a criança tem dos pais”
- Se inverter papéis aumenta sua força e estabilidade, a dependência, de fato, tende a diminuir.

“inversões freqüentes de papel por parte da criança com indivíduos de idade e experiências superiores incentivam sua sensibilidade para a vida interior que é mais complexa do que a sua. A fim de poder acompanhar tais pessoas em seu nível interior de papel, que é muito superior ao nível patente de papel, a criança tem que ser inventiva. Torna-se prematuramente habilitada na administração de

relações interpessoais.” Crianças invertem papéis na situação psicoterápica geralmente; quanto mais têm a possibilidade de lidar com suas relações invertendo papéis, melhor sua capacidade relacional.

“a técnica da inversão de papel é tanto mais eficiente quanto mais próximas forem duas pessoas em termos psicológicos, sociais e étnicos; tais como mãe e filho, pai e filho, marido e mulher.” Adentrar-se no outro, inverter, implica em conhecer o outro. Isso se aplica para todos, adultos e crianças.

“a empatia dos terapeutas aumenta com seu treinamento em percepção de papel e em inversão de papel.” O exercício do papel profissional de psicoterapeuta psicodramatista é favorável ao próprio indivíduo, porque jogar papéis é terapêutico, aumenta a sensibilidade e capacidade de percepção.

“quanto mais solidamente estruturadas forem as pessoas que invertem papéis, menos arriscada será a inversão que executam.” Entendo o ‘estruturada’ como capacidade afetiva e cognitiva; isso significa que crianças pequenas, as pré-escolares, não têm capacidade de inversão, bem como adultos com transtornos mentais.

“a inversão de papel é um risco muito maior, às vezes até contra indicada, se o ego de uma pessoa tem uma estruturação mínima e o ego da outra uma estruturação máxima. Uma ilustração deste fato é o tratamento de pacientes psicóticos. (...)” Aqui Moreno confirma o que disse acima.

“a percepção de papel é uma função da inversão de papel.” Sem dúvida, para inverter papéis é necessário ‘poder’ perceber, ter desenvolvida essa capacidade e, concomitantemente, *inverter* ajuda a perceber.

“a inversão de papel é indispensável para a exploração das relações interpessoais e para a pesquisa com pequenos grupos.” A inversão de papéis é uma técnica que pode ser utilizada com o propósito de se fazer psicoterapia, bem como para pesquisas. Na psicoterapia, tanto para crianças escolares (acima de sete anos) (Ferrari, 1982; Gonçalves, 1988; Tassinari, 1990; Petrilli, 2000; Filipini, 2005), quanto para adultos, é uma técnica que auxilia na ‘exploração’ e intervenção nas relações interpessoais. Em pesquisa, a pesquisa ação é um exemplo do uso dessa técnica (Nery e Conceição, 2012).

“todo pai e toda mãe é um ego auxiliar natural, mas destreinado. Para ser o ego auxiliar eficiente de seu próprio filho, todo pai e toda mãe precisa de treinamento profissional. A técnica do ego auxiliar deveria ser aplicada nos casos em que fosse claramente indicado.” Na psicoterapia com crianças, os pais ou outros cuidadores da criança têm a oportunidade de inverter papéis com a criança por meio de sessões orientadas para isso. No capítulo IV deste trabalho apresento, na prática da psicoterapia, um subitem que se refere ao trabalho com pais e as primeiras sessões. A importância de entrar no papel da criança está voltada ao fato de poder compreendê-la melhor, sensibilizar-se, perceber e, conseqüentemente, investir na relação, tornando-a mais favorável.

“se a animação pelo ego auxiliar acontecer excessivamente, poderá excitar a criança de maneira desnecessária. Talvez não seja sempre indicado animar todos os objetos e todos os animais que circundam a criança.” Compreendo que no trabalho psicoterápico isso se refere ao papel do psicoterapeuta quando é ego auxiliar da criança. No contrapapel, é importante que ele (o psicoterapeuta) esteja bem aquecido para que possa jogar o contrapapel com espontaneidade, seguindo o ritmo e movimento da criança.

“a técnica do duplo é a mais importante das terapias para pessoas sozinhas e, por isso, importante para crianças rejeitadas e isoladas. A criança sozinha, do mesmo modo que o paciente esquizofrênico poderá ser permanentemente incapaz de inverter papéis, mas aceitará um duplo.” A técnica do duplo é utilizada para o atendimento de crianças pré-escolares, não por seu isolamento, mas porque elas não têm ainda a capacidade de abstração que lhes permita perceber o outro a ponto de poderem inverter papel com o mesmo (Ferrari, 1985; Gonçalves, 1988; Tassinari, 1990; Petrilli, 2000; Filipini, 2005).

Moreno e Zerka Moreno (1975, 1975a) deixaram essas contribuições ao psicodrama com crianças e, ao serem questionados (Gonçalves, 1988) sobre a validade de se *inverter papéis* em tão tenra idade (o exemplo do filho Jonathan), Zerka Moreno sempre afirmou que é necessário *treinar papéis* sempre. Com pouca produção literária e muito desejo em experimentar o psicodrama com crianças, alguns psicodramatistas brasileiros iniciaram seus trabalhos na década de 1970 e as produções, em forma de artigos, serão relatadas a seguir.

Psicodrama com crianças no Brasil

Apresento breve histórico do psicodrama no Brasil, com o intuito de localizá-lo no processo das psicoterapias que se estabeleciam no país até então. A psicoterapia psicodramática com crianças ainda se encontra num processo de criação e evolução. As principais produções datam da década de 1980 em diante. A forma como realizo meu trabalho será apresentada no próximo capítulo, o que possibilitará que eu o discuta fazendo paralelos com os outros autores.

Há diversas produções sobre a história do psicodrama no Brasil (Navarro, 1988; Cesarino, 1999; Pamplona da Costa, 2001; Assunção, 2005; Malaquias, 2007; Motta, 2008; Cepeda, 2010), todas elas trazendo contribuições importantes para compreensão do significado da inserção dessa nova modalidade psicoterápica no país. Nas décadas de 1950 e 1960 o referencial moreniano estava iniciando em pontos diferentes do Brasil: Alberto Guerreiro Ramos no Rio de Janeiro (Malaquias, 2007) e um trabalho pioneiro com organizações empresariais em Minas Gerais, conduzido por Pierre Weil, todos os trabalhos com o público adulto.

No final da década de 1960 o psicodrama apresentou crescimento e repercussão importantes no meio psiquiátrico e psicológico de São Paulo, exatamente pela abertura no campo da saúde mental e visão de *Homem* inserido num contexto sócio-histórico (Pamplona da Costa, 2001). Realizaram-se cursos de formação na Clínica Enfance, que funcionou de 1967 a 1987 e foi uma das primeiras comunidades terapêuticas do Brasil, na qual um grupo de profissionais desenvolveu pesquisas e chegou a um modelo de atendimento voltado a uma prática humanizada na psiquiatria. Oswaldo Dante Di Loreto, o coordenador da Enfance, dedicou mais de cinquenta anos de sua vida profissional ao estudo da

mente de crianças⁸. Os primeiros psicodramatistas começaram sua formação em São Paulo dentro do Enfance e suas produções foram estudadas pelos que se interessavam (Petrilli, 1990) em trabalhar com crianças.

Até a década de 1960 não existiam psiquiatras da infância no Brasil, conforme relatou Di Loreto em entrevista ao Conselho Regional de Psicologia, CRP. Tínhamos os psicanalistas que iniciavam sua formação nessa área. Naquela época, o Brasil vivia um período difícil, estávamos em pleno regime da ditadura militar e todos que contextualizaram historicamente a chegada do psicodrama, nova modalidade teórica e terapêutica no Brasil (Navarro, 1988; Cezarino, 1999; Costa, 2001; Malaquias, 2007; Motta, 2008; Cepeda, 2010) relataram que a repressão era grande em muitos aspectos da sociedade e um trabalho que permitisse a livre expressão era desejado.

Até esse período alguns congressos internacionais de psicodrama já haviam ocorrido e em 1970, quem sedia o V Congresso Internacional de Psicodrama é o Brasil.

Não se mencionava trabalho de psicodrama com crianças no Brasil até então, e mesmo nesse congresso não foram muitos, apenas quatro, diante da diversidade de trabalhos com o público adulto. O Congresso de 1970 do MASP teve a participação de psicodramatistas do mundo todo; alguns estrangeiros e poucos brasileiros apresentaram os trabalhos com crianças. A programação de atividades continha uma classificação e apresento as que foram contempladas por profissionais direcionados à infância. Relatos Oficiais (conferências): *“Psicodrama com Crianças e Adolescentes”* – J. Echaniz (da Argentina); Atelier de Expressão (demonstrações de diversas técnicas, a cargo de especialistas

⁸ Psi Site do CRP SP

provenientes de diferentes disciplinas): “*Atividades numa Comunidade Terapêutica Infantil*”- S. Novaes (brasileiro); “*Ambientoterapia na Infância*” - M. Pellela (brasileiro); Grupo de Discussão Dramatizada (mesa composta de especialistas convidados como discutidores e dramatização): “*Psicodrama de Crianças*” - Coordenador: N. Jatobá (Brasileiro); mesa: I. Echaniz (Argentino); B. Simões (Português); R. B. Carvalho (Brasileiro); N. Padovan (Argentino); K. Matsumura (Japonês); H. Grunspun (Brasileiro) (Cepeda, 2010).

Por esses dados, observa-se que o número de psicodramatistas brasileiros que trabalhavam com crianças era pequeno. Outros trabalhos, dirigidos à adolescência, orientação familiar, orientação de mães para escolares, também foram apresentados em forma de *Atelier de Psicodrama*, que era uma demonstração de técnicas psicodramáticas aplicadas a trabalhos específicos.

Na década de 1970 o psicodrama com crianças foi se difundindo timidamente em pontos distintos do Brasil. Foi publicado pela Editora Vozes, em 1970, o livro “*Psicodrama com crianças*”, tradução de *Le psychodrame chez l'enfant* do psicanalista Daniel Wildlöcher, publicado em Paris, em 1962. Seu livro tornou-se referência para os brasileiros interessados no tema, além das outras influências psicanalíticas dos franceses Anzieu (1981), Kestenberg e Jeammet (1989), e do argentino Pavlovsky (1981). O argentino Narvaez (1976-77) trabalhava com grupos de crianças pequenas (de 3 a 5 anos) e virou referência para os psicodramatistas voltados à educação.

Em São Paulo, na Sociedade de Psicodrama de São Paulo, SOPSP, criou-se no início dos anos 80 um núcleo de atendimento a crianças, coordenado por Camila S. Gonçalves e Carmen L. Lamas. Os integrantes do Núcleo de Psicodrama com Crianças do Instituto de Psicodrama da SOPSP publicaram em

1988 o livro *Psicodrama com Crianças* que se tornou referência para os jovens psicodramatistas que ingressaram nessa modalidade psicoterápica. Nesse livro apresentam-se o psicodrama analítico, iniciado na França, na década de 1940 - uma síntese da psicanálise e psicodrama, e o psicodrama moreniano, baseado na concepção moreniana de Homem e teoria de papéis (apresentado pelos autores inicialmente como um trabalho no XIV Congresso Nacional de Neurologia, Psiquiatria e Higiene Mental, em Maceió, 1979).

Petrilli (2002) apresentou um trabalho no XIII Congresso Brasileiro de Psicodrama de 2002, intitulado *“Psicodrama com crianças: raízes, transformações e perspectivas”*. Nele, a autora faz um levantamento histórico do psicodrama com crianças no Brasil do qual destaco alguns pontos: em 1978, o Instituto Sedes Sapientiae criou no seu curso de formação em Psicodrama, uma cadeira chamada Psicodramas Especiais, que continha, dentre outros, o módulo Psicodrama com crianças.

Sobre o pequeno número de publicações até a década de 1980, Petrilli enfatiza *“As escassas publicações disponíveis no decorrer dos anos 1980 se referiam ao psicodrama analítico desenvolvido pelos franceses tais como Anzieu (1981), Widlocher (1970), Kestemberg e Jeammet (1989), e o argentino Pavlovsky (1975, 1981). O livro de Zerka Toeman Moreno intitulado Psicodrama de Crianças (Zerka Moreno, 1975), pouco acrescentou em relação aos escritos originais de J. L. Moreno.”* (p. 4-5). Desta forma, a psicanálise era a referência para os primeiros psicodramatistas que trabalharam com crianças, pois na teoria psicodramática os psicoterapeutas não consideravam que houvesse suporte teórico que sustentasse a prática com crianças.

Em 1982, tivemos a primeira publicação brasileira que sistematiza o psicodrama com crianças, com o artigo intitulado “*Psicodrama infantil: teoria e prática*”. Antes da publicação, ele foi apresentado como um trabalho no III Congresso Brasileiro de Psicodrama, por Ferrari e Leão (1982). As autoras apresentaram a experiência de quase dez anos de trabalho conjunto e, apesar de também terem tido influências da psicanálise, propuseram um atendimento clínico para crianças, segundo os princípios socionômicos de Moreno, adaptando as técnicas ao público infantil segundo as possibilidades de cada faixa etária e o amadurecimento sócio-afetivo-cognitivo das crianças.

Ferrari e Leão usam o termo *rematização*, dizendo que o objetivo da psicoterapia é favorecer, incrementar relações verdadeiras, télicas e objetivas entre as pessoas da microssociedade a que pertencem: a família. Para isso, é necessário internalizar o modelo terapêutico que busca a transformação de relações transferenciais em relações télicas. O processo chamado de *rematização* propõe uma reaprendizagem emocional.

Para as autoras, os mecanismos de cura da psicoterapia são: o desenvolvimento de papéis; a possibilidade de inscrição de novas marcas; o insight; a catarse de integração e, por último, a introjeção do modelo relacional. Para compreender a criança, unem os conceitos das etapas da Matriz de Identidade ampliada por Fonseca; a Teoria do Núcleo do Eu de Rojas-Bermúdez; e mais dois outros autores (Vitor Dias e Içami Tiba) que trabalham com referenciais diversos.

Ferrari e Leão (1982) relatam a dinâmica do processo terapêutico, apontando a importância de se verificar como o desenvolvimento da criança ocorreu, que determinantes foram importantes e quais as pessoas significativas.

Afirmam que esses dados auxiliam o psicoterapeuta a ter uma visão completa dos processos internos e externos do desenvolvimento humano, sob o ponto de vista psicodramático.

Para as autoras, o cenário para as crianças mais novas, as pré-escolares, tem a função de incentivar e legalizar a vivência dos papéis de fantasia, por meio dos papéis psicodramáticos e ao mesmo tempo, propiciar a 'revivência' de situações do cotidiano, as quais precisam ser integradas ao seu "eu" ainda em construção. Essa 'revivência' está a serviço de uma primeira diferenciação entre fantasia e realidade, entre papéis imaginários e sociais.

Observa-se que as autoras Ferrari e Leão realizaram uma fusão de vários conceitos do psicodrama. Esse período no Brasil era fortemente influenciado pela psicanálise e parece que elas buscaram no próprio psicodrama, noções e conceitos que pudessem fundamentar a prática. Isso caracteriza o trabalho das psicoterapeutas, a integração de diversos conceitos desenvolvidos pelos psicodramatistas, contemporâneos ou não, ao público infantil.

Foi na década de 1980 então, que o psicodrama com crianças foi se delineando como uma prática psicoterápica possível, seja sob influência da psicanálise, seja baseada nos princípios da teoria socionômica. Especialmente nos congressos, trabalhos de psicodrama com crianças foram apresentados. (Petrilli, 1982, 1984, 1985; Ferrari e Leão, 1982; Peres, 1985; Gonçalves, 1988). Neles, abordavam-se a relação terapêutica, a criança e a família, a integração, ou não, dos modelos psicanalítico e psicodramático. Este é um período que revela a busca dos psicoterapeutas psicodramatistas de crianças brasileiros, em suprir as 'lacunas' do psicodrama. Para a realização de psicodiagnósticos

utilizavam-se de aportes psicanalíticos (Peres, 1985), ou, anos mais tarde, discutia-se a própria realização do psicodiagnóstico como uma prática do psicodrama (Petrilli, 1992), questionando-se a sua necessidade ou não no processo psicoterápico.

A contribuição maior ao psicodrama com crianças nesse período foi a publicação do livro *Psicodrama com crianças*, organizado por Gonçalves (1988), mencionado anteriormente. Ressalto alguns pontos que considero importantes no que se refere ao psicodrama moreniano e ao analítico. No psicodrama moreniano com crianças, Gonçalves e Kaufman consideram que a fase de aquecimento é geralmente inexistente ou de curta duração, pois na criança, especialmente a pré-escolar, o jogo dramático flui sem a necessidade do recurso de aquecimento. Na dramatização utilizam as técnicas da entrevista, diálogo, intervenção coloquial, duplo, inversão de papéis, interpolação de resistência, solilóquio e utilização de fantoches. Mesmo no psicodrama moreniano, busca-se um entendimento simbólico das representações infantis. Para isso, é lançado mão dos conceitos psicanalíticos ou da *função simbólica* na Psicologia Genética de Piaget.

Gonçalves e Kaufman (1988) reconheceram que é difícil distinguir no trabalho com crianças pré-escolares, entre *jogo espontâneo* e *brincadeira* e *dramatização*. Propuseram, dessa forma, chamar de *dramatização* o(s) momento(s) em que são distribuídos papéis.

Gonçalves assinala que as crianças ‘dominam’ facilmente certas técnicas psicodramáticas e que é necessário que o diretor esteja atento para não fortalecer papéis estereotipados da criança ou complementar e satisfazer papéis sádicos ou masoquistas. Nesse aspecto a autora chama a atenção para o

desempenho de papéis do diretor, como ego auxiliar. Acredita que dependendo da dinâmica que é trazida pela criança, o contrapapel pode não ser favorável à criança; ela o associa à transferência ou contratransferência.

Quando a autora se refere ao psicodrama analítico, entende que a psicoterapia *“favorece o brincar, o desenvolvimento da fala e o surgimento da palavra inconsciente, da qual se põe à escuta”* (1988, p. 111). Sua compreensão do brincar baseia-se em Winnicott e afirma:

“Sem dúvida, os estilos terapêuticos, de Moreno e Winnicott, que estão relacionados, respectivamente, com teorias sobre o desenvolvimento de papéis, e sobre o brincar, pressupõem a dependência do fator ambiental.” (p. 114).

Gonçalves discute especialmente a técnica da inversão de papéis e se diz ‘cautelosa’ ao propô-la para crianças, considerando que até mais ou menos os seis anos de idade a criança não dispõe de condições intelectuais de se colocar na perspectiva do outro. Para isso, justifica e se refere à fase de pensamento não reversível da psicologia evolutiva de Piaget.

Ela discute também a dificuldade das crianças em assumirem determinados papéis (considerados “ruins”, como o de vilão ou bandido perseguidor), dizendo que Moreno já havia mencionado isso quando se refere ao desempenho de papéis mais “integrados no *eu*” (Moreno, 1999). Gonçalves questiona a possibilidade do psicodrama terapêutico com crianças pré-escolares por essa questão e pelo fato de verificar que elas não invertem papéis.

Na etapa do aquecimento, Gonçalves (1988) assinala que pode propor jogos ou brincadeiras e utiliza-se de objetos intermediários. O aquecimento é, *“antes de tudo, disposição para captar o clima da outra pessoa.”* (p. 119). Na dramatização reforça a função de *ego auxiliar* do terapeuta nos *papéis de faz de conta*. Critica o entusiasmo do psicodramatista com as “soluções” encontradas

em cena pelo protagonista, ou o desejo de se encontrar um *bom resultado*. Para ela, a *catarse de integração* é o emergir de fantasias e emoções e não a ordenação e rearranjo coerente de uma história.

A autora também discute termos como *tele* e *coinconsciente*, fazendo um paralelo com *contratransferência*, ou seja, fenômenos relacionais por parte do terapeuta, da manifestação inconsciente do cliente. No entanto, adverte novamente sobre a necessidade de evitar a criação de um *contra papel* que atenda predominantemente às necessidades neuróticas do terapeuta. Podemos concluir que Gonçalves realiza seu trabalho, seguindo as etapas do psicodrama: aquecimento, dramatização; utiliza-se das técnicas, mas sua compreensão dos fenômenos psíquicos é baseada na teoria psicanalítica.

Nesse mesmo livro *Psicodrama com crianças: uma psicoterapia possível*, organizado por Gonçalves (1988), que foi a primeira grande produção de psicodrama com crianças no Brasil, Moraes (1988, p.17-31) desenvolveu um estudo sobre o *faz de conta*, e essas reflexões se fundamentaram a partir de uma pesquisa realizada em 1978, que originou sua Dissertação de Mestrado na Universidade de São Paulo (Moraes, 1980 “*O Faz-de-Conta e a Realidade Social da Criança*”). Revendo a literatura, a autora verifica quatro ideias básicas presentes nos estudos que exploram esse tema:

- “ 1) *A criança, no brinquedo, é relativamente livre das pressões ambientais ou impostas pela realidade social.*
- 2) *A criança não distingue ou confunde formas e níveis de realidade.*
- 3) *A criança acredita, é consciente de que, ao brincar, está lidando com uma realidade diferente daquela do cotidiano.*
- 4) *O brinquedo difere da realidade na medida em que há comportamentos que são inibidos numa situação real, mas permitidos se encarados como brinquedo.*” (Moraes, 1988, p. 18)

Para cada uma dessas afirmações, ela se fundamenta em diferentes autores que definem o comportamento do brincar ou o conceito de realidade.

Dentre os autores explorados, encontram-se Winnicott (1972) e Piaget (1945). Morais observa que as crianças mais eficientes na interação social brincam mais de faz de conta, sendo, portanto, sustentável que o treino na representação de papéis é importante para a eficiência comunicativa da criança.

A década de 1990 é marcada por publicações e encontros científicos que focam especificamente na psicoterapia da infância e adolescência. Tassinari (1990) publica o artigo *“Psicodrama com crianças: uma introdução à teoria da prática”*, onde enfatiza os conceitos morenianos na prática psicoterápica com a criança, considerando-a um “porta voz, um receptor e transmissor” dos conflitos. O sujeito do processo psicoterápico para a autora é a família, ou seja, todo o átomo familiar.

O trabalho de Tassinari também traz contribuições importantes ao psicodrama com crianças porque a Autora procura fazer uma sistematização da sua prática, demonstrando que os conceitos morenianos fornecem os necessários subsídios para a fundamentação e compreensão do universo infantil. É uma proximidade maior entre uma postura psicodramática baseada na filosofia do momento, na teoria da espontaneidade criatividade e a estratégia por ela usada. Como o seu sujeito do processo psicoterápico é a família, quando recebe seu cliente, realiza duas ou mais entrevistas com os componentes familiares e depois de ter configurado o átomo familiar, define com quais pessoas vai trabalhar.

Tassinari (1990, 2006) assinala que não faz uso de procedimentos clássicos de psicodiagnóstico e que sua investigação em cada caso, não passa por uma busca de causas ao longo do desenvolvimento infantil, ao contrário de Peres (1985) e Petrilli (1992). Ela faz uma compreensão diagnóstica a partir da

centralização na estrutura e na dinâmica das relações atuais e com a participação dos adultos. Acredita que dessa forma, compromete os adultos na participação do processo terapêutico. Seu trabalho com os pais é dividido em duas partes: uma de orientação e outra de pesquisa e reestruturação de vínculos. Para Tassinari o conceito de matriz de identidade refere-se a um processo coletivo e não individual e não considera que esse conceito seja uma teoria psicodramática do desenvolvimento infantil. Isto significa que, para a Autora, a teoria do desenvolvimento da espontaneidade infantil é rediscutida com a ideia de que tal desenvolvimento ocorre sempre na interação e não como uma evolução individual.

Trabalha na perspectiva de papéis complementares e é a partir dela que se origina a demanda psicoterápica. Para Tassinari, a ‘crise’ que motiva a psicoterapia se instala quando não existe tele numa relação, não há mutualidade de escolhas nem uma ação congruente – há uma divergência a respeito dos objetivos comuns, ou seja, há transferência.

Na sessão, faz tal qual a de adultos, com aquecimento, dramatização e compartilhar. Tassinari refere em seu artigo:

“Cada vez mais, tenho notado que a minha clara explicitação de que trabalharemos fazendo teatro tem facilitado muito a utilização da técnica psicodramática. As próprias crianças já se organizam para assim funcionarem e passam inclusive a deixar de lado alguns brinquedos mais estruturados, como jogos de azar, que ainda tenho como resquícios de uma prática anterior.” (p. 106).

Quando as crianças usam brinquedos para dramatizar, eles funcionam como transmissores que permitem a comunicação por seu intermédio, mantendo a distância entre as pessoas reais. Não usa o termo ‘objeto intermediário’ por

não fazer referência à teoria de Rojas-Bermúdez (1970)⁹. Entende que esse uso diz respeito à necessidade da criança de reforçar nitidamente a delimitação entre papel psicodramático e papel social. A demarcação de contextos não é suficiente naquela situação, obrigando a criança a lançar mão de mais um artifício para a separação de fantasia e realidade.

Quanto à dramatização, afirma: “*quanto mais avançamos na idade cronológica, mais a demarcação entre o imaginado e o real se faz clara e rapidamente, eliminando um cuidado maior que se deve ter quanto menor for a idade*” (p.107). Utiliza como técnicas o *duplo* e o *espelho* que são empregados a partir do contra papel.

Também faz uso da técnica do *solilóquio* à criança pedindo que diga o que determinado personagem representado por ela está pensando ou sentindo. Não há interrupção de cena e dessa forma, discorda de Alegre (1980) que diz não usar essa técnica e a da *imagem*, porque a criança não a compreende. Quanto à *imagem*, diz que concorda com o autor de que ela não é entendida pelas crianças.

Para Tassinari (1990), a técnica da inversão de papel apresenta algumas características peculiares. Cita Joana Lopes, uma pesquisadora da teatralidade brasileira, e se orienta por ela. De 1 a 3 anos a criança realiza imitações; dos 4 aos 6 anos apresenta rudimentos do assumir personagens, durante um espaço de tempo curto; dos 6 aos 8 anos, o “faz de conta” instala-se, permitindo maior elaboração do drama e de suas personificações.

⁹ Objeto intermediário – termo criado por J.G.Rojas-Bermudez para definir um instrumento que reforce as qualidades protetoras do Eu - facilita o desempenho de papéis sociais, pois diminui a sensação de persecutoriedade e focaliza a atenção.

Correlaciona o desempenho de papéis e a capacidade de inversão com o desenvolvimento da espontaneidade na aprendizagem dos papéis na teoria moreniana: *role taking*, *role playing* e *role creating*. Ela nota a presença dessas etapas, mais ou menos acentuadas, numa relação direta com a idade cronológica.

Na etapa final da sessão, o compartilhar, ou *sharing*, como Tassinari (1990) prefere dizer, ocorre fundamentalmente durante a dramatização, a partir dos papéis psicodramáticos, através da troca de ideias, sentimentos e ações. Diz que tecer comentários ao final da sessão psicodramática, sobre “*como ela se desenrolou ou correlacionar situações sociais com as dramaticamente vivida é perfeitamente cabível*” (p. 109). Com esse artigo, Tassinari rompe com as influências psicanalíticas que até então estavam se tornando “tradição” no psicodrama. Seus argumentos de que a teoria moreniana oferece suporte para a prática psicoterápica com crianças não são muito discutidos nem explorados pelos futuros psicodramatistas.

Considero que este artigo de Tassinari seja um marco no trabalho de psicoterapia psicodramática com crianças, no entanto, parece que seu trabalho é menos valorizado, ou pelo menos, pouco divulgado entre os psicodramatistas. Nos anos subsequentes, verifiquei que novamente os autores buscaram outras teorias para cobrir as “lacunas” de Moreno. A insistência na necessidade de uma teoria do desenvolvimento levou alguns a realizarem correlações entre a Matriz de Identidade de Moreno com outras teorias.

Em 1991, ocorreu o I Encontro de Psicodrama da Infância e Adolescência, e Petrilli apresenta seus estudos sobre psicoterapia individual com crianças, propondo uma psicoterapia através da relação, que articula

conhecimentos de psicodrama e da psicologia psicodinâmica. Em 1992, no 8º Congresso Brasileiro de Psicodrama, Soares (1992), apresentou um curso sobre psicodrama com crianças, não publicou o trabalho e ficamos apenas com a referência de sua apresentação. Dois anos depois, ocorre o 2º. Encontro de Psicodrama da Infância e Adolescência, onde apresentei meu primeiro trabalho sobre o tema (Filipini, 1994), enfatizando o vínculo de uma criança portadora da Síndrome de Asperger com o psicoterapeuta psicodramatista. Nesse trabalho apresentei um caso e discuti um período do processo psicoterápico, fazendo referência à matriz de identidade, com aportes de Fonseca (1980), que revisa e amplia o conceito moreniano.

A partir daí, nos congressos brasileiros de psicodrama estiveram presentes, escritos, cursos, workshops, abordando a prática do psicodrama com crianças inseridas em diversas instituições públicas ou privadas. Esses trabalhos têm como referência as contribuições de Gonçalves preponderantemente e após a publicação de Tassinari (1990) e Petrilli (2000), observo uma diversidade maior na forma de compreender e abordar a criança na situação psicoterápica.

Ainda na década de 1990, Andrade (1994) que trabalha com crianças em instituições escolares, fez uma crítica ao psicodrama moreniano apresentado por Kaufman e Gonçalves (1988), que dizem trabalhar sempre na sessão, estimulando “*como se estivessem num teatro*” e comentam sobre a evasão do grupo de crianças na instituição. O Autor apresenta dois estudos que sugerem que as crianças, quando deixadas livres para escolherem, sem qualquer constrangimento ou sugestão, optam por dedicarem-se aos jogos que lhes favoreçam o conhecimento, a pesquisa e o desenvolvimento das interações no

interior do grupo, portanto, no desenvolvimento de vínculos, antes de optarem pela dramatização. Mesmo com essa opção da ‘não dramatização’ sugerida, Andrade considera que faz psicodrama com os grupos de crianças.

Outras publicações e contribuições para o psicodrama com crianças foram os estudos de Wechsler (1997, 1999). A Autora atualiza a Matriz de Identidade de Moreno numa perspectiva construtivista e a correlaciona com a Teoria do Desenvolvimento Cognitivo de Jean Piaget. Culmina com uma proposta de articulação, tratando-a em suas publicações como um processo de construção da identidade sócio-afetivo-cognitiva do indivíduo. Além disso, Wechsler, em sua Tese de Doutorado, discute sobre o *brincar*, trazendo para o conhecimento a classificação de jogos para Piaget (1946) e Caillos (1958). Por meio da classificação desses jogos é possível “visualizar” as mais diversas brincadeiras infantis, o período de desenvolvimento em que elas ocorrem e o objetivo dos mesmos.

Wechsler (1999) traz a classificação de jogos para Piaget: de exercício; simbólico; de regras; e de construção. Para Piaget o jogo é compreendido como um representante da estrutura em curso, desempenhando funções específicas em cada uma das quatro categorias. Fazendo um paralelo com Piaget, a Autora apresenta Caillois que também define quatro categorias de jogos, as quais são determinadas pelas atitudes básicas ou papéis predominantes dos jogadores: de competição; de sorte; de simulacro; e de vertigem.

Diante desses dois autores e as respectivas classificações de jogos, Wechsler discute o *jogo* para Moreno, que é uma forma de jogo especializada, o *Role Playing*, ou jogos de papéis, nos quais os jogadores podem assumir papéis da vida cotidiana e papéis imaginários, que são jogados no *contexto dramático*.

A autora afirma que o *role playing*, por exigir dramaticidade, pode também ser considerado um jogo dramático, mas, é preciso assinalar que o jogo dramático não tem como especificidade o treino de papéis.

O trabalho foi realizado por meio de experimentos: com crianças de 4 a 7 anos e com púberes entre 11 e 14 anos. Com as crianças, o experimento tinha o intuito de averiguar o nível operatório das crianças em relação a quatro conteúdos específicos fornecidos pelas provas operatórias, e por outro, averiguar suas possibilidades de inter-relação, por intermédio do jogo de papéis.

Como para Moreno jogar papéis implica em espontaneidade, Wechsler compreende que para as crianças:

“Os jogos de papéis, aqui entendidos como jogos dramáticos, trabalhados no primeiro experimento, podem ser compreendidos, segundo a classificação de Caillois, como um representante de Simulacro-Mimicry, mais ainda, como um representante de uma Paidia-Mimicry, posto que o teatro organizado ou o desempenho adequado dos papéis seria o próprio Ludus-Mimicry, (...). Da mesma forma, segundo a classificação de Piaget, os jogos dramáticos podem ser considerados jogos simbólicos, uma vez que a idade das crianças não permitiu a atualização da estrutura de regras” (1999, p. 71).

Wechsler (1999) conclui, dentre outras coisas, que a espontaneidade e criatividade são fatores que permeiam a regulação de todo o desenvolvimento, quer seja ele voltado para as construções lógicas, ou para as relações afetivas e sociais. Assim, *jogar*, dentro de um contexto dramático exige espontaneidade e uma resposta dita como operatória. A junção das teorias psicodramática e construtivista oferece subsídios e fundamentação para os psicodramatistas interessados em compreender e classificar o jogo infantil.

Sua contribuição também foi importante ao processo de formação da identidade da criança, quando desenvolveu as fases da matriz de identidade de Moreno com Piaget, abrangendo os aspectos: cognitivo, social e afetivo. Para

Wechsler, a construção da identidade psicossocial do indivíduo conta com três patamares de equilíbrio: o primeiro por volta dos dois anos; o segundo ao redor dos sete (primeira forma de identidade estável); o último ao redor dos quinze anos.

Entre dois e sete anos a criança apresenta características do período pré-operatório (Piaget, 1975), as quais são correspondentes às suas vivências do início da Matriz da Brecha entre Fantasia e Realidade. Nesse período ela vive o ápice de sua fantasia e se esforça para compreender as leis que regem os fenômenos físicos e interindividuais que caracterizam a realidade. Wechsler (1999) assinala em sua pesquisa que nessa etapa do desenvolvimento ocorre o início da socialização e a criança está no auge de seu egocentrismo. Sugere que o profissional da psicologia ou da educação proponham atividades espontâneas nas quais a criança possa realizar jogos simbólicos ou jogos de papéis, desenhos, assim como oferecer materiais que facilitem algumas atividades cognitivas.

“(...) pode ajuda-la no discernimento entre fantasia e realidade, isto é, entre o que ela imagina que seja e o que de fato é. Ajuda-la na conquista de diferenciação entre “ela própria” e o “outro” significa dar possibilidades a ela de tomada de papel, ou seja, ajuda-la a desempenhar tantos papéis quantos os possíveis dentro de seu universo sociocultural” (p.108).

Dos sete aos onze, doze anos, a criança constrói sua primeira forma de identidade estável enquanto construiu as noções objetivas de espaço, tempo e causalidade. Para a autora, a postura “educativa” do profissional é aquela que permite a:

“consolidação de suas novas aquisições, ou seja, de seus conceitos relativos ao entendimento dos fenômenos físicos e interindividuais, assim como aquela que prepare a criança para a compreensão do mundo das possibilidades. Para tal, podem-se propor atividades com material didático que estimule seu raciocínio lógico, assim como

atividades grupais que incentivem a descentração do seu próprio ponto de vista, permitindo que haja uma verdadeira cooperação grupal” (1999, p. 109).

Wechsler acentua que, nesse momento, a técnica da inversão de papel possibilita a vivência pela criança de um “eu” e de um “outro” já diferenciados e que estimular a criança à inversão de papel não só a ajuda na consolidação de sua primeira forma estável de identidade, como também a prepara para posteriores encontros. A criança poderá experimentar outras formas de pensar, sentir e perceber, o que propicia também o desenvolvimento da tele atualizada nas relações de reciprocidade.

Nessa articulação de Moreno com Piaget, Wechsler confirma que as fases da Matriz de Identidade moreniana, apesar de não serem desenvolvidas nem tão especificadas quanto as de Piaget, não se contrapõem. Considero que a diferença mais significativa esteja na ‘insistência’ de Moreno quando afirma que a criança já tem possibilidade de realizar a inversão de papéis após os três anos de idade. Quanto a isso, acredito que Moreno refere-se, tal como traduziu Tassinari (1990), ao desenvolvimento de papéis: role playing, role taking e role creating. Em sua teoria de papéis deixa isso claro e podemos fazer essa associação com a capacidade da criança em jogar, desempenhar e inverter papéis, relacionada a sua idade e capacidade cognitiva.

Petrilli (2000) que já havia apresentado seu trabalho sobre psicodrama com crianças através da relação no início dos anos 1990, publicou um capítulo sobre o tema em 2000, e esta é mais uma contribuição importante para os psicodramatistas que trabalham com crianças.

A autora insere ao psicodrama, seus conhecimentos de psicodinâmica, referencial que adota em sua prática. Petrilli considera que para se empregar o método psicodramático de forma 'clássica', aquecimento, dramatização e compartilhar, o psicodrama com crianças tem que passar por adaptações profundas. Para ela, a criança pequena, o pré-escolar, tem pouco estruturado seu desenvolvimento egóico e suas formas de contato são mais primitivas, necessitando de reconhecimento de sua própria imagem, dos indivíduos que a cercam e de seu lugar nas relações. Afirmar que para isso é necessário técnica e comunicação diversificadas e complexas. Nesse aspecto, não difere das outras psicodramatistas (Ferrari, 1985; Gonçalves, 1988; Tassinari, 1990; Wechsler, 1999) que afirmam que dependendo da faixa etária da criança, alguns elementos do processo psicoterápico se diferenciam.

Diferentemente de Tassinari (1990), Petrilli afirma que *“Treinar papéis é rico, lúdico, corretivo e terapêutico, mas não é suficiente para determinados estados psicopatológicos e de desenvolvimento”* (2000, p. 358). Não que seu foco seja na patologia, mas ela considera a importância do diagnóstico e o processo evolutivo da criança.

Sua proposta é de uma relação horizontal e a experiência interpessoal é o foco de uma psicoterapia através da relação. Distingue a assimetria dos papéis da criança e psicoterapeuta e a função deste último é de *metabolizar* os conflitos, dar continência e promover *devoluções* que possam capacitar a criança a elaborar e retomar seu desenvolvimento. Também intervém ou propõe atividades em sintonia com o movimento psicodinâmico da criança e o momento relacional, cuidando para não sobrepor e privilegiar as necessidades do terapeuta às da criança.

A forma de ação *metabolizadora* de Petrilli (2000) pode ser:

“Pela palavra, podemos citar a interação coloquial, os assinalamentos e as interpretações (instrumentos de intervenção e interação desenvolvidos pela psicoterapia psicanalítica)(...). Por meio da ação, podem ser feitas intervenções nos níveis real, simbólico e imaginário.” (p. 363-364)

A psicanálise, desta forma, é uma influência no trabalho da autora. Ela discute sobre o processo de *inversão de papéis*, afirmando que não seduz, nem induz a criança para o desempenho de papéis; compreende que somente com o processo natural do desenvolvimento e da socialização é que ela estará apta à *inversão de papéis*.

Afirma que *dentro* da psicoterapia individual, a família não faz parte do trabalho, apenas pelo que estiver internalizado pela criança, pois ela não está incluída no *setting* diretamente. Discordando de Tassinari (1990), não considera a criança sempre como emergente dos conflitos familiares, acredita que o contrário também acontece.

Rojas-Bermúdez, um psiquiatra colombiano radicado na Argentina, criou a Teoria do Núcleo do Eu, que não é muito estudada em algumas escolas de formação em psicodrama. No entanto, essa teoria é referência de compreensão do funcionamento das crianças por alguns psicodramatistas (Rebouças, 2008; Barbosa, Khouri, Maçado, Rebouças, 2008). A Teoria do Núcleo do Eu envolve pressupostos da neurologia bem como o desempenho de papéis chamados por Moreno de psicossomáticos.

Costa (2003), psicoterapeuta pernambucana, movida por inquietações dentro da clínica com crianças, desenvolveu sua Dissertação de Mestrado sobre a prática da psicoterapia infantil a partir de três referenciais teóricos. Um deles foi o psicodrama, com foco nas produções de Bermúdez (1985, 1997) e nas de

Ferrari (1983). Seu trabalho consistiu em entrevistar psicoterapeutas, pesquisando com os diferentes autores como está sendo experienciada essa prática clínica, buscando os sentimentos experimentados, obstáculos vivenciados, recursos utilizados, necessidades sentidas e avaliação da especialidade. Observou que há a necessidade de mais pesquisas e produção de literatura no psicodrama.

Considero que os autores citados são os que mais contribuíram para a construção de uma teoria e prática psicoterápica do psicodrama com crianças. Gonçalves e seus colaboradores (1988), bem como Petrilli (2000), mostram como fazem psicodrama com crianças, segundo seus referenciais, sejam eles morenianos ou psicanalíticos. Wechsler (1998, 1999) não fala em processo psicoterápico, mas seu trabalho oferece subsídios para os que buscam sustentação teórica para a prática com crianças, já que o *jogo* é um meio de se desenvolver a psicoterapia. Unir psicodrama com construtivismo foi a possibilidade que a Autora encontrou para realizar essa compreensão.

Destacam-se Ferrari e Leão (1982) e Tassinari (1990), que descrevem seus trabalhos e buscam fundamentá-los por meio da escassa produção “não psicanalítica” com crianças. As autoras oferecem justificativas para cada ação e as fundamentam segundo a teoria do momento, a sociometria e a teoria de papéis. Tassinari é a única autora que utiliza apenas o referencial moreniano.

Neste capítulo apresentei os trabalhos realizados por psicodramatistas que têm diferentes formas de compreender e realizar a prática psicoterápica com crianças no psicodrama. Ênfase aos trabalhos que foram relatados, nos quais distingui duas vertentes: a que tem influência da psicanálise e a que se considera mais moreniana.

A minha prática será relatada no próximo capítulo e procurarei fundamentá-la por meio da teoria socionômica, tal como o fez Tassinari.

A prática do psicodrama tem uma estrutura que se tornou comum no meio psicodramático e ficou conhecida como o psicodrama 'clássico'. Ela obedece a uma estrutura composta de contextos, etapas e instrumentos. Moreno, ao construir a teoria socionômica, trabalhou preponderantemente com grupos e, de forma geral, se refere a eles na construção da socionomia. Entretanto, a psicoterapia psicodramática não se restringe a grupos e neste trabalho, abordo a psicoterapia psicodramática individual com crianças.

Capítulo 4

A Estrutura da Prática da Psicoterapia Psicodramática com Crianças

A história da psicoterapia aponta para uma mudança na sua prática quando voltada ao público infantil. A psicanálise foi pioneira nesse trabalho e, dentre os psicanalistas apresentados, é unânime o fato de que com as crianças, a abordagem técnica é outra. As crianças têm uma forma peculiar de comunicação e o seu brincar na psicanálise, é entendido como forma de expressão do mundo interno, semelhante à associação livre no adulto e que poderá ser interpretado. Outras abordagens foram surgindo após a psicanálise e o arcabouço teórico permite fazer uma diferenciação da psicoterapia com crianças, considerando que elas têm recursos psicológicos e vivem num contexto diferente do adulto.

No caso do psicodrama, que tem uma estrutura teórica fundamentada na teoria socionômica, discutir as ações que se referem à estrutura da prática, implica em considerar seus contextos, etapas e instrumentos. Esses três conceitos constituem uma estrutura que se repete na prática psicodramática, seja na sua modalidade psicoterápica ou socioeducacional.

Como mencionado anteriormente, os contextos, etapas e instrumentos formam um eixo que ficou conhecido como psicodrama 'clássico'. Dessa forma, discutirei nesse capítulo, como se pode realizar a prática da psicoterapia psicodramática com crianças. Para isso, os conceitos morenianos serão apresentados, discutidos, e ilustrados por algumas vinhetas de sessões.

Moreno construiu sua teoria baseado em suas experiências com grupos e os conceitos que criou têm, deste modo, origem no grupo. Entretanto, a prática demonstrada a seguir refere-se a atendimentos individuais, modalidade de atendimento instituída na prática psicoterápica do psicodrama desde seus primórdios. Ressalto que quando é discutida a teoria, geralmente Moreno se refere a grupos, mas minha referência é o atendimento individual.

A psicoterapia com crianças, diferente do trabalho com adultos, implica em algumas etapas que a antecedem. O encaminhamento ou indicação, a sala de atendimento, os materiais e o contrato de trabalho são entendidos como pertencentes ao contexto social e serão discutidos nesse item. Assim, o início do processo psicoterápico inclui sessões com as pessoas cuidadoras, geralmente os pais da criança, ou algum outro familiar.

Os Contextos: Social, Grupal e Dramático

A prática psicodramática tem uma estrutura que se fundamenta na compreensão do Homem inserido num contexto. Moreno (1975) definiu contexto como um encadeamento de vivências privadas e coletivas de sujeitos que se inter-relacionam numa contingência espaço temporal. Fez referência a três contextos, que são distintos entre si: o social, o grupal e o dramático. Caracteriza cada um deles para diferenciar o desempenho de papéis, ou seja, nos contextos social e grupal, são desempenhados os papéis sociais e no contexto dramático, os papéis psicodramáticos. A demarcação de contextos num trabalho de psicodrama é importante porque é o que permite discriminar o “como é” – papéis

sociais, tempo e espaço reais, do “como se” – papéis psicodramáticos, tempo e espaço coconstruídos dramaticamente.

O contexto social se refere à realidade social com suas consequências, o ‘como é’. Tem características culturais, econômicas e políticas; normas e leis regulam os vínculos entre as pessoas (Moreno, 1975; Gonçalves, 1982).

Na psicoterapia com crianças, o contexto social, como na do adulto, inclui a criança, sua família, sua rede de relações mais ampla, cultura, religião, nível socioeconômico, sua história, seu encaminhamento e o motivo que resultou sua vinda ao trabalho psicoterápico. Todos estão em seus papéis sociais: filho, pai, mãe, outros cuidadores, outros membros da família, psicoterapeuta. Tudo o que rodeia a criança em seus vários ambientes. Então, enquanto na psicoterapia com adultos os familiares e outras pessoas significativas da sua vida geralmente são apenas referidos no processo psicoterápico, com as crianças eles estão presentes. Esta presença ora se faz pelo simples fato de serem conduzidos até a psicoterapia, ora pela sua participação no processo.

O contexto grupal é construído pelo próprio grupo ao elaborar regras de funcionamento. Esse contexto existe dentro de tempo e espaço delimitados e possui uma dinâmica específica que permeia as relações entre os seus componentes (Moreno, 1975; Gonçalves, 1982). Enquanto o contexto social detém regras e valores de funcionamento mais rígidos, o contexto grupal é mais tolerante e permissivo, abrindo espaço para o ajustamento destas regras. Ainda se refere ao ‘como é’, mas algumas das regras sociais podem ser questionadas. Por exemplo, na sessão psicoterápica é possível falar palavrão, mandar no adulto, etc.

Na psicoterapia psicodramática individual, o grupo é constituído pela criança e o psicoterapeuta. À medida que adentram a sala de psicoterapia e o trabalho vai se efetivando, o contexto grupal se estabelece. Quando os cuidadores da criança participam de uma sessão psicoterápica, o grupo é constituído por esses membros também. O objetivo comum dos indivíduos ali reunidos é o trabalho psicoterápico. Todos mantêm seu papel social e a criança e seus cuidadores incluem mais um papel nesse momento: clientes de psicoterapia. Com os adultos, a presença de outros indivíduos geralmente é dispensável, ele procura a psicoterapia por seu desejo ou necessidade e é o responsável por ela. Incluir outros indivíduos num processo psicoterápico, implica em ter um contrato de trabalho que preveja isso. Uma questão importante é a do sigilo. É contratado com a criança que haverá sigilo em relação ao processo psicoterápico. Ao mesmo tempo, os cuidadores têm participação ativa no processo e com eles são trabalhados elementos significativos do processo da psicoterapia. Dessa forma, o sigilo existe tal qual a psicoterapia de adultos, porém, os cuidadores relatam acontecimentos importantes do cotidiano familiar que são refletidos junto aos temas que surgem na psicoterapia da criança.

O contexto dramático é delimitado pelo “como se” que possibilita que fantasias sejam acolhidas e trabalhadas dramaticamente. Passado e futuro se fundem no “aqui e agora”, ou seja, o “como se” é construído pelo tempo e espaço subjetivos, onde as regras sociais podem ser questionadas, quebradas ou alteradas, e novas regras podem ser acordadas.

Na díade criança e psicoterapeuta durante o processo psicoterápico, há um movimento de entrada e saída do contexto grupal para o dramático e vice

versa. Isso ocorre porque a criança transita com liberdade entre o “como se” e o “como é”. E, por vezes, uma cena pode ser interrompida, havendo um retorno ao contexto grupal. Isso também ocorre na psicoterapia com adultos, porém, está mais associada ao *aquecimento*. Um adulto quando aquecido para o papel psicodramático, tende a se manter no contexto dramático porque compreende que está no ‘como se’ e que o que faz tem uma função psicoterápica. A criança, especialmente as menores, as pré-escolares, jogam papéis no ‘como se’ porque gostam e são *aquecidas* para tal. No entanto, a discriminação de que isso faz parte do processo psicoterápico não existe necessariamente; ela não possui recurso psicológico para tal. As crianças não estão preocupadas em “colaborar” com o psicoterapeuta no sentido de permanecerem no ‘como se’ para que a cena dramática flua.

É comum estabelecermos um código com a criança que esclarece essas entradas e saídas; por exemplo, um estalar de dedos, uma palma, que demarquem “a história começou”. Ao mesmo tempo, um outro código que represente uma rápida ‘saída’, ou um ‘tempo’ na história. Esse código muitas vezes se efetua por meio do gesto manual de *tempo!*, semelhante aos jogos esportivos. Rapidamente as crianças apreendem esses sinais e os utilizam com frequência e tranquilidade. Usam o *tempo!* para interromper uma cena quando consideram que o terapeuta, no papel de ego auxiliar, não está desempenhando seu papel psicodramático como ela considera adequado. Uma criança disse: “*Você está fazendo tudo errado, não é assim, tem que ser mais bravo!*”; outras: “*A história não é assim, tem que dormir agora...*”, “*para, que agora eles vão para outro lugar*”, marcando a direção da cena; “*Eu não faria isso na realidade!*”, confirmando que o desempenho de papel psicodramático permite que ela realize

coisas que só são possíveis no “como se”. Essas demarcações também têm um caráter terapêutico de poder auxiliar a criança a separar internamente os contextos.

Dessa forma, os contextos estão presentes no processo psicoterápico de crianças e adultos. As diferenças são pequenas e incluem principalmente a presença de outras pessoas no processo psicoterápico das crianças. Os contextos social e grupal da psicoterapia com crianças implicam em considerar que esses cuidadores não são apenas referidos como rede socioafetiva, eles têm presença no processo, bem como estabelecem as regras de funcionamento junto com psicoterapeuta e criança. Por exemplo, o horário da sessão, os honorários, sua história de vida e as informações significativas do cotidiano que não são relatadas pela criança.

No contexto dramático, o trabalho com crianças se diferencia do público adulto no transitar com mais liberdade entre o dramático e o grupal. O adulto depois de aquecido para o papel psicodramático tende a assim permanecer em cena. E quando há necessidade de retomar o papel social no contexto grupal, ele o faz sem que o diretor de cena precise usar algum outro mecanismo que não seja o verbal. Os pré-escolares já discriminam o ‘como se’ do ‘como é’, ou seja, já alcançaram a possibilidade de discernir fantasia de realidade. Entretanto, tudo isso está em processo e elas estão desenvolvendo recursos psicológicos que as auxiliem cada vez mais nessa discriminação. A demarcação de contextos realizada pelo psicoterapeuta favorece essa diferenciação.

No Contexto Social:

Apresento neste item algumas etapas do trabalho psicoterápico com crianças que antecedem o início do processo psicoterápico, mas que não se referem às Etapas de uma sessão psicoterápica.

Na psicoterapia com crianças, essas etapas pertencem ao contexto social. Isso porque nesse caso, diferente da dos adultos, não há uma motivação e um movimento individual para a procura por esse tipo de intervenção. Geralmente é a família quem decide a necessidade desse trabalho e a vinda da criança é compulsória. Movidos por dificuldades de ordem diversa, motivados ou encaminhados por outros profissionais da saúde ou educação, esses cuidadores se preparam no contexto social para o início do trabalho psicoterápico.

Considero que fazem parte do contexto social, a indicação da criança, a sala de atendimento, o contrato de trabalho. Esses aspectos estão presentes em qualquer processo psicoterápico e relato a seguir, algumas considerações, demarcando suas especificidades no trabalho com crianças.

1. Indicação

As questões que levam um indivíduo a procurar psicoterapia são variadas e características da época em que vivemos, ou até mesmo atemporais, universais e inerentes à vida. Necessitar de ajuda faz parte do nosso contexto de vida e da história da humanidade (Myra y López, 1967; Costa, 2003).

Geralmente os motivos que originaram uma indicação psicoterápica, ou as 'queixas' apresentadas, são de ordem emocional, comportamental, neurológica, educacional, familiar e social. Essas questões não se diferenciam,

necessariamente, para os adultos, mas podemos pensar que para as crianças, o fato de estarem inseridas num contexto socioafetivo em que ocupam um lugar sociométrico de maior dependência ou cuidado, pode gerar questões afetivas específicas. Mudanças ocorreram na sociedade em geral e, conseqüentemente, puderam gerar dificuldades também, como a ansiedade por conquistas profissionais, afetivas e financeiras que as famílias enfrentam.

Por sua vez, a família contemporânea traz demandas específicas às crianças, seja no aspecto da separação parental, nas demais uniões conjugais e as implicações que isso acarreta para a família como um todo. Essas demandas não são necessariamente de ordem psicoterápica (Souza, 1995, 1997, 2000, 2006; Filipini, 2003), mas a psicoterapia pode ser uma intervenção de ajuda nesse período de transição familiar, auxiliando-as a identificarem os sentimentos que emergem, bem como desenvolvendo recursos para lidarem com eles.

A psicoterapia psicodramática com crianças já teve sua indicação somente a partir do 11º ano (puberdade e adolescência), pelo psiquiatra francês Chazaud (1974), baseado no psicanalista Widlöcher (1970). O autor afirmou que é frequente uma grande inibição nas crianças, mostrando-se incapazes de propor um tema, ficando irritadas ou desatentas. Somente maiores teriam a possibilidade de trazer cenas e dramatizá-las. Porém, os psicodramatistas brasileiros contemporâneos, atenderam crianças de todas as faixas etárias.

Na literatura de psicodrama os autores relatam que atenderam crianças com conflitos e/ou distúrbios emocionais por meio da psicoterapia psicodramática (Alegre, 1980; Gonçalves, 1988; Filipini, 2005b, 2005c; Petrilli,

2000, Tassinari, 1990; Ferrari e Leão, 1982); dificuldades de aprendizagem e retardo mental (Narvaez, 1976-77; Andrade, 1996, 1997, 1999; Soares, 1986); transtornos mentais específicos, tais como TDAH – Transtorno do Déficit de Atenção e Hiperatividade (Boccardo, 2011). Os autores consideram que o jogo dramático e o desempenho de papéis, auxiliam as crianças no enfrentamento de suas dificuldades e limitações, e as auxiliam no desenvolvimento de recursos para lidar com essa demanda. Compreendem que a criança pré-escolar se manifesta espontaneamente por meio do jogo dramático, o que não acontece necessariamente com as maiores, que devem ser aquecidas para tal. Dessa forma, diferentemente de Chazaud (1974), os psicodramatistas contemporâneos trabalham também com crianças pré-escolares e utilizam formas diversas desse ‘fazer psicodrama’, tal como o psicodrama analítico (Gonçalves, 1988), psicodrama através da relação (Petrilli, 2000), baseado no Núcleo do Eu de Bermúdez (Rebouças, 2008), psicodrama moreniano e com outras contribuições de psicodramatistas contemporâneos (Ferrari, 1985); psicodrama moreniano (Tassinari, 1990).

Como relatado no capítulo anterior, as contribuições que considero mais significativas para a psicoterapia, referem-se a alguns autores que foram mencionados.

2. A sala de atendimento e os materiais

A sala de atendimento deve possibilitar trânsito livre razoável para a criança, ou conter móveis facilmente removíveis, ou pelo menos que possam ser integrados numa produção dramática. Os materiais utilizados são brinquedos de uso comum, alguns mais outros menos estruturados; casinha; castelo; família de

bonecos; bichos em geral, fantoches; alguns jogos; material gráfico e de artes plásticas em geral (papel, canetas, lápis, giz de cera, cola, fita adesiva, tesoura, barbante, etc.); e principalmente, máscaras e utensílios de fantasia (capas, chapéus, lenços, tecidos de cores variadas, objetos de adorno...). Esse material fica disponível para a criança, mas não significa que será usado por ela; não fica necessariamente exposto, ao contrário, a criança é apresentada à sala e ao que ela contém, seu movimento é livre para aproximar-se de um armário que armazena brinquedos, ou não.

A função principal do brinquedo é de aquecimento, tanto para aquecê-la para o papel dramático, quanto para mantê-la aquecida durante a dramatização. Os ‘acessórios’ que compõem um personagem ajudam-na a manter-se aquecida, bem como ao ego auxiliar. Os jogos, construções e desenhos, além da função de aquecimento, podem também assemelhar-se ao que Wechsler (1999) refere, possibilitando à criança expressar e desenvolver capacidades condizentes com sua condição socioafetivo-cognitiva. Dessa forma, eles estão sempre inseridos num projeto dramático e a ação dramática dar-se-á por meio do jogo de papéis ou a dramatização, do jogo em si, do desenho, da construção de um jogo, etc.

Para Gonçalves e Kauffman (1988) a utilização do material segue o mesmo padrão descrito por Alegre (1982), onde o brinquedo pode ser utilizado como aquecimento; como objeto intermediário; como parte da dramatização; e como parte da dramatização com personagens “reais”. Gonçalves (1988) usa o brinquedo para “marcar” no espaço dramático o lugar do personagem e também serve para representá-la, quando o protagonista *“exerce alguma ação sobre esta, que não pode ser realizada com (ou contra) o ego auxiliar”* (p. 78). Tassinari

(1990) diferentemente dos autores acima citados, diz que os brinquedos funcionam como 'transmissores' que permitem a comunicação por seu intermédio, mantendo a distância entre as pessoas reais. Não usa o termo 'objeto intermediário', mas considera que as crianças fazem uso dele quando ainda necessitam demarcar melhor os contextos. Petrilli (2000) também faz uso de brinquedos como intermediário da relação e como objeto simbólico.

Verifica-se então que os psicodramatistas contemporâneos utilizam-se de brinquedos com funções diversas. Do simbólico, tal como na psicanálise; como objeto intermediário, como definiu Rojas-Bermúdez e principalmente como aquecimento para a ação. No psicodrama analítico o brinquedo pode ser interpretado, mas no moreniano, não. Ele poderá estar presente na sessão, e independentemente do uso que a criança faz, o foco e a compreensão estarão na relação. Ou seja, sempre voltado ao papel que a criança assume, quando com o brinquedo e o seu contrapapel.

Um exemplo: *Duas irmãs, de 6 e 7 anos, numa sessão vincular, querem brincar de massinha de modelar. Elas constroem uma cidade de ursos. Nessa cidade estão sua família, que é composta por elas, seus pais e os respectivos namorados, avós e empregada. A mais nova faz uma espécie de barco, onde coloca todos os seus entes queridos. A mais velha, ao contrário, faz um grande arco-íris e se coloca em cima dele. Conforme vão construindo os ursos e a cidade, uma história vai sendo narrada e contém elementos dos vínculos presentes; da disputa entre elas; das necessidades afetivas de cada uma; do lugar sociométrico que cada uma ocupa nessa família; de como percebem e se relacionam com cada membro da família (pai e namorada; mãe e namorado; avós).*

O brinquedo, inicialmente massinhas que viram ursos e outros objetos foram instrumentos, ou transmissores (como Tassinari define) que intermedeiam a relação; também tiveram a função de aquecer as crianças para a construção da história e papel psicodramático. Além disso, cada objeto construído por elas tinha uma função representativa na *cidade* e na história, porém, não foram interpretados, mas sim, incluídos na ação dramática. Eles faziam parte do cenário que as aquecia e auxiliava na construção do *drama* a ser apresentado e representado.

3. O contrato de trabalho

Na literatura do psicodrama com crianças, o contrato de trabalho não é referido por todos. Os autores (Gonçalves, 1988; Tassinari, 1990; Petrilli, 2000) abordam o trabalho com os pais, mas não necessariamente o descrevem como 'contrato de trabalho'.

Com os pais

Para qualquer faixa etária, realizo o primeiro contato com os pais ou responsáveis pela criança, com o objetivo de, além de colher dados sobre a criança, conhecer o casal de pais ou essa(s) outra(s) pessoa(s) que participa(m) da vida da criança, ou seja, parte do seu átomo social. Saber o que as preocupa, que percurso realizaram até chegar à psicoterapia, o porquê desse tipo de trabalho são perguntas que percorrerão esse primeiro contato.

O contrato de trabalho é feito com os responsáveis quanto aos horários da sessão, sua duração (geralmente de 50 a 60 minutos para o trabalho individual e de 1:30 h. para grupo), sua frequência, honorários, participação da família no trabalho e necessidade de algum outro encaminhamento (pediatra, neurologista, psiquiatra, fonoaudiólogo, psicopedagogo, etc). Esses encaminhamentos baseiam-se em conhecimentos que o psicoterapeuta obtém em relação à criança com seus cuidadores e dos primeiros encontros com ela.

Moreno não construiu uma teoria de desenvolvimento nem de psicopatologia. Como dissemos anteriormente, ele não considerava necessários esses conhecimentos para realizar o psicodrama, pois o seu foco estava no inter-relacional. No entanto, Moreno era médico e o seu saber médico estava presente no trabalho psicodramático. Considero que esses conhecimentos anteriores, pertencem à psicologia e dão suporte ao papel de psicoterapeuta, independentemente da linha teórica na qual se baseia. Por isso, esses aspectos pertencem a uma etapa que precede o processo psicoterápico propriamente dito. Isto significa que um psicoterapeuta de crianças deve ser um conhecedor de desenvolvimento normal e dos transtornos do mesmo, conhecimentos obtidos da psicologia. A compreensão e o uso que fará deles é que pode se diferenciar nas diferentes abordagens teóricas. No psicodrama o *homem* se constitui por meio das relações e nosso foco estará sempre no inter-relacional.

Além da primeira sessão de atendimento com os pais, é realizado um contrato verbal, no qual é acordado que eles comparecerão periodicamente para sessões de orientação ou o que chamamos de sessões vinculares – pais-filho, ou pais-filhos (com a presença de irmãos), ou com a presença de outras pessoas significativas para a criança (avós, babás, amigos, tios, etc.). O objetivo é o de

possibilitar o desenvolvimento de recursos que possam ajudar a criança nas suas interpelações, o que incluirá sociometria e papéis.

Conhecer a configuração sociométrica da família, o lugar que cada um ocupa nessa rede de relações e os papéis que são jogados, oferece subsídios ao psicoterapeuta quanto à matriz relacional da criança. No psicodrama a noção de *matriz* está sempre associada às de *lócus* (onde) e de *status nascendi* (quando). Isto significa que os fenômenos psíquicos ocorrem em um espaço e tempo determinados e a partir de um movimento relacional que se organiza num *modus operandi* emocional (como). Essas relações são construídas pelas pessoas que participam da mesma família, do mesmo grupo social ou da mesma cultura (Knobel, 2005). A *matriz* relacional passa a ser chamada de *matriz de identidade* quando descreve o processo de aprendizado emocional via relacionamentos focados em alguns papéis e contrapapéis. Como vimos anteriormente, a *matriz de identidade* da criança é composta por essas primeiras relações no âmbito da família (*lócus*), num espaço e tempo determinados (*status nascendi*), com características próprias (*modus operandi*). Os primeiros papéis sociais da criança são construídos nessas relações e a psicoterapia pode auxiliar criança e familiares a jogarem esses papéis com mais espontaneidade e criatividade.

Com a criança

Quando recebo a criança, pergunto se ela sabe o que motivou sua vinda à psicoterapia. Isto se fundamenta no fato de que faz parte do seu papel social

de filho saber que ação sua motivou determinada ação no seu contrapapel. Normalmente as crianças falam sobre a preocupação que os pais têm em relação a algo relacionado a ela e compreendem que isso que está acontecendo não lhe é favorável. Um menino disse: *“Eu fico muito nervoso de vez em quando e aí eu brigo muito, grito, bato e choro.”*; uma garotinha: *“Tenho muito medo na hora de dormir, fico com dor de barriga e dor de garganta sempre, não gosto de viajar e meus pais querem viajar sempre.”* Um outro, *“Não sei,... acho que é porque eu não gosto da escola e de ninguém de lá porque são todos muito chatos”*. As crianças pré-escolares podem referir que não sabem o porquê e nem quem sou, mas que vieram brincar. Desta forma, o ‘saber’ da motivação à psicoterapia dificilmente está presente na criança pré-escolar, o que mais uma vez confirma tanto sua ida “compulsória”, quanto a diferença de recurso psicológico para algumas funções nessa idade. Apesar disso, por meio do brincar, ela adquire uma compreensão de que *‘aquele brincar daquela situação’* lhe permite uma expressão importante e ela gosta disso.

Da mesma forma que se faz um contrato com os responsáveis, outro é realizado com a criança, quando falamos sobre o motivo do trabalho, a frequência com a qual nos encontraremos e as possíveis sessões vinculares. O que é dito à ela é semelhante ao que Gonçalves (1988) afirmou: *“Você virá aqui toda semana para trabalharmos juntos; vamos conversar sobre você e sobre as coisas que estão difíceis para você. A gente vai fazer isto usando este material e também fazendo representações ‘como se fosse em um teatro’, de histórias de ‘verdade’ ou inventadas” (p.66).*

As crianças escolares (acima de seis ou sete anos) compreendem e auxiliam com contribuições no contrato de trabalho: falamos do sigilo, da vinda

dos irmãos, etc. As menores, como dito anteriormente, têm uma compreensão compatível com seus recursos mentais, mas isso não é significativo para o ‘contrato’, tal como qualquer outra diferença advinda da sua idade: o objetivo da psicoterapia é auxiliá-la a desenvolver recursos de que dispõe, para lidar com suas dificuldades, tendo ou não clareza da sua existência.

Os Instrumentos: Cenário, Protagonista, Diretor, Ego Auxiliar e Plateia

O psicodrama, na estrutura da sua prática, inclui cinco instrumentos de trabalho, necessários para seu desenvolvimento. Independentemente da sua modalidade, grupal ou individual, eles estão presentes na sessão psicoterápica. É necessário um *lugar*, contendo o cenário no qual ocorrerá o ‘como se’ O drama de *quem* será apresentado é importante, porque ele é o porta-voz, o representante e o que contém esse drama – o protagonista. No trabalho psicodramático e na sua modalidade psicoterápica, é necessário um indivíduo que ocupe o lugar daquele que coordena o trabalho dramático: o diretor, representado pelo psicoterapeuta.

O ego auxiliar, como o próprio nome diz, auxilia, tanto diretor quanto protagonista. Na psicoterapia individual, caso deste trabalho, o psicoterapeuta será ego auxiliar da criança. A *plateia* é representada por todos aqueles indivíduos presentes na sessão psicodramática, mas que não estão no ‘como se’. Na psicoterapia individual não há plateia, somente quando há presença de alguma outra pessoa, é possível que ela se estabeleça. Ao discutir cada um deles, apontarei as diferenças que existem no trabalho com as crianças.

1. Cenário

Moreno (1983) demarcava o contexto dramático por meio da presença concreta de um palco, que podia ser no formato do teatro convencional ou marcado por um tablado ao redor do qual o grupo se sentava.

“(...) A colocação de uma plataforma ou de um palco numa sala, ou a designação de uma área especial para a produção, deu licença “oficial” para uma prática tacitamente aceita.(...)” (p.208)

Nos Congressos de Psicodrama, ao apresentarem seus trabalhos clínicos, pôde-se constatar que poucos psicodramatistas ainda mantêm o palco ou o tablado na clínica privada. Ao longo da experiência, o ‘palco’, exatamente por ser um espaço subjetivo, foi sendo demarcado da mesma forma, é a “área especial” à qual Moreno se referiu. Com as crianças, esse espaço geralmente se amplia para toda a sala de atendimento e os objetos a ela pertencentes adquirem uma nova ‘roupagem’. Quando uma história vai se iniciar, o cenário é demarcado pela criança e psicoterapeuta por meio de alguns objetos e espaços que tomam formas diversificadas ou se faz completamente na imaginação: *“Agora estamos numa floresta”; “o mar está com ondas muito grandes!”; “está tudo escuro e eles vão se perder”; “aqui é a casa do pintinho e ali é a do gavião”.*

A capacidade de imaginar faz parte do universo infantil; sua imaginação flui com facilidade e não é necessário dispor de muitos recursos materiais para que isso ocorra (Morais, 1980). Ao contrário, a construção do cenário para os adultos é necessária ao aquecimento (físico e mental) do protagonista para o contexto dramático. Importante salientar que o cenário se faz no palco, ou nesse espaço delimitado, não é um lugar concreto, são os referenciais temporais e espaciais onde a cena ocorre.

A origem do cenário no teatro espontâneo de Moreno foi em Viena, onde ele e sua equipe se apresentavam diariamente. No início, o cenário tinha o intuito de compor e adaptar as cenas que ocorriam, funcionava como um “pano de fundo” que pudesse ser ajustado às ações dramáticas. Para isso, improvisavam desde materiais diversos, até um pintor que subia ao palco e ilustrava, perante a plateia, a cena que estava iniciando e continuava à medida que ela se desenrolava. (Moreno, 1984). Com o decorrer de seu trabalho e a passagem do teatro espontâneo para o teatro terapêutico (Moreno, 1975), o cenário deixou de ser apenas o “pano de fundo” para integrar-se à cena dramática, funcionando como o aquecimento para os atores em cena. Nele ocorre a ação dramática, ou seja, o campo terapêutico do psicodrama. É considerado então, um instrumento essencial porque permite contextualizar a ação, aquece os atores e define papéis para que um trabalho de psicodrama ocorra.

2. Protagonista: o brincar infantil

O protagonista é porta-voz de sentimentos e vivências do grupo, o que sustenta o drama (quando se trata de um grupo; no caso do trabalho individual, o sujeito em questão sempre será o protagonista). Segundo Moreno:

“O segundo instrumento é o sujeito ou paciente. É solicitado a ser ele mesmo no palco, a retratar o seu próprio mundo privado. É instruído para ser ele mesmo, não um ator, tal qual o ator é compelido a sacrificar o seu próprio eu privado ao papel que lhe foi imposto por um dramaturgo. Uma vez “aquecido” para a tarefa, é comparativamente fácil ao paciente fazer um relato de sua vida cotidiana em ação, pois ninguém possui mais autoridade sobre ele mesmo do que ele mesmo. Ele tem de atuar livremente, à medida que as coisas lhe acodem à mente; é por isso que tem de lhe ser concedida liberdade de expressão e espontaneidade. Em grau de importância, o processo de representação segue-se à espontaneidade. O nível verbal é transcendido e incluído no nível de ação.” (1975, p. 18).

Quando se trata de criança e de um atendimento individual, ela é sempre a protagonista e as cenas que produzirá não necessariamente serão relatos de sua vida cotidiana. Sua expressão como protagonista ocorrerá por meio de cenas reais, imaginárias ou fantasiosas. Então, numa sessão psicodramática, a expressão da criança no contexto grupal e dramático dar-se-á por meio do brincar. Como dito anteriormente, o brinquedo é utilizado no cenário e na dramatização, ou seja, a ação da criança ocorre por meio do brincar.

. O brincar infantil

Quando uma criança inicia um processo psicoterápico, especialmente as menores de sete anos, ela não está preocupada nem interessada em retratar ou contar verbalmente fatos cotidianos, sobretudo se eles são conflituosos, trazem-lhe sofrimento. Ela quer brincar, esse é o seu movimento, sua forma de expressão e esta é uma das grandes diferenças do psicodrama realizado com adultos. Então, o protagonista criança tem características peculiares: não veio à psicoterapia por sua escolha, não tem, por iniciativa, o movimento de relatar 'problemas' para o psicoterapeuta, até porque nem sempre os reconhece, ou não tem aparato psíquico que lhe permita essa elaboração (Wechsler, 1999). Os psicoterapeutas infantis têm que lançar mão de recursos pessoais e técnicas que lhes propiciem ajudar essa criança a identificar e buscar recursos internos e externos para resolver seu(s) conflito(s).

É o brincar seu comportamento mais comum e quando o faz é assim que pode se comunicar e expressar o seu mundo interno. Isso foi considerado inicialmente por Melanie Klein (1969) e se tornou instrumento de trabalho dos

psicanalistas que interpretavam a brincadeira da criança, tal como na análise de adultos com a associação livre.

No psicodrama, o jogo dramático, não é interpretado, o foco do psicoterapeuta está na relação com a criança e nos papéis que são jogados como forma de resgate de sua espontaneidade e criatividade no ‘como se’. O jogo dramático também tem regras constituídas, pelo grupo ou criança, tais como a demarcação do contexto dramático, permitindo que o tempo e o espaço sejam adequados ao momento; jogam-se papéis e contrapapéis psicodramáticos que pertencem ao ‘como se’ e no ‘como é’, retomam-se os papéis sociais. O jogo dramático é facilmente utilizado com crianças pela sua capacidade de utilizar o brincar como forma de expressão.

Perazzo (1994) traz o conceito de papéis de fantasia, ou seja, papéis jogados na brincadeira espontânea da criança, em que ela é capaz de criar, reconhecer, imitar e interpretar. Morais (1980) observa que “(...) *as crianças mais eficientes na interação social brincam mais de faz de conta, sendo, portanto, sustentável que o treino na representação de papéis é importante para a eficiência comunicativa da criança*” (p. 23). A criança em idade escolar sabe distinguir a brincadeira de “faz de conta” da realidade e por meio dela fica relativamente livre de tensões impostas pela realidade social, podendo realizar comportamentos que seriam inibidos numa situação real. Por isso, o ‘como se’, o contexto dramático é o lugar e o momento onde o protagonista poderá modificar, romper ou refletir sobre regras impostas. A criança mais nova, a pré-escolar, por vezes, não distingue ou se confunde com as formas e níveis de realidade, mas é consciente de que, ao brincar, está lidando com uma realidade diferente daquela do cotidiano (Morais, 1980).

Observamos na prática com crianças pré-escolares, que elas preferem objetos ou brinquedos em miniatura para se expressarem. Algumas vezes passamos semanas a fio realizando histórias com os mesmos personagens e o mesmo cenário. Um mesmo tema da dramatização se repete com pequenas diferenças até que os papéis desempenhados sejam suficientemente jogados e elaborados. Essa elaboração se confirma por meio de mudanças em seu comportamento no contexto social e pode ser relatada por seus cuidadores.

Quando a criança realizou, por algumas vezes, uma mesma história, é comum que ela mesma passe a interpretar os personagens que eram representados por brinquedos. Quando isso ocorre, considera-se que o brinquedo era um instrumento que intermediava sua relação e que agora ela se encontra devidamente aquecida para jogar esses papéis. E nesse repetir de histórias é que ela revela o seu mundo e o sentido que ele tem, ou o revê através de papéis de fantasia (Perazzo, 1994).

Tassinari (1990) quando escreve sobre a utilização de brinquedos, afirma que não os considera 'objetos intermediários da relação' porque não faz referência à teoria de Rojaz-Bermúdez (1972). Para essa autora quando a criança usa o brinquedo é porque tem a necessidade desse recurso para auxiliá-la a diferenciar o 'como se', contexto dramático, do 'como é', contexto social. Concordo com Tassinari, mas compreendo que por vezes a criança utiliza o brinquedo como intermediário da relação também. Crianças escolares gostam de jogos e outros brinquedos; elas os utilizam na sessão psicoterápica e não é para caracterizar o 'como se', usam porque gostam, se expressam por meio dele e se apoiam nele para iniciar um contato. O trabalho de Wechsler (1999)

confirma isso e, mais que isso, para a autora, eles têm cunho educacional e possibilitam que a criança desenvolva recursos mentais a partir do jogo.

Outras crianças dispõem qualquer espécie de brinquedo e partem diretamente para a ação dramática. Algumas se dirigem ao jogo dramático, utilizando-se de objetos que as auxiliam no desempenho do papel dramático: são capas de Zorro, Batman, vampiros, monstros; ou fadas, princesas; máscaras e chapéus que compõem os mais diversos personagens e suas diferentes expressões e as aquecem para o papel dramático.

Independentemente do jogo escolhido, ou qual história será realizada pela criança, o foco do psicoterapeuta psicodramatista está na relação, no papel e contrapapel que naquele momento são jogados. As crianças escolares gostam de jogos, sejam eles de competição, sorte, simulacro ou vertigem. O que importa é que o psicoterapeuta considere qual é a função daquele jogo naquele momento, para que, a partir dele, os papéis psicodramáticos se revelem e possam ser jogados.

O brincar, então, é forma de expressão dramática, o que não significa necessariamente dramatização de uma história. O protagonista criança assim irá se expressar no decorrer do processo psicoterápico e para que a sessão ocorra, é necessário outro instrumento do psicodrama que é o diretor.

3. Diretor e ego auxiliar

Quem dirige a sessão psicodramática é o psicoterapeuta que neste papel tem três funções, a saber: diretor da cena no momento em que dirige a ação dramática, mantendo protagonista e plateia aquecidos para o drama presente; terapeuta em função da atenção a sentimentos, emoções e

pensamentos presentes na cena; e analista social, no que se refere a pontuações e comentários percebidos durante o processo de dramatização (Moreno, 1975).

Como diretor, é importante que o psicoterapeuta psicodramatista de crianças mantenha o aquecimento (primeira etapa da sessão que será discutida a seguir), em benefício da expressão da criança. Isso implica em estar disponível para acolher e acompanhar as suas propostas, e ao mesmo tempo, favorecer o desempenho de papéis psicodramáticos, pois esse é um recurso terapêutico do psicodrama. A atenção aos sentimentos, emoções e pensamentos presentes na atividade da criança permite que o psicoterapeuta desempenhe papéis psicodramáticos significativos para ela. Ao mesmo tempo, o conhecimento que tem dos seus contrapapéis no contexto social (por exemplo, pai, mãe, irmãos e outros), o auxilia no desempenho desses papéis no contexto dramático.

No contexto dramático da psicoterapia individual, o psicoterapeuta psicodramatista exerce dupla função: diretor e ego auxiliar concomitantemente. Para Moreno (1975), o ego auxiliar tem função de ator, pois representa papéis e contrapapéis, viabilizando a cena e auxilia o terapeuta do protagonista, captando sentimentos e desempenhando papéis complementares que possam facilitar a catarse de integração. Então, o psicoterapeuta de crianças necessita ter essa disponibilidade de dirigir e atuar ao mesmo tempo. Não significa que numa psicoterapia individual de adultos isso não ocorra; a diferença reside na atenção maior ao exercício desses papéis psicodramáticos que ora lhe são designados, ora ele os traz por meio de sua percepção e atenção ao movimento da criança, considerando que ela transita mais livremente entre os contextos, especialmente as pré-escolares.

O psicodramatista psicoterapeuta de crianças tem que ter um gosto especial pelo brincar, jogar, desempenhar papéis. Não que isso não tenha que estar presente em todos os psicoterapeutas de crianças, mas no psicodrama a atenção maior reside no exercício do contrapapel.

Para Petrilli (2000), a função do psicoterapeuta é *metabolizadora*, significando que por meio da relação horizontal com a criança, poderá lhe dar continência e promover devoluções. Gonçalves (1988) também realiza devoluções, por meio da interpretação no psicodrama analítico.

Nesse trabalho o psicoterapeuta, quando ao exercer o papel de diretor, não interpreta; quando é ego auxiliar e está exercendo um contrapapel, está livre para exercê-lo e todas as suas falas são a partir do personagem, não se constituindo como interpretação. A diferença do exercício do papel de diretor com crianças ou adultos é sutil. Compreendo que é importante a disponibilidade para o brincar, jogar, desempenhar os contrapapéis que lhe são designados – geralmente muitos ao mesmo tempo.

4. Plateia

Finalmente, temos a plateia, que é constituída por todas as pessoas presentes que não estão incluídas no ‘como se’ dramático. Ela tem a função norteadora da sessão psicodramática, ou seja, funciona como uma caixa de ressonância para o protagonista e, por conseguinte, auxilia o diretor e ego(s) auxiliar(es), orientando-lhes o trabalho. Moreno afirmou:

“O quinto instrumento é o público. Este se reveste de uma dupla finalidade. Pode servir para ajudar o paciente ou, sendo ele próprio ajudado pelo sujeito no palco, converte-se então em paciente. Quando ajuda o paciente, é um sólido painel de opinião pública. Suas respostas e comentários são tão extemporâneos quanto os do paciente e podem variar desde o riso ao violento protesto. Quanto

mais isolado estiver o paciente, por exemplo, porque o seu drama no palco é formado por delírios e alucinações, mais importante se torna para ele a presença de um público disposto a aceita-lo e compreende-lo. Quando o público é ajudado pelo sujeito, assim se tornando o próprio sujeito, a situação inverte-se. O público vê-se a si mesmo, isto é, um de seus síndromes coletivos é retratado no palco.” (1975, p. 19)

No caso da psicoterapia psicodramática individual com crianças, a plateia pode se constituir quando ocorrem sessões com a participação de outro(s) indivíduo(s) que faça(m) parte do átomo social da criança, isto é, a presença de outros familiares, ou pessoas significativas que vêm para uma sessão vincular.

Início do trabalho Psicoterápico

Antes de discorrer especificamente sobre as Etapas de uma sessão, farei algumas considerações a respeito das primeiras sessões com os pais e com a criança que inicia o processo psicoterápico. Essas primeiras sessões se diferenciam do processo como um todo porque têm funções mais específicas, ou seja, a de conhecer a rede sociométrica na qual a criança está inserida, qual seu status sociométrico, os papéis que lhe são designados e os que ela joga, que conflitos estão presentes e originaram a psicoterapia.

As primeiras sessões

Baseada em Conte e Regra (2000), que pesquisaram sobre a história da psicoterapia, mudanças nas formas de intervenção durante o processo psicoterapêutico ocorreram especialmente nas últimas três décadas, como vimos anteriormente. Se antes o processo era corretivo, atualmente a busca

pelo trabalho psicoterápico está ampliada e abrange aspectos preventivos e de promoção de saúde. Da mesma forma, a patologia que era demarcada por meio do processo diagnóstico, perdeu seu *status* para a compreensão do funcionamento da criança e seu complexo de adaptação ou não ao sistema em que vive.

O psicodrama não possui instrumentos de avaliação tais como os testes psicológicos. No entanto, do psicoterapeuta infantil é esperado que retorne aos pais o que percebeu ou concluiu da criança que iniciou um trabalho psicoterápico. Esse é um processo comum às psicoterapias com crianças de forma geral e foi ditado por autores contemporâneos que pesquisaram sobre o tema (Kazdin, 1987; Conte e Regra, 2000; Nunes e Lhulier, 2003).

Desta forma, após algumas sessões, essa 'devolutiva' com os pais também acontece numa psicoterapia psicodramática. Em concordância com Tassinari (1990), considero que o terapeuta retornará aos pais como percebe o funcionamento da criança em relação aos papéis que desempenha, sua inserção no átomo social e familiar: quem são as pessoas que o constituem, como percebe e se relaciona com cada pessoa de seu átomo; quais as tensões e conflitos presentes e quais os recursos de que dispõe para lidar com as demandas apresentadas. Tudo isso em consonância com as 'queixas', as demandas que motivaram a consulta psicoterápica.

1. As primeiras sessões com crianças

Moreno (1975) realizou testes de desempenho de papéis com crianças para verificar a espontaneidade, mas da forma como o fez, não considero que

seja viável na situação psicoterápica. Com o intuito de fazer pesquisa, as crianças eram convocadas a participar somente para essa tarefa, diferentemente de um contrato psicoterápico que implica na construção de uma relação ao longo de um processo. Então, pedir para elas desempenharem papéis desconectados de um objetivo mais claro, seria recebido com certo estranhamento, além de que o terapeuta correria o risco de a criança recusar-se a realizá-lo, seja por não estar suficientemente aquecida para tal, seja por timidez ou desconfiança.

Assim, geralmente a primeira sessão é de livre escolha dela. No meu trabalho, deixo alguns materiais disponíveis, tais como uma casinha, alguns bonecos e material gráfico para serem ou não utilizados espontaneamente. Esses materiais funcionam como intermediários da relação ou são utilizados num jogo dramático, ou na construção do átomo social da criança. A relação já se inicia no contexto social, quando vou recebê-la. Como isso ocorreu, qual sua receptividade, como foi o despedir-se ou não de seu acompanhante são elementos que compõem a compreensão dessa criança em relação. Na sala de psicoterapia, esse foco se mantém: é comum ela demonstrar interesse pelos brinquedos e comentar: *“Tenho uma casinha quase igual a essa, a minha é cor de rosa”*. De forma geral, supõe que o terapeuta é um adulto amigável e o inclui nos seus planos de brinquedo *“Meu time é o Corinthians e eu gosto de jogar bola, vamos jogar?”*. Ela é livre para expressar diretamente uma ampla variedade de sentimentos, *“Minha mãe sempre atrasa e hoje a gente saiu correndo”*. Pode admitir alguns pensamentos ou sentimentos mais negativos: *“Minha irmã é uma chata que não me deixa entrar no quarto dela”*.

Quando se trata de uma criança pré-escolar, é possível que não queira entrar para a sala de atendimento apenas com o terapeuta. Quando isso ocorre,

não o vejo como um problema; considero que ela está demonstrando que tem motivos para não se separar da figura que a acompanha e tem dificuldade em entregar-se a uma relação desconhecida. Sugiro que entre com o seu acompanhante, geralmente uma figura importante do seu átomo social porque os responsáveis já foram orientados antes para essa possibilidade, o que será considerado na compreensão do funcionamento da criança. Com criança e adulto na sala, o percurso da primeira sessão será praticamente o mesmo, o diferencial é que este adulto participa ativamente da sessão, não ignoro sua presença. Se houve a necessidade de a criança entrar na sala com esse indivíduo, trabalho os mesmos aspectos anteriormente mencionados com essa díade. Falo sobre o motivo de sua vinda, sobre a proposta de trabalho e a disponibilidade do brincar. É comum que percorridos alguns minutos ela já se sinta segura e dispense seu acompanhante; isso ocorrendo, a pessoa sai e a sessão prossegue apenas com ela e o terapeuta.

Em outras situações, geralmente com crianças menores de quatro ou cinco anos, há solicitação da presença simultânea do adulto por diversas sessões. Sua relação com esse indivíduo é trabalhada, o processo de separação ocorre paulatinamente e a psicoterapia prossegue com essa característica.

Algumas famílias procuram psicoterapia para crianças bem pequenas, as abaixo de quatro anos. Quando isto ocorre, prefiro trabalhar sempre com sessões vinculares, ou seja, criança e algum de seus cuidadores porque no psicodrama trabalha-se sempre o indivíduo nas suas relações, os papéis e os contrapapéis. A rede de relação de uma criança nessa idade, em geral não vai além de sua família, ou dos seus cuidadores diretos; ela não desenvolveu muitos papéis sociais até então. Considero que a possibilidade de trabalhar diretamente

com seus contrapapéis lhe é favorável. O pai ou a mãe constituem egos auxiliares ainda muito importantes para a criança, pois sua dependência dos mesmos é grande. Ela passou para o segundo universo e a terceira etapa da matriz de identidade há pouco, mas é gradativamente que irá adquirir a noção de realidade desse mundo ampliado que lhe traz surpresas, medos, desafios e conquistas que terá que lidar. Porém, não abordarei neste trabalho a psicoterapia com crianças menores de quatro anos, meu foco é a psicoterapia individual com crianças pré--escolares e escolares.

Da mesma forma que o terapeuta deixa a criança livre para fazer suas escolhas, pode também sugerir que construam o átomo social. Digo que é uma espécie de jogo e que consiste em escolher alguma coisa da sala que a represente e vá colocando ao seu redor as pessoas que são importantes na sua vida. Acrescento que ela deverá escolher o lugar e a distância em que essa pessoa se posiciona, mostrando como é sua relação com ela: mais perto, mais distante e assim por diante. Tanto as crianças pré-escolares, quanto as escolares, não encontram dificuldade em realizá-lo em todas as suas etapas, ou seja, a construção e tomada de papéis.

O átomo social, além de definir o que Moreno entende como o sujeito e suas relações – menor unidade observável do Homem em relação (Moreno, 1992), sua concretização pode ser um instrumento que permite conhecer a criança. A concretização dramática das relações é comumente chamada de átomo social ou técnica de autoapresentação. Depois que a criança termina a construção, peço que a olhe de longe e confirme se é assim mesmo ou se deseja fazer alguma alteração. Uma criança de pais separados cuja mãe casou-se novamente e teve filhas gêmeas, ao realizar seu átomo, incluiu a filha da esposa

do pai que tinha o mesmo nome que o seu e dizia: *“Eu sou a Paula 1 e ela é a Paula 2”*. Quando peço para olhá-lo de longe, grita: *“Esqueci das minhas irmãzinhas!”*. Ela incluiu a enteada do pai, e excluiu as irmãs, além da madrasta e padrasto que ficaram de fora. Investigar e compreender o significado de suas escolhas e rejeições possibilitou identificar seu átomo social e seu lugar na rede sociométrica em que estava inserida.

Outra criança pergunta se pode colocar pessoas que já morreram e diante da afirmativa, traz a avó e um passarinho. Uma outra fica em conflito porque precisa colocar uma amiga que está odiando, então, ela deve ficar muito longe dela. Diz que teria que jogar a almofada (é o objeto que a representa) pela janela; depois de muito refletir, escolhe colocá-la atrás do armário que é o ponto mais distante e escondido da sala. Ficou satisfeita e foi a primeira pessoa do átomo que escolheu para tomar o papel.

Por meio das entrevistas com a criança nos papéis psicodramáticos, é possível assinalar, esclarecer, levantar questões, ou seja, o papel psicodramático oferece uma gama de possibilidades para que se trabalhe o átomo social.

Difícilmente as crianças entram em todos os papéis que incluíram em seu átomo. Isto por dois motivos: primeiro porque geralmente são muitas pessoas, segundo porque elas não têm tempo nem prontidão para entrar em tantos papéis. Suas escolhas partem dos iguais: amigos, irmãos, animais de estimação e quando completam três tomadas de papéis, geralmente já se cansaram desse ‘jogo’. Porém, é o suficiente para o terapeuta conhecer a criança quanto a: sua espontaneidade; criatividade; capacidade de desempenhar

papéis; capacidade de tomar o papel do outro; de inverter papéis; sua rede de relações; lugar sociométrico que ocupa na família nuclear, extensa e grupo social; como percebe sua relação com esses indivíduos; capacidade télica; conflitos. Todos esses dados são elementos para que se possa refletir com os pais e outros cuidadores a necessidade ou não da realização do processo psicoterápico e a inclusão deles nesse trabalho.

A utilização do átomo social como forma de compreender a criança e os vínculos familiares é comum na psicoterapia psicodramática. Por isso, ele também é chamado de técnica de autoapresentação. No entanto, os autores de psicoterapia psicodramática com crianças não relatam que o utilizam na(s) primeira(s) sessão(ões) como parte do processo de compreensão do funcionamento da criança.

2. As primeiras sessões com os cuidadores

No trabalho com os pais ou cuidadores da criança também é utilizada a metodologia psicodramática, o que significa que eles também poderão dramatizar. A construção do papel se faz na relação e os pais constroem seus papéis na relação com os filhos. Inverter papéis com eles permite que possam ir além do *script social* do papel de pai ou mãe, porque lhes propicia conhecer esse filho na sua subjetividade.

Quando é o casal parental que vem para essa primeira sessão e não se trata de um casal separado, solicito no percurso da sessão, uma *inversão de papéis* para que se apresentem (um jogo de apresentação). Nessa inversão, solicito que a partir do papel parental, tragam características da sua relação com o filho, suas facilidades e dificuldades no desempenho desse papel, sua relação

com o parceiro parental, e o que mais couber nessa relação. Aqueço o casal para essa proposta e deixo que escolham quem iniciará a apresentação. Essa proposta é sempre bem aceita e suscita emoções, surpresas, sentimentos de compaixão, concordâncias e por vezes, discórdias. Um pai, no papel de mãe, disse: *“Sinto-me só por muitas vezes, fico cansada de ser a que dá bronca o tempo todo.”* Quando disse isso, os olhos de sua esposa se encheram de lágrimas, ela não tinha ideia de que ele a compreendia. Ela no papel dele: *“Chego tarde em casa e mesmo que as crianças estão aprontando não ligo muito, tenho medo de ser o pai ausente que além de tudo é bravo.”* Para o processo psicoterápico da criança, essas ações possibilitam uma sensibilização maior dos pais em relação à criança e entre os cuidadores. Favorece com que esses cuidadores mais sensibilizados, se comprometam com o processo psicoterápico e estejam mais disponíveis a refletirem sobre o exercício de seus papéis parentais, podendo questioná-los, mudá-los ou recriá-los em favor do bem-estar da criança.

O trabalho com pais é referido pelos autores psicodramatistas. Tassinari (1990) tem seu foco na família e somente depois que faz uma pesquisa no átomo familiar é que decide quem é o paciente da psicoterapia. Petrilli (2000) também trabalha com os familiares; seu foco é a criança e não tem o objetivo de “rematizar” as relações familiares, como afirmam Ferrari e Leão (1982), e Benedito, Baptista, França e Vero (*in* Gonçalves, 1988).

Nas primeiras sessões com os pais ou cuidadores ocorrerá a ‘devolutiva’, como mencionado anteriormente. Esta sessão tem o objetivo de lhes retornar a compreensão que tive da criança, seu funcionamento, conflitos, recursos ou não dos quais dispõe para lidar com suas dificuldades. São refletidos

esses processos em relação à queixa apresentada por eles e reconfirmada ou não a proposta da psicoterapia.

Utilizar-se de técnicas do psicodrama no trabalho com os pais e/ou responsáveis possibilita ampliar o conhecimento sobre eles. O objetivo do psicoterapeuta é o de favorecer ou incrementar relações télicas entre as pessoas dessa microssociedade que é a família, bem como que, um a um, *desempenhem o papel* do filho e interajam com ele ao longo do processo psicoterápico.

Etapas da sessão psicodramática: aquecimento, dramatização e compartilhar

A sessão psicodramática, além de considerar os contextos e os instrumentos, tem uma estrutura cuja prática é constituída por etapas. Esse processo do trabalho psicodramático foi dividido por Moreno em três etapas a saber: o aquecimento, a dramatização e o compartilhar. Cada uma delas será discutida a partir do que Moreno desenvolveu a respeito e apresentarei fragmentos de sessões para ilustrar a discussão.

A primeira etapa de uma sessão de psicoterapia psicodramática é o aquecimento que tem função importante no processo psicoterápico e constrói a passagem de um contexto a outro (Moreno, 1975, 1983, 1984, 1999). Na literatura de psicodrama ele é citado quando se fala dos contextos grupal e dramático, com a função de preparar o protagonista para atuar no contexto do “como se”, a cena dramática.

Moreno foi estabelecendo essa forma de realizar psicoterapia, ao longo do desenvolvimento do psicodrama (Moreno, 1975). Do mesmo modo que

verificou o valor da representação de papéis para a liberação da espontaneidade e criatividade, também observou que era necessário ‘aquecer’-se para o desempenho de papéis.

1. Aquecimento

O “processo de aquecimento preparatório” foi estudado por Moreno por meio de suas observações iniciais com crianças e bebês (Moreno, 1975). Ele estava interessado em investigar a espontaneidade e percebeu que os estados espontâneos são gerados por vários dispositivos de arranque, aos quais chamava de *starters*.

“(...)O sujeito põe em movimento corpo e mente, usando atitudes físicas e imagens mentais que levam à consecução do estado. Dá-se a isto o nome de processo de aquecimento preparatório. Este processo pode ser estimulado por dispositivos físicos de arranque (um complexo processo físico em que as contrações musculares têm um papel dominante), dispositivos mentais de arranque (sentimentos e imagens no sujeito que são, com frequência, sugeridos por uma outra pessoa) e dispositivos psicoquímicos de arranque (a estimulação artificial através do álcool e do café, por exemplo).” (Moreno, 1975, 300-301 (rodapé)).

‘Aquecer’ para a ação é parte de um processo natural do funcionamento humano. Ele manifesta-se em toda e qualquer expressão do organismo vivo, ao realizar um ato. Moreno (1975) afirma que *“o aquecimento possui uma expressão somática, uma expressão psicológica e uma expressão social”* (p. 106). Nesse processo de aquecimento preparatório acompanham sinais fisiológicos que se desdobram e libertam emoções simples, e não necessariamente surgem reações verbais. Para cada ato espontâneo um conjunto de expressões aparece. Ele exemplifica, *“(...)respiração acelerada, bocejos, tremores, acessos, críspação dos músculos faciais, incapacidade de falar, gritos repentinos, torcer*

as mãos, etc., desenvolve uma outra tendência afetiva, ansiedade, medo, desespero ou uma combinação destes.” (1975, p. 133).

No desempenho de papéis, Moreno observou que quando um indivíduo estava inteiramente absorvido por seu papel, nenhuma parte do seu ego estava livre para observar e registrar na memória, ou seja, havia um envolvimento e uma entrega total do indivíduo ao desempenho desse papel, e isso era favorável ao desempenho. O contrário também ocorria, ou seja, o que chamava de “*improvisação espontânea*” (1999, p. 287) era na verdade, uma espontaneidade fraca e que poderia atrapalhar a representação e destruir o processo psicoterápico. Então, desenvolveu para o trabalho psicoterápico com grupos, o método de “aquecimento” (1999). A função desse método era estimular o corpo e a mente para atitudes e atuações espontâneas. Para aquecer o corpo, movimentos corporais diversos; para aquecer a mente, estímulos variados, geralmente oferecidos por outra pessoa.

Moreno afirma que processo de aquecimento é a “*expressão operacional da espontaneidade*” (1992, p. 150), isto é, um termo técnico que resume as operações subjetivas e objetivas que conduzem a uma resposta adequada por parte do indivíduo. Elas implicam nos iniciadores físicos, mentais e psicoquímicos. Moreno sugere acrescentar outro iniciador: o simbólico, que seria composto pelos fantoches, contos de fadas, etc. Ele faz essa referência na introdução do livro de J. G. Rojas-Bermúdez (1970), *Títeres y Psicodrama*, no qual o autor trabalha com psicóticos crônicos por meio de objetos intermediários. No caso de psicoterapia com crianças, aqui se incorporam também os brinquedos, jogos e brincadeiras em geral.

Também é importante e necessário que o diretor e não somente o *ator*, esteja aquecido para a ação dramática. Quando trabalhava com grupos, observou que a maneira mais segura de fazer parte do processo de aquecimento era tornar-se membro do grupo, ou seja, criou a *regra* da “coação” do pesquisador (diretor) para com o grupo (sujeito da psicoterapia) (Moreno, 1992). Assim, no processo psicoterápico, o diretor também se aquece para o processo psicoterápico, para a ação dramática. Esse aquecimento ocorre num processo conjunto, definindo o papel que cada membro do grupo desempenha (no contexto grupal: diretor/psicoterapeuta e paciente; no contexto dramático: diretor/ego auxiliar e paciente no(s) papel(is) psicodramático(s)).

Numa sessão de psicodrama, o aquecimento é subdividido em aquecimento inespecífico e específico. O inespecífico, tal como designa seu nome, é um aquecimento que se realiza por meio de iniciadores físicos, mentais e psicoquímicos e simbólicos com o objetivo de aquecer para a ação dramática. O aquecimento específico é aquele que permite a passagem do “como é” para o “como se”, do contexto dramático. Numa psicoterapia de grupo, ocorre quando já foi escolhido o protagonista e ele é aquecido para sua cena. Na cena protagônica, egos auxiliares poderão desempenhar papéis e também deverão ser aquecidos especificamente para ela. O aquecimento específico prepara todos para o contexto dramático e segue a direção da cena protagônica. Ele se faz durante a própria montagem do cenário, a escolha dos personagens, na tomada de papel dos mesmos, etc. O aquecimento deve se manter durante o desenrolar da cena, pois libera a espontaneidade no desempenho dos papéis. O mesmo ocorre na psicoterapia psicodramática com crianças.

Encontramos na literatura de psicodrama com crianças que a etapa do aquecimento algumas vezes é desnecessária para os pré-escolares (Gonçalves, 1988). Comparado-o com o psicodrama realizado com adultos, que tem claramente uma etapa de aquecimento inicial, concordo com Gonçalves; por vezes a criança entra para a sala de atendimento já distribuindo papéis e iniciando uma dramatização, ou seja, ela já está aquecida para o jogo dramático. Entretanto, o aquecimento é sempre necessário, mesmo que eventualmente prescindir de uma ação do psicoterapeuta para que ocorra. Isso porque o aquecimento é para todos os envolvidos, para que possam encontrar uma forma de trabalho comum.

Com crianças, às vezes, o psicoterapeuta deve agir mais no sentido de aquecer-se para acompanhar a criança que entra rapidamente no contexto dramático. Assim, considerando o aquecimento da perspectiva de possibilitar que um *projeto dramático* aconteça, bem como a manutenção desse contexto, a delimitação entre o dramático e o grupal; o jogo de papéis e o desfecho da trama implicam num aquecimento contínuo de criança e psicoterapeuta. A manutenção do aquecimento é proporcional a boa e constante observação e percepção da atuação da criança em cada momento, desde a proposta inicial de ação até o final da sessão.

Uma menina de cinco anos chega à sala de psicoterapia dizendo que quer jogar memória. Vai até o armário, pega o jogo que lhe interessa e iniciamos a partida. Ela joga silenciosamente e de forma concentrada. Segue as regras com precisão e observa o desempenho do terapeuta. Ela ganha o jogo por um ponto e é elogiada pelo seu adversário, sorri satisfeita e diz: *Agora podemos*

brincar de mamãe e filhinha! Jogar memória foi o aquecimento inespecífico daquela sessão, porque nesse período inicial ela foi acolhida na sua escolha, o jogo, uma brincadeira que permitiu que ela tivesse um tempo para estar com o outro de forma tranquila, com o jogo e suas regras intermediando a relação. O tempo designado para essa atividade não foi pré-estabelecido, seguimos o curso natural do processo do jogo e, assim, parece ter sido o suficiente para ela. O jogo era de disputa com o outro e consigo mesma e ela obteve sucesso ao jogar, favorecendo sua segurança e confiança para a etapa seguinte: brincar de mamãe e filhinha.

No aquecimento específico ela deixou claro que o papel da filha seria seu e escolheu que eu assumisse o papel da mãe. Sua justificativa foi porque sou grande; esse seu critério segue o padrão do papel social de mãe: o adulto é maior, cuida, é o responsável, é grande. Isso, além do fato de ela ter experimentado momentos antes como era estar comigo; se eu era alguém disponível para desempenhar esse papel; que aspectos eram importantes nesse papel: acolhimento, submissão, reconhecimento ou o que mais pudesse representar. Ela tinha algo para contar nesse papel de filha e eu faria o contrapapel.

Com os papéis definidos, começamos a demarcar o cenário: é noite e vamos dormir; escolhemos onde serão nossos quartos e nossas camas. O psicoterapeuta no papel de diretor demarca o contexto dramático, investigando com a criança detalhes do cenário quanto ao espaço e tempo. Essas demarcações auxiliam criança e diretor a adentrarem no contexto dramático por meio da imaginação e isso facilita o processo de entrada no “como se”.

Outra garota, de 6 anos, chega sempre muito agitada, falando rapidamente, sem concluir um pensamento, uma tarefa ou uma história. Essa é uma característica de seu comportamento que se repete sempre. Rapidamente pega a casinha, alguns bonecos e inicia uma história. O diretor, sem interromper seu brincar, demarca o contexto dramático, anunciando que uma história está se iniciando e solicitando que o cenário seja construído e os personagens caracterizados. Compreendo que as características comportamentais da criança direcionam para a impulsividade e ansiedade e não são favoráveis à ação dramática, é preciso que ela se aqueça para tal.

O diretor procura dar ênfase a cada etapa da arrumação da casa, na escolha dos personagens, para que a criança vá se desacelerando e se aquecendo para a ação dramática e para uma ação conjunta. Ela escolhe os personagens: mãe, pai e filhas gêmeas. Onde estão, qual o período do dia e o que cada um está fazendo são dados importantes para o desenrolar da história. Eles são representados por bonecos e esses personagens e essa história têm se repetido em várias sessões. O diretor entrevista cada personagem fazendo perguntas simples e arruma o cenário 'casinha' junto com a criança.

Quando a criança rapidamente inicia uma história, ela pode já estar aquecida para a ação dramática, como pode também não estar. Dificuldades em controlar impulsos e ansiedade, necessitam de ajuda para a criança desacelerar e aquecer-se. Investir na construção do cenário e na caracterização dos personagens é uma forma de aquecê-la para a ação dramática.

No caso dessa criança, um dos cuidados do diretor foi mantê-la aquecida no decorrer da cena. A ansiedade a dificultava no desempenho dos papéis e ao mesmo tempo, sua desorganização se manifestava por meio do desempenho de

vários papéis ao mesmo tempo, como se atropelasse o percurso dos mesmos. Estávamos diante do que Moreno chamou da *improvisação espontânea* para o desempenho do papel. Diante disso, o aquecimento é essencial à criança e ao diretor. Ele pode ser feito por meio de *duplos* dos personagens. Exemplo: “*Estou confusa, agora há pouco estava no quarto com minha irmã, agora já estou em cima do telhado, minha mãe está gritando comigo, meu pai não faz nada, isso aqui está uma bagunça!*”. Um outro duplo: “*Essas meninas me deixam maluca, elas não param! Estão fazendo uma desordem muito grande na casa e eu não estou gostando nada disso!*”. Por meio da técnica do *duplo*, a criança pode dimensionar o seu movimento e reorganizar o percurso de seu pensamento e da construção do enredo dramático. Ao mesmo tempo, o diretor, por meio dos *duplos* também vai se aquecendo para esses papéis psicodramáticos e adentrando no drama trazido pela criança.

Numa outra situação, o psicoterapeuta recebe a criança na sala de atendimento, perguntando o que havia feito naquele tempo em que não se viram (foi um tempo maior em função de feriados). O contexto era o grupal e a pergunta tinha o intuito de demonstrar interesse e dar acolhimento à criança, que já tinha em mãos um bloco de papel e lápis da mesa do psicoterapeuta. Ela respondeu: “*Caguei na sua cabeça.*” Nova pergunta: E o que mais? “*Caguei na sua cabeça.*” Enquanto falava isso, ia desenhando corações. Ela trazia o psicoterapeuta para uma relação ambígua, ao que lhe foi respondido: *Poxa, você pensou bastante em mim, eu também fiquei com saudades.* Ela não disse nada e em seguida falou que podiam retomar a história da sessão passada: duas garotas que se invejavam e se ‘roubavam’ mutuamente.

Diferente da criança citada anteriormente, esta não estava agitada, seu comportamento era calmo e rapidamente ofereceu um contrapapel ao psicoterapeuta: o que será desprezado e invejado. O trabalho do psicoterapeuta no papel de diretor foi separar o “como se” do “como é” para a criança. Novamente o contexto dramático foi demarcado e os personagens construídos. Ambos foram se aquecendo para os papéis, colocando roupas e acessórios que compunham o papel psicodramático. O cenário foi construído imaginariamente: estavam numa festa. O comentário inicial do diretor teve a função de demarcar contextos e possibilitou também o aquecimento para a entrada no contexto dramático e a partir daí ele foi mais específico.

Outras crianças escolhem primeiro construir ou escolher um jogo e depois são aquecidas para assumir um personagem e jogam no “como se”. Dessa forma, o jogo é um aquecimento inespecífico para a ação dramática e a construção dos personagens, o aquecimento específico. Isso é mais comum nas crianças acima de sete anos, que não têm como escolha primeira o jogo dramático, elas precisam ser aquecidas para a ação dramática, à semelhança dos adultos. Isso é compartilhado pelos outros psicodramatistas (Gonçalves, 1988; Tassinari, 1990). Sair do papel social e assumir um papel psicodramático oferece ao terapeuta a possibilidade de estabelecer com a criança uma relação mais espontânea. Partimos para a investigação: Quem vai jogar? Quem são essas pessoas? Qual a idade delas? Sexo, nome? Onde estão? Favoreço com que a criança vá fazendo suas escolhas e determine os papéis. Assim, seu ego auxiliar fará o seu contrapapel que, naquele momento contém elementos que necessitam ser vividos nessa relação.

O desenho também é uma escolha frequente entre as crianças de todas as idades. Esta é uma atividade comum entre elas. É uma forma de expressão livre que precede a escrita e a leitura e é encontrada em todos os níveis socioeconômicos e culturais (Wechsler e Nakano, 2012). Como aquecimento para a ação e especialmente nos momentos iniciais de contato com a criança, desenhar é geralmente bem aceito, pois é considerado uma forma de brincar, bem como intermediário da relação.

No psicodrama, o desenho e sua exploração por meio de histórias podem ter como objetivo aquecer a criança para a ação dramática. É oferecida a ela uma conduta ativa para buscar no “como se” da dramatização, situações que antes se viam limitadas somente no seu desenho. Ele funciona como um iniciador físico e mental para aquecer a criança e entrar no papel psicodramático.

Então, o aquecimento na sessão com crianças pode ocorrer inicialmente de várias formas: por meio de jogos diversos, desenho, brincadeira, etc. Esse instrumento que aquece pode se manter no percurso da dramatização, como uma espécie de ‘pano de fundo’ onde o drama se manifesta. Ou seja, personagens podem surgir por meio de um jogo de regra ou do desenho e a passagem para o contexto dramático ocorre sem que necessariamente se interrompam essas atividades.

As crianças acima de sete anos podem também trazer cenas do seu cotidiano para serem trabalhadas. A partir dessa idade, a criança já percorreu etapas do seu desenvolvimento as quais permitem que ela tenha uma elaboração mental mais sofisticada que as menores (está na 3ª. fase da Matriz de Identidade: *Brecha entre a Fantasia e Realidade*, capacitada para realizar a *inversão de papéis*), podendo compreender situações do seu dia a dia que a

incomodam e que a psicoterapia é um espaço onde ela pode ‘contar’ suas histórias.

Quando ela traz uma cena do seu cotidiano, o aquecimento se dará através da construção do cenário dramático com a criança, investigando detalhes de tempo e espaço e dos personagens que contracenam. Isso está de acordo com o que afirmou Tassinari (1990) de que as crianças maiores necessitam de mais investimento na etapa de aquecimento porque estão com capacidade espontânea menor devido às conservas culturais. Além disso, investir na sua capacidade imaginativa contribui para a liberação da espontaneidade.

1. Dramatização

A dramatização é a etapa de uma sessão de psicoterapia psicodramática em que a ação dramática é coconstruída, é o contexto do “como se”, onde as cenas se desenvolvem a partir de elementos trazidos pelo protagonista (Moreno, 1975,1983,1984, 1999).

Na psicoterapia psicodramática cliente e psicoterapeuta constroem e executam um *projeto dramático* que, segundo alguns psicodramatistas contemporâneos (Perazzo, 1994; Aguiar, 1998) era o que Moreno (1975) tinha como meta: trazer a ‘verdade’ do indivíduo por meio da ação dramática. Perazzo (1994) assinala que há o *projeto dramático latente*, onde cada uma das partes mantém sua função ligada ao papel social, ou seja, o de psicoterapeuta que deve cuidar e a do cliente que está para ser cuidado, semelhante ao que tradicionalmente é conhecido como contrato de trabalho, e o *projeto dramático*

manifesto. Este é coconstruído na sessão e carrega a subjetividade da criança e do psicoterapeuta. Ele contém o que a criança tem a dizer, manifestar, vivenciar naquela sessão, acompanhada e compartilhada pelo psicoterapeuta que desempenhará os contrapapéis, por isso uma cocriação. E esse *projeto dramático*, cocriado coconsciente e coinconscientemente por psicoterapeuta e criança, se torna ação na dramatização.

Moreno (1999) verificou a importância da dramatização, trazendo o conceito de *Momento*, o “aqui e agora” em que adultos e crianças podem expressar o que ele chamou de “*Vivências impressionantes do passado se exteriorizam de alguma forma nas vivências atuais*” (p.85). Passado, presente e futuro podem ser experimentados no contexto dramático sem a preocupação da lógica temporal. A cena dramática se caracteriza por sua atualidade, ela é sempre uma criação do momento. As crianças, especialmente as pré-escolares, facilmente imaginam e criam histórias. A imaginação da criança, ao criar uma cena dramática, é uma alternativa que ela encontra para as respostas, os comportamentos já conservados, as repetições de seu cotidiano.

Aguiar (1998), psicodramatista brasileiro, reconhecido por seu trabalho com teatro espontâneo reflete que a vantagem de se liberar a imaginação é que a liberdade de criação torna a cena mais fluente e possibilita a contribuição do outro por meio do contrapapel. As cenas que se criam refletem os conflitos e contradições que permeiam a vida comum, não só da criança, mas de todos, com a diferença de que elas são base do sofrimento da criança. Assim, a singularidade da criança está inserida num contexto mais amplo, no coletivo, no qual o psicoterapeuta também faz parte – “*O singular de um indivíduo é único na coletividade*” (Aguiar, 1999, p. 129). A ideia de que o conflito tem a ver com a

forma como estão estruturadas as relações dentro da coletividade, mostra a importância do contrapapel na encenação psicodramática. A criação permite emergir a estrutura vincular dos papéis que são jogados. E o efeito terapêutico disso está vinculado à manifestação do coinconsciente, ou seja, a experiência vivida e compartilhada por meio da cocriação.

Para Moreno (1983) o coconsciente e o coinconsciente são estados que ultrapassam os limites do espaço psíquico individual e podem ser revividos e atuados por elas e pelas pessoas que possam se vincular a conjuntos de sentimentos, sensações e crenças. A essa dimensão relacional Moreno chamou de interpsique, que são modos específicos de ser e de se relacionar, originários de duas ou mais pessoas, acessíveis ou não à consciência.

Knobel (2009), explorando o conceito de coinconsciente em Moreno, complementa:

“Além disso são estados, conjuntos de qualidades e de características móveis e conjunturais que se organizam, em parte intencionalmente e em parte por acaso, na convivência estável e significativa. Constituem um tecido relacional de base, uma matrix compartilhada por pessoas (inter) que deixa vestígios e fragmentos dessas experiências compartilhadas nas pessoas (intra) e se mantém como histórias, mitos e tradição cultural para além das pessoas concretas. Abrange tanto modelos relacionais usuais nas/das famílias, como seus significados oriundos da vida social e cultural.” (p. 4)

Ambas as dimensões, consciente e inconsciente, estão presentes na relação. E, fazem parte da singularidade do indivíduo, os seus modelos relacionais e familiares que estão inseridos na vida social e cultural e vice-versa. Assim, a criança poderá, por meio da relação com o psicoterapeuta nos seus contrapapéis, experimentar novas formas e padrões de comportamento que são permitidos no “como se”, mas proibidos ou difíceis de serem realizados no

contexto social, exatamente pela história na qual a criança está inscrita. Questionar padrões de conduta familiar e/ou social, experimentar no “como se” o poder de inverter valores, e papéis sociais pré-determinados, explorar seus recursos, defrontar-se com seus limites, são possibilidades que ela terá na ação dramática. E é na ação dramática que os fatores *e* (espontaneidade) e *t* (tele) poderão ser liberados e experimentados, pois o trabalho de Moreno com o teatro espontâneo levou-o a perceber que jogar papéis dramáticos possibilitava romper com regras que se aprisionam na conserva cultural.

Para Perazzo (1996), na dramatização:

“As tramas ocultas dos dramas privados de cada um se misturam e se esclarecem num mesmo drama coletivo. Aquilo que até então era co inconsciente se torna co consciente, mesmo que não verbalizado, para todos, inclusive para o diretor e para os egos auxiliares.” (p. 4).

Considerando que no psicodrama com crianças o psicoterapeuta é seu ego auxiliar e contracena com ela, no jogo de papéis os estados coconsciente e coinconsciente estão presentes nessa relação, possibilitando o fluir das emoções, pensamentos e atitudes que permeiam os papéis que são jogados. A atenção e sensibilidade do psicoterapeuta devem encaminhar-se para uma relação télica, fazendo com que o jogo dramático que se manifesta, seja acolhido, vivido e conduzido a um desfecho com a criança. Esse desfecho não significa necessariamente um “final” da história, mas o retorno ao contexto grupal e depois ao social. O contexto dramático é a possibilidade de liberar espontaneidade por meio do papel psicodramático e o retorno ao papel social é uma das funções da psicoterapia psicodramática. Moreno considerava que a função do papel psicodramático era revitalizar, trazer novas possibilidades de

ação para o papel social com relação a seus contrapapéis após a liberação da espontaneidade.

Sendo uma criação, a dramatização é a concretização de uma *realidade suplementar*, que segundo Moreno (2000), é “*uma dimensão que vai mais além da realidade subjetiva e objetiva*” (p. 46). A autora faz essa afirmação baseada em depoimentos de seu marido, Moreno, que dizia que os protagonistas se moviam dentro de áreas que eram reais somente para eles, de caráter puramente subjetivo. Diante disso, Moreno afirma que só poderia chegar verdadeiramente ao psiquismo do protagonista se ele estivesse junto com o protagonista na *realidade suplementar*. Este é o movimento do psicoterapeuta psicodramatista de crianças, um mergulho nessa subjetividade infantil, que por vezes, será compreendida somente por meio dos contrapapéis que desempenha.

Continuando em seu pensamento sobre a dramatização, Perazzo (1996) conclui:

“(...)dessa forma, também estaremos nos libertando e construindo um status nascendi novo de uma forma de viver, a partir de novas inscrições, registros, de modos relacionais. Um novo existir consigo mesmo, a partir de uma nova maneira de existir com os outros.” (p.4).

O autor reflete sobre o ‘efeito’ da dramatização que possibilita experimentar novos parâmetros relacionais, mais favoráveis à liberação da espontaneidade e menos aprisionados às conservas culturais. Para a criança significa também, a partir disso, oferecer novas perspectivas de conhecimento, aprender a lidar com diferentes papéis sociais que têm *scripts* divergentes entre

si e que ela aprende a escolher, dependendo de quando, como e com quem se relaciona.

Como já assinalado na discussão sobre contextos, a etapa da dramatização com crianças também pode ter uma demarcação diferente da sessão de um adulto. Ora ela já se inicia na entrada da sala de psicoterapia com o fechar da porta, ora após o início de um jogo, um desenho, etc. O aquecimento marca a passagem de um contexto a outro, e algumas crianças encontram-se suficientemente aquecidas para o papel psicodramático. O psicoterapeuta mantém seu papel de diretor e ego auxiliar. Como diretor, deve conduzir o aquecimento da criança e o dele para que os papéis psicodramáticos possam ser jogados e demarcar entradas e saídas de contexto. Como ego auxiliar, deve manter-se aquecido para jogar o papel psicodramático com a criança.

Trabalhar dessa forma, em geral, independe das 'queixas' da criança, sejam de ordem emocional somente, ou com componentes orgânicos. A mudança ocorre no aquecimento, variando com relação ao tipo, intensidade e frequência dele. Na ação dramática, nem sempre são jogados papéis psicodramáticos; o que importa é que um projeto dramático seja construído com a criança e executado. As etapas da sessão psicodramática às vezes, ocorrem ao longo do processo psicoterápico. Os fragmentos de sessão que apresentarei contêm uma ação dramática e favorecerão que se compreenda o uso de técnicas psicodramáticas.

O psicodrama é uma teoria da ação e Moreno desenvolveu técnicas que auxiliam na condução do trabalho dramático. Existem três técnicas básicas que se originaram a partir da Matriz de Identidade. Ao estudar o desenvolvimento da criança e conceituar as fases da Matriz de Identidade, Moreno observou que

algumas ações eram presentes em cada uma delas. A *fase do duplo* é a da “indiferenciação e onde a criança precisa sempre de alguém que faça por ela aquilo que não consegue fazer por si própria, necessitando, portanto de um *ego-auxiliar*.” Inspirando-se no *doublé* do cinema, Moreno chamou esta fase de DUPLO.

Fase do Espelho – onde existem dois movimentos que se mesclam: o de concentrar a atenção em si mesma, esquecendo-se do outro e o de concentrar a atenção no outro, ignorando a si mesma. Pelo fato de nesta fase a criança ver sua imagem refletida na água ou no espelho e estranhá-la dizendo “olha o outro nenê”, Moreno deu a esta fase o nome de ESPELHO.

Fase de Inversão – onde, “*em primeiro lugar, existe a tomada do papel do outro para em seguida haver a inversão concomitante dos papéis.*” (Gonçalves, 1988, p. 62). A partir das fases, criou as técnicas do DUPLO, ESPELHO e INVERSÃO DE PAPÉIS.

Cada uma das técnicas tem função específica, o *duplo* realizado pelo psicoterapeuta ou ego auxiliar, consiste em colocar-se na mesma sintonia do protagonista e trazer à tona sentimentos, pensamentos, emoções que ele não consegue discernir sozinho. O *espelho* é a técnica que oferece a possibilidade de se ver como no espelho, de perceber seu comportamento, esse é seu valor terapêutico (Moreno, 1999, p. 109). É utilizado quando o paciente é incapaz de se apresentar em palavras e atos. Nessa técnica, “o protagonista é um espectador, um observador, ele olha para o espelho psicológico e vê a si mesmo” (Moreno, 1983, p. 67).

A técnica da *inversão de papéis* consiste em colocar-se no lugar do outro. Para Moreno (1983), ela era considerada uma técnica de socialização e de integração do eu, onde “deformações do psiquismo do outro são assim trazidas à luz e podem, durante a atuação, ser pesquisadas e melhoradas” (1999, p. 123). Moreno discute sobre essa técnica utilizada em crianças e tece uma série de hipóteses a respeito, as quais foram mencionadas anteriormente.

Uma das formas do psicoterapeuta trabalhar, estar com a criança, é seguindo o ‘princípio do duplo’, termo empregado por Fonseca (1990) e utilizado por Petrilli (2000), o qual significa estar em sintonia com o paciente, podendo expressar ou realizar aquilo que ele necessita e não consegue por si só. Fonseca apresenta também o ‘princípio da entrega’, que está vinculado ao desempenho de papéis do psicoterapeuta. No contexto dramático com as crianças a disponibilidade do psicoterapeuta, como ego auxiliar, implica em contracenar com os papéis psicodramáticos da criança, favorecendo o correr do enredo dramático. Dessa forma, não importa que papel psicodramático o terapeuta estará desempenhando, mas sim, se esse papel está em sintonia com o desempenhado pela criança.

Na dramatização com crianças algumas das técnicas do psicodrama podem ser utilizadas. Com as pré-escolares, o *princípio do duplo* tem supremacia em relação as outras. Isso se relaciona em primeiro lugar, à fase de desenvolvimento em que a criança se encontra. Vimos que na fase do *duplo*, primeira etapa da matriz de identidade, ela vive um momento de indiferenciação e necessita do seu ego auxiliar para o processo de reconhecimento de si mesma e do outro. A criança pré-escolar, em psicoterapia, não está nessa fase, já avançou outras etapas (todas as mencionadas na Matriz de Identidade) e,

segundo Moreno, já pode inverter papéis. Nesse aspecto, concordo com os psicoterapeutas psicodramatistas de crianças contemporâneos (Gonçalves, 1988, Petrilli, 2000, Wechsler, 1999) que afirmam que a criança só conseguirá inverter papéis, bem mais velha (a partir de 7, 8 anos), baseando-se no seu desenvolvimento biopsicosocial (as autoras citam os autores: Piaget e Vygotsky).

Isto significa que, apesar de já ter avançado por etapas importantes, a criança ainda está desenvolvendo habilidades mentais que exigem recursos mais sofisticados, tal como a *inversão de papéis*. Tassinari (1990) associa o desempenho de papéis às etapas de desenvolvimento de papéis: *role playing*, *role taking* e *role creating*, pesquisados por Moreno (1975). A autora afirma que em sua experiência pode correlacionar a idade da criança com sua capacidade de desempenhar papéis, ou seja, tomar, jogar e criar. A inversão de papéis pressupõe um desenvolvimento de papel que atingiu o grau máximo, o *role creating*. O resultado é o mesmo, a criança só inverte papéis quando maior, em idade escolar.

A menina de cinco anos que queria brincar de mamãe e filhinha inicia a ação dramática com uma cena familiar: pai e mãe dormem e ela está em seu quarto. Não consegue dormir e começa a fazer barulho. Os pais inicialmente perguntam o que acontece e acolhem a criança, como ela reluta em dizer o que há, acaba levando bronca do pai e recebe um castigo. Na cena, quer ficar com a mãe e busca cumplicidade com ela na tentativa de ludibriar o pai.

“F: Bom dia, mãe. Fica aqui comigo vendo TV?”

M: Não posso, o seu pai disse que você estava de castigo e não podia ver TV.

F: Ah, mas ele não vai ver que a gente está vendo, a gente fecha a porta.”

Não alcançando seu objetivo, retoma a cena noturna:

“Ela se levanta e vai para o quarto dos pais.

F: Eu não quero ficar no meu quarto porque tem um fantasma me assustando.

M: O quê? Poxa filha, que ruim. Então temos que dar um jeito nisso. Nós vamos lá acabar com ele!

Ela fica entusiasmada. Decidem como vão enfrentar o fantasma: pegam uma lanterna (imaginária) e um pau e caminham para o quarto.

Logo o fantasma aparece (ela aponta dizendo que está ‘ali’) e ele é “atacado” por ela e os pais. Ela o pega e diz que tem que jogar no lixo (um grande puff da sala). Joga-o, chuta e xinga.”

O terapeuta faz os contrapapéis e a cena prossegue:

“M: Pronto filha, agora você pode ficar tranquila no seu quarto.

F: Ei, tem mais! Tem um nenezinho aqui.

M: Mas esse é o seu irmãozinho (mãe o pega)

F: Mas tem mais nenezinhos! Esses são fantasmas!

M: E o que vamos fazer?

F: Então vamos jogando tudo no lixo.

Ela muito entusiasmada vai jogando todos os outros nenezinhos no lixo e dando chutes, pauladas e xingando. Enquanto havia um nenezinho (que era representado por almofadas) ela foi jogando.

Depois diz:

F: Mãe, você pode brincar comigo?

M: Sim filha, eu vou deixar seu irmãozinho lá com seu pai então.

F: Vamos brincar de casinha?

M: Vamos, sim!

A história termina com mãe e filha brincando de casinha no quarto, agora sem os nenezinhos fantasmas. “

O desenrolar da cena encaminha para um acolhimento da criança e dos “fantasmas” que a assombram. Na relação com os pais suas fantasias fluem e ela ‘perturba’ o encontro do pai e da mãe. Além disso, manifesta sua

necessidade de cuidado e atenção: os fantasmas bebês vêm para perturbar seu sono, tal como o irmão ‘perturba’ seu encontro com a mãe no contexto social.

Ela pede contato com a mãe e o recebe. Sua atitude de ‘perturbar’ os pais, e os seus sentimentos em relação aos bebês fantasmas são autorizados, compartilhados e não interpretados. Ela pode expressar no “como se”, nos papéis psicodramáticos, seus sentimentos de raiva, medo, solidão, tristeza e ciúmes. Pode também viver uma realidade suplementar, realizando um encontro com a mãe. As ações verbais do psicoterapeuta ocorrem por meio do seu papel de ego auxiliar que assume papéis psicodramáticos. Toda a ação é em cena e na etapa do compartilhar ficará mais evidente a ação terapêutica.

Esta história, com pequenas modificações, se repetiu por mais duas vezes e marcamos sessão vincular da criança com sua mãe. O teor da sessão vincular : brincar de casinha com a mãe foi a possibilidade de ela viver concretamente com a mãe o que vivia no “como se” com o psicoterapeuta. A sessão vincular de psicodrama, neste caso, retirou o psicoterapeuta do papel de ego auxiliar da criança, permanecendo apenas como diretor. A mãe assumiu o papel de ego auxiliar e elas jogaram papéis psicodramáticos, o que possibilitou a liberação de espontaneidade na relação e isso lhe é favorável.

Com outra criança, de seis anos, a história também é uma situação familiar e o ‘princípio do duplo’, permeou a dramatização.

“Muito agitada, assume vários personagens ao mesmo tempo, mas o que mantém como estáveis são as ‘irmãs gêmeas’.” Como muitas crianças, ela escolhe um personagem com o qual se identifica e os outros, de forma geral, são

desempenhados pelo diretor. Esse personagem é o que traz o conflito, ou o 'tema protagônico' que será vivido nas relações do contexto dramático.

Todos estão em casa.

Mãe (criança): Está quase na hora do bebê nascer.

Pai (Terapeuta): Ah, eu estou desgostoso porque vai nascer outra menina e eu queria um menino agora.

Mãe (c): Ah, deixa pra lá, vai ser mais uma menina, mas tudo bem.

Em seguida, já aparece o bebê, mas ele sai de cena rapidamente e as irmãs gêmeas começam a 'aprontar': sobem em cima da casa, derrubam coisas, brigam entre si e hostilizam a família.

Toda a história se mantém dessa forma: as gêmeas sempre muito agitadas, inadequadas e se depreciando. No meio da história a criança sai do papel psicodramático e diz para psicoterapeuta: *"Minha mãe disse que minha irmã é perfeita. T: E o que você achou disso? Não responde e está agitada demais."*

Aqui a criança passou do contexto dramático para o grupal rapidamente. Ela precisava dizer para o diretor o que sabia a respeito da sua história; não respondeu verbalmente à pergunta do diretor, mas ao retornar à história ofereceu sua resposta dramaticamente. As gêmeas continuavam destruindo tudo e os pais dando broncas, colocando-as de castigo, punindo sempre. Depois de um tempo ela saiu novamente do papel das gêmeas e disse para o psicoterapeuta: *"Eu odeio a minha irmã."*

Nesse momento ela voltou ao contexto grupal para dar a resposta ao psicoterapeuta. Rapidamente retorna à história e as gêmeas morrem.

A ansiedade e dificuldade de atenção da criança a dificultam no desempenho dos papéis e ao mesmo tempo, sua desorganização interna se

manifestou na história: desempenhou vários papéis ao mesmo tempo, como se atropelasse o percurso dos mesmos. Essa confusão era a sua história e ela precisava ser vivida.

As gêmeas representavam suas dificuldades, confusão, rejeição, desafeto e inadequação (sua mãe diz que ela dá trabalho por duas!). Esses conteúdos se manifestaram em seguida, tal qual na vida real, em comportamentos inadequados ao convívio familiar.

Os papéis psicodramáticos propiciaram que manifestação de comportamentos e sentimentos proibidos no contexto social. Tomada por esses afetos, saiu do papel psicodramático e contou para o psicoterapeuta algo que percebeu no ambiente familiar. Seu lugar sociométrico na família não tem sido favorável em nenhum aspecto: sente-se rejeitada e inadequada. Isso gera sentimentos difíceis de serem administrados. Os papéis sociais de filha e irmã têm sido desempenhados com pouca espontaneidade e nessa sessão ela reproduz isso. Foi um passo dado na compreensão do seu átomo social e de seu comportamento. As gêmeas continuaram aparecendo nas histórias seguintes.

Às vezes, a criança dramatiza por meio de brinquedos. Ela distribui os papéis, traz o enredo e a trama vai se desenvolvendo. Isso é comum nas psicoterapias psicodramáticas com crianças, mas há uma ação que não encontrei descrita nos artigos de psicodrama com crianças.

Quando a criança escolhe para o psicoterapeuta um papel simétrico ao dela, favorece o 'princípio do duplo' e também do 'espelho', ou seja, além de estar em sintonia com a criança, trazendo elementos importantes da relação, no

papel psicodramático o psicoterapeuta pode ‘espelhar’ aspectos da criança. Chamarei de ‘princípio do duplo espelho’ as características do desempenho de papéis simétricos no contexto dramático. A função desse princípio é a mesma do duplo e espelho, ou seja, no papel psicodramático o psicoterapeuta traz para a relação conteúdos que a criança não consegue reconhecer ou expressar sozinha, função do ‘duplo’. E, nesta ação ela ‘visualiza’ atitudes, expressões e comportamentos também seus, com certa distância, ampliando sua capacidade de percepção.

Relato a seguir sessões em que foi utilizada a técnica do duplo espelho, que segue o mesmo princípio descrito acima.

“História de duas famílias: A família da criança (sete anos), mora na casa maior e tem o pai, mãe, um bebê e uma menina. A família do psicoterapeuta tem o pai, a mãe e um menino. Ela define os personagens: ela é a menina e eu o menino. Nossas famílias são parentes: somos primos.

As famílias vão se visitar e os primos brigam por causa de um brinquedo, que é do primo. A menina é agressiva com o primo e a mãe lhe dá bronca.”

A criança orienta o psicoterapeuta, a mãe tem que ser muito, mas muito brava.

“A mãe é brava e a menina se revolta e vai morar no alto da montanha, diz que quer morrer, que na verdade já está morta. Nesse momento abandona a casa dos parentes e vai para o alto das montanhas (colocou uma grande almofada e fica sozinha lá em cima, deitada no alto da montanha). “

Os familiares conversam entre si para entenderem o que é que aconteceu com a menina. Levantam algumas hipóteses: - ela gostou do brinquedo do primo e discutem se talvez deveriam dar um igual para ela. – questionam se ela mereceria, já que foi tão mal-educada com todos.

“Enquanto isso, a filha continua deitada no topo da montanha, quietinha, só ouvindo a conversa de longe. A mãe diz o quanto é difícil ter que lidar com esse jeito da filha: “Ela sempre quer o que é do outro e aí eu fico brava e ela some, mais brava ainda!”.

Os pais refletem, por meio de solilóquios. O solilóquio é uma das técnicas verbais utilizadas para expressão de conteúdos ocultos do mundo interpessoal. É semelhante ao que no senso comum chamamos de “pense alto”. Moreno (1975) a desenvolveu com o intuito de o paciente revelar sentimentos e pensamentos que teve em uma situação real com determinada pessoa, ou que surgiram naquele momento da ação dramática.

Os personagens fazem solilóquio ou conversam entre si, alegando que não querem deixar que ela morra, que já tinha ficado um tempo na montanha e que agora talvez devesse voltar pra casa. Sem encontrar alternativa no momento, resolvem que vão comprar um brinquedo igual e presenteá-la no Natal, que está próximo.

“O primo diz que quer ir até a montanha levar um presente para ela; ele está triste com a sua ausência e não gosta de saber que ela está lá sozinha, ele não gostaria de estar nessa situação, se sentiria muito sozinho, com medo e triste. Ele vai até o alto da montanha para levar-lhe o presente e ela o recebe sem muito entusiasmo... O primo procura conversar com ela, entendê-la, agradá-la, busca uma aproximação, mas ela o trata de forma fria, não fala com ele e o ignora. Ele deixa o presente e volta para casa, dizendo que ela não quer conversa com ele. Queria o brinquedo dele, mas parece que dar um pra ela não a tinha deixado satisfeita, ela era uma chata! Ele achava inclusive que ela nem estava sofrendo lá na montanha, parecia a mesma de sempre.”

Este solilóquio do primo é ouvido silenciosamente pela criança e aí ela orienta quanto ao desfecho da história: *“Chega o Natal e a mãe lhe dá o presente. Ela fica muito feliz e a história se encerra.”*

A cena dramática representa aspectos conflituosos e contraditórios nos quais a criança vive, tanto nas relações familiares, quanto com ela mesma. Ela

representa o papel da filha que enfrenta e ‘envergonha’ os pais, e a que deseja o que o primo tem. Esse tema do ‘desejar o que não tem’, se repetia em outras histórias dessa criança e ela sempre buscava a cumplicidade materna, em vão. O psicoterapeuta poderia ter utilizado outras técnicas, mas optou por seguir o movimento da criança nesse desfecho, considerando alguns aspectos do processo psicoterápico, tais como sua posição sociométrica na família e presença de relações mais transferenciais com algumas pessoas da sua rede social. No “como se” ela pode jogar o papel da menina que vive numa ambiguidade entre ser a malvada e desconsiderada, querida e preterida, mas que precisava de um final positivo, vitorioso. Ela o teve e depois ouviu o compartilhar do primo (terapeuta no papel psicodramático dele), que mostrava sua ambiguidade.

Outro exemplo da técnica do duplo espelho, agora com uma criança maior, de dez anos.

No início da sessão, Clara diz que quer inventar um jogo. Construímos um de tabuleiro que ocupa a sala toda. Cria um jogo em que está presente apenas o fator ‘sorte’ (jogo de dados). – diverte-se com essa proposta; seu objetivo parece que é poder compartilhar, mostrar seu potencial criativo e experimentar situações diversas.

As almofadas representam as “casas” e são organizadas por cores diferentes. Cada cor tem um significado (vermelha, joga novamente; bege, volta uma casa; cor de rosa, salta duas casas; preta, volta ao início do jogo; laranja, fica parado uma jogada, etc). Sobre algumas almofadas/casas, há uma determinação: você ganhou um kit beleza; você ganhou uma viagem; você ganhou um monte de tarefas para fazer.

O jogo consiste em ir jogando o dado de cores e seguir até o seu ponto final; quem chega primeiro é o vencedor.

Parte da sessão é destinada à elaboração e construção do jogo. Toda a construção do jogo é um aquecimento para a ação de jogar, como uma ação dramática.

Após tudo pronto, partimos para a ação dramática. Ela define que será uma garota de 15 anos e eu de 16. Seu desejo é explorar os aspectos femininos e para tal ela escolhe garotas mais velhas para jogarem – um jogo simbólico. Entramos no papel psicodramático e as duas garotas jogam. A exploração é vivida conforme cada dado é jogado e os desafios lançados: ir pra frente, para trás, aguardar, ganhar, perder, tal quais os movimentos da vida.

Entra no papel e se empolga com as jogadas, fala com voz um pouco diferente, “mais moça”, disputa com a adversária com uma espécie de ‘classe’, e sempre que vence fica muito entusiasmada. O jogo entre as duas garotas continua até o final da sessão. O papel desempenhado pelo diretor, que é semelhante ao da criança, possibilita que ele utilize a técnica de duplo e espelho. No papel psicodramático ele também faz a garota mais velha que se exhibe para a outra, que aprecia seu corpo, suas habilidades e personalidade – como duplo traz alguns aspectos que até então não haviam sido identificados, e como espelho possibilita que a criança visualize o que vai trazendo por meio dessa relação.

Quando o psicoterapeuta assume um papel psicodramático semelhante ao da criança (nesse caso, um ano mais velha não fazia diferença significativa), possibilita que ele faça uso da técnica de duplo e espelho, sem que haja necessidade de demarcar a utilização das mesmas. É um estar junto com a

criança, acompanhando cada um de seus movimentos, habilidades, dificuldades, inseguranças, confiança, etc. É semelhante a ela ditar o *script* do papel, porém, isso vai ocorrendo na cena dramática, no próprio desempenho dos papéis. Em sintonia com ela, o psicoterapeuta traz novos conteúdos que são mais difíceis de serem identificados e assim atua como duplo. Quando reconhece o que ela faz, em seu papel psicodramático, e atua tal qual, possibilita que ela se espelhe.

Para essa menina, poder experimentar o “salto” de casa em casa é uma forma de vivenciar simbolicamente o que faz no cotidiano: divide-se entre a casa da avó, do pai e do namorado da mãe; tem que estar pronta para ir e vir sempre que se faz necessário e não é ela quem escolhe para onde vai, sua rotina é cheia de surpresas. Esse é um papel que tem desempenhado há anos e que nesse momento necessita ser mais desenvolvido porque se acrescentou mais uma casa no seu contexto social. Quais as novas demandas? Como é estar numa casa onde há namoro? Como lidar com sua sexualidade? Todas essas questões estavam presentes e ela buscava lidar com cada uma da melhor forma que conseguia, porém, a ansiedade se impunha sempre. Além disso, a mãe assumiu um novo papel (de namorada) e ela precisava aprender a relacionar-se com essa ‘nova’ mãe apaixonada, que dividia sua atenção com o novo parceiro. A sociometria familiar mudou e seu papel social de filha tinha novas demandas. Deixar de ser menina para ser mulher (ou filha pequena para filha crescida) era algo a aprender, e jogar esse papel foi uma forma que encontrou naquele momento.

Na próxima descrição, ressalto o uso da técnica da interpolação de resistência. Segundo Gonçalves (1988), Moreno utilizou o nome interpolação de resistência para vários procedimentos técnicos, que têm em comum o fato de

visarem “contrariar” disposições conscientes e rígidas do protagonista. Possibilita ao paciente ter acesso a novos pontos de vista, maior flexibilidade em suas posições relacionais e buscar caminhos mais produtivos para sua tele-sensibilidade. Em uma de suas aplicações, Moreno (1978, p. 215) afirma: “A *terapia da resistência* ou através da técnica de “interpolação de resistência”, que descrevi aqui, não se aplica apenas às resistências *internas* do paciente. Ela se situa no campo dos acontecimentos concretos. Trata-se das resistências *entre* o indivíduo e seu ou seus parceiros: as *resistências interpessoais*. (...)”.

Calvente (1993), discutindo sobre a interpolação de resistência, faz uma revisão histórica do uso dessa técnica na obra de Moreno. Conclui que o uso da técnica esteve presente no trabalho de Moreno, no período mais inicial do psicodrama terapêutico. Quando Moreno verifica que para o desempenho do papel psicodramático o aquecimento era imprescindível, deixa de mencionar o uso da técnica tal como a utilizava anteriormente, resistências ligadas ao papel ou à cena. Além disso, Calvente reflete, dentre outras coisas que o nome resistência não é muito apropriado, já que o objetivo da técnica era de encontrar novos caminhos para que a criatividade se manifestasse.

Calvente (1993) aborda a dificuldade em pensar como interpolar (que significa colocar entre dois pólos, ou seja, entre papel e “contrapapel”) “*uma resistência para favorecer a expressão da espontaneidade e da criatividade*” (p. 130). Assim, sugere que o nome mais apropriado para a técnica, seja interpolação de aquecimento, porque esse é o foco – criar outras condições para revelar o bloqueio do protagonista. O termo interpolação de aquecimento não tem sido empregado pelos psicodramatistas e a ‘interpolação de resistência’ se manteve como referência dessa técnica.

Essas reflexões do autor são pertinentes ao uso da técnica na sessão com a criança que trarei, pois teve a função de fazer uma “interpolação de aquecimento”, com o objetivo de trazê-la para o papel psicodramático. Sua atitude com o psicoterapeuta era semelhante à que tinha com os familiares, o que demonstrava nesse momento que não havia tele na relação.

Giovanna, nove anos, entra na sala de psicoterapia com um gibi (Turma da Mônica), senta-se numa poltrona e fica lendo sem nem mesmo olhar para a psicoterapeuta. Espero e digo um tempo depois que parece que a brincadeira de hoje é ela me ignorar... Ela sorri, mas não tira os olhos do gibi. Pergunto se não há outra atividade onde eu possa ser incluída e ela responde que sim, que poderia pegar outro gibi e lê-lo. Havia ironia em sua voz e sua postura era de despeito. Aguardo um pouco mais e sugiro que ao invés de me manter no papel de terapeuta, assumirei o papel de sua irmã mais velha. A sugestão ocorreu porque entendia que a criança mantinha esse distanciamento por resistir a entrar em contato com sua história e as pessoas do seu átomo social, isso era recorrente.

Ela tem bom relacionamento com a irmã mais velha e considereei que era uma pessoa adequada a ser trazida naquele momento.

Aqueço-me para o papel psicodramático de sua irmã e busco contato. Rapidamente ela muda de postura, ficando mais distante ainda. A irmã pede atenção e não encontrando, provoca-a, ameaçando roubar-lhe o gibi. Por meio do papel psicodramático o terapeuta usa a técnica de interpolação de resistência.

Depois que desempenhei o papel de sua irmã mais velha, ela respondeu ríspidamente dizendo que fiz uma imitação barata da irmã. Saio do papel e digo que agora serei sua irmãzinha menor, porém, um pouquinho maior porque já conseguiria me comunicar com ela.

Psicoterapeuta estava em processo de aquecimento.

Assumo o papel da Irmã menor e pergunto se quer brincar comigo. Ela diz que não e que não é para interromper sua leitura. A irmãzinha diz que vai pegar alguns brinquedos. Ela chama a irmã para brincar, mexe em seu gibi e solicita

sua atenção. Giovanna levanta-se da poltrona, grita com a irmãzinha e diz que não é para ela encher o seu saco!

Nesse momento ela já passou para o contexto dramático e está no papel psicodramático de irmã.

A irmãzinha a ignora e continua pedindo sua atenção; então, ela toma o brinquedo da irmãzinha, faz uma barreira de almofadas no meio da sala, depois faz uma espécie de cerco pequeno e coloca a irmãzinha lá dentro. Olha muito brava para ela e diz: - Não saia daí senão você vai apanhar! A menininha ameaça sair e ela vem rapidamente e bate nela com um taco (bate forte e é preciso interromper a cena e marcar que tem que ser de mentirinha, 'faz de conta'). Ela continua batendo (agora com cuidado, no 'como se'). A irmã chora, faz cara de triste, de desgosto... Ela diz: - Pode ficar emburrada que eu não ligo! O cerco está próximo do armário de brinquedos, a irmãzinha tenta pegar um brinquedo e ela corre e impede, cercando com mais almofadas. O cerco é tão pequeno que a irmãzinha mal tem espaço para se mexer. Ela levanta o taco e diz que se fizer qualquer movimento ou som vai apanhar. Em seguida afirma: - Eu não faria isso na vida real!

A criança passou para o contexto social, confirmando para o terapeuta que estava no 'como se' e que sabia que aquela atitude era proibida. Ao mesmo tempo, estava envolvida na história e no papel psicodramático, demonstrando claramente que queria continuar jogando esse papel. Ela estava aquecida, mas parecia que precisava da confirmação do terapeuta de que estava 'autorizada' a se manifestar daquela forma.

Interrompo a cena (fazendo sinal de "tempo!") e digo que agora chegará a mãe em casa. Ela fica entusiasmada. Assumo o papel da mãe e chego em casa. Ao entrar, a mãe é recebida com agressividade quando questiona sobre o que aconteceu. Ela começa a bater na mãe, ameaça-a, vai esfaqueando no braço a cada manifestação. Bate muito, esfaqueia muito, impede a mãe de falar, coloca-a sentada no sofá sob ameaças. Novamente repete: - Eu não faria isso na vida real!

Cena interrompida novamente; deixo uma almofada representando a mãe, tal como tinha feito com irmãzinha e assumo o papel do pai. O pai, depois de ter

que arrombar a porta porque ninguém lhe atendia, tem uma postura mais indignada e firme com a situação, porém, ela interrompe a cena e diz que não é assim a história. Peço então para trocarmos de papel para ela mostrar como é que o pai faria.

Ela não aceitou e entendi que nesse momento necessitava manter a história daquela forma: ela punia todos e não conseguia estar no lugar do outro.

O mesmo ocorre com o pai, agora mais passivo: agressões múltiplas tanto de forma física, quanto verbal. Ele fica ao lado da mãe no sofá. Agora ela já está esperando a chegada da irmã mais velha (e não é preciso interrupção de cena para marcar sua chegada). A irmã chega, reage e antes que tudo se repita, foge. Vai até o hospital onde estagia, trata-se dos ferimentos e quando ainda está lá, Giovanna chega, agora com uma arma de fogo (que é o próprio taco). Leva-a para casa, dá muitos tiros (dizendo que nenhum matava) e pergunta à irmã para quem ela tinha contado a história. A irmã diz que todos no hospital sabiam. Giovanna, depois de trancar a porta de casa, retorna ao hospital e metralha todos, diz que todo mundo morreu. Volta para casa e retoma as ameaças a todos. Estamos no final do tempo e digo que precisamos finalizar a história.

O término da dramatização não é necessariamente chegar a um 'final', mas à finalização do contexto dramático. A interrupção por vezes é demarcada pelo tempo cronológico da sessão. Faltando alguns minutos para o final, o diretor avisa que é preciso 'terminar' a história daquele dia. Muitas vezes, essa mesma história será retomada em outras sessões, funcionando como uma espécie de novela, em 'capítulos'.

Giovanna diz que é assim mesmo que termina, todos presos sob sua ameaça, machucados, sem poderem fazer nenhum movimento nem emitir nenhum som. Mãe, pai e irmã mais velha sentados no sofá e na outra extremidade da sala, num cerco muito pequeno, a irmãzinha. Encerramos a história e ela pede para guardar o gubi na sala porque a história vai continuar na próxima sessão.

A técnica da interpolação de resistência possibilitou que a criança saísse da condição que se impunha, inclusive na sessão psicoterápica, de não entrar em contato e conter sempre seus impulsos mais agressivos e sua raiva. A

primeira história do gibi era da personagem Mônica, que tem como característica conhecida, ser brava. Considero que essa leitura foi um aquecimento inespecífico para a dramatização. Quando o psicoterapeuta assume o primeiro papel psicodramático, o da irmã mais velha, ambos estão se aquecendo mais especificamente para a ação dramática. Importante ressaltar que não foi necessário demarcar concretamente o cenário, o contexto dramático foi se instalando à medida que o psicoterapeuta diz para a criança que irá assumir um papel psicodramático. Isso é possível porque Giovanna já tem dez anos e se nos remetermos às etapas da Matriz de Identidade, verificamos que ela já as percorreu e tem capacidade cognitiva e emocional para compreender e lidar com situações abstratas e discerni-las.

À medida que a cena se desenvolvia, a criança foi se aquecendo cada vez mais e o contexto dramático se impôs. Toda a sala era cenário. Quando ela demarcou o local em que a irmãzinha devia ficar, não importava que lugar era, mas que deveria ser longe de qualquer coisa e ela devia sofrer também, ficar sem brinquedos, sem relação com ninguém. A mãe foi punida quase da mesma forma; não houve piedade para com ela. Ela introduziu a faca para agredir a mãe e os cortes foram nas mãos e braços; o cenário era claramente sua casa, com demarcações do seu quarto e sala. O pai foi o que teve mais dificuldade para chegar, precisando telefonar, interfonar e depois arrombar a porta (sugestões dela), simbolizando possivelmente que não morava mais lá (pais separados) e as negociações difíceis que tem com a ex-esposa relacionadas às visitas. O pai foi muito agredido, apanhou com o taco e também muito esfaqueado nos braços, mãos, barriga e boca.

A irmã mais velha também foi punida, mas com menor intensidade. A arma era de fogo, que não mata, como de festim. Houve certo tom lúdico na briga com ela. Sua relação com essa irmã era boa, apesar da diferença de idade. Ela se mantinha distante em função da faculdade e talvez, eliminar todos do hospital possa significar sua ira diante disso.

A vida familiar nos últimos anos foi de intensa mudança para Giovanna. Um terceiro casamento da mãe ocorreu logo após a separação dos seus pais, e a gravidez da irmãzinha veio logo em seguida. A mãe não alegou ciúmes da parte dela, ao contrário, era sempre carinhosa e companheira. Porém, o tempo destinado a ela quase não existia mais e parecia que a mãe não se ocupava nem percebia o que acontecia com essa filha. Giovanna reagia a essa situação de forma contida, com apatia. Poder entrar em contato com suas emoções, tais como a raiva, tristeza, medo e o ciúme, e expressá-las no contexto dramático foram importantes para o processo de elaboração desses conteúdos presentes no seu cotidiano familiar (Souza, 1999, 2000; Filipini, 2003, 2005a). São muitas mudanças e algumas, tais como as novas relações amorosas dos pais, são compreendidas e até mesmo aceitas, porém, não significa que sejam fáceis de lidar (Souza, 2006). Quanto às relações fraternas, cada uma traz sua vicissitude; a irmã mais velha se afasta para cuidar de sua vida e a mais nova vem ocupar um lugar que há pouco lhe pertencia, sentimentos de ciúmes, raiva, tristeza se apresentaram e precisaram de um lugar de expressão (Goldsmid e Feres-Carneiro, 2007, 2011).

As sessões anteriores continham uma cena em que ela se ‘enterrava’ nas almofadas, que representavam uma espécie de pântano e alguém passava e via aquela criança caída lá dentro. Tentava salvá-la a todo custo - puxava pelas

mãos, jogava uma corda, mas tudo em vão. Após muitas tentativas esse ‘salvador’ conseguia e aí saía do pântano um monstro. A história acabava aí. Inquerida sobre o monstro, dizia que a sujeira do pântano a tinha transformado naquilo. Na sessão aqui relatada, o ‘monstro’ se manifestou e depois foi preciso cuidar dele para trazer a criança de volta.

Divórcio e novos casamentos são comuns na família contemporânea e as crianças têm condições de transitar por essas mudanças de forma saudável, o que não significa que deixarão de reagir (Sousa, 1999, 2006; Filipini, 2003, 2005c, 2009). Giovanna percebia que seu átomo social mudara, a família mudou, novas pessoas foram introduzidas e ela ainda estava se adaptando às mudanças. Como sempre foi uma menina bem comportada e cordata, era difícil expressar sentimentos contrários a isso. Seu lugar na família mudou, deixou de ser a caçulinha e tinha que desenvolver o papel de filha do meio. Além disso, como filha, relacionava-se com um pai que estava mais distante, precisava viajar para vê-lo e dividi-lo com a nova parceira. A mãe estava apaixonada e vivia uma nova relação amorosa com o marido atual e um bebê. Tudo isso gerava sentimentos variados, mas não considerados positivos para ela: raiva principalmente, que a transformava no monstro que foi gerado pelas ‘sujeiras do pântano’.

Como irmã, também era difícil. A caçulinha roubava-lhe o lugar e a atenção materna. A mais velha se afastava para cuidar de si mesma. Também eram mudanças que necessitavam que ela desenvolvesse novos aspectos do seu papel de irmã diante dessa reconfiguração sociométrica. Esse processo começou com a identificação de sentimentos como a raiva e sua expressão no contexto dramático. Romper com as normas, com os limites e padrões de

condutas sociais de forma protegida, no ‘como se’, possibilitou à criança experimentar outra forma de relação com seus contrapapéis, mais espontânea. A demanda atual dos papéis sociais é grande e poder jogar esses papéis com mais espontaneidade é auxiliá-la nesse momento de transição familiar.

Gonçalves (1988) aponta para o cuidado que o terapeuta deve ter para não complementar ou reforçar papéis sádicos ou masoquistas da criança. Considerar que determinados comportamentos são assim constituídos, é uma interpretação ou compreensão do terapeuta que estará baseada no conhecimento que o terapeuta tem dessa criança.

Um dos aspectos favoráveis do papel psicodramático é que nele não existe “certo ou errado”; não há uma regra pré-estabelecida. E é exatamente por também poder “romper” com as normas sociais, que possibilita a criança de fato a adentrar no contexto dramático, no ‘como se’. Se ela é “sádica” naquele momento, é porque tem demanda para que isso seja vivido no ‘como se’. E é por meio do contrapapel que ela também poderá entrar em contato com esses seus aspectos. Por isso a etapa do compartilhar, que será discutida a seguir, é importante. Na relação, seus aspectos mais sádicos, masoquistas, bondosos, medrosos, etc. serão vividos. E é naquela relação; ela não é aquilo; esse é um aspecto do seu Eu e que se faz presente em determinada(s) relação (ões).

Da mesma forma, discordo de Petrilli (2000) quando diz que jogar papéis é lúdico, recomendável, terapêutico, mas não suficiente para determinados estados psicopatológicos e de desenvolvimento. Compreendo que esse é o melhor caminho para se auxiliar a criança a entrar em contato com seus conflitos, identificá-los e buscar recursos para a resolução dos mesmos. Como já mencionei anteriormente, nem sempre uma criança joga papéis, seja por falta de

aquecimento, por dificuldades de ordem orgânica, cognitiva ou emocional. Entretanto, a ação dramática ocorre quando há um projeto dramático comum. E esse projeto mantém criança e psicoterapeuta aquecidos ao longo do processo psicoterapêutico, podendo alcançar o desempenho de papéis psicodramáticos.

No 'como se', nem sempre o diretor tem clareza, compreensão racional do que está acontecendo naquele momento, naquela história. Porém, a riqueza desse momento não está no "saber" intelectual do diretor, mas na sua disponibilidade de jogar os contrapapéis e viver com a criança aquele momento. Isso não é 'apenas um brincar', é construir com ela um momento em que o consciente e inconsciente de cada um está presente. As relações se estabelecem e emoções são liberadas para serem ou não integradas. É a possibilidade do *Encontro* moreniano. A coconstrução do drama direciona-se para o interpósíquico, ou inter-relacional, mas não fecha as portas ao intrapsíquico, já que são faces da mesma moeda (Almeida,1994).

É "sustentar a relação" paciente- terapeuta, ao invés das interpretações; acolher o relacional, como assinalou Almeida (1994). A ação cênica, seja ela de histórias reais ou imaginárias, concretas ou metafóricas, resulta numa atitude criadora para a vida. É trabalhar com a imaginação como possibilidade de mudança do mundo, a partir do sujeito.

Ainda com o intuito de ilustrar e discutir as possibilidades da prática psicoterápica com crianças relatarei o exemplo de uma sessão em que a criança escolheu fazer um desenho como primeira atividade e que, por sua qualidade expressiva, pode ser um bom iniciador mental para aquecer a criança a entrar no papel psicodramático e o uso da técnica do duplo espelho.

Ingrid, 8 anos, faz um desenho (aquecimento inespecífico), conta uma história sobre ele (aquecimento específico) e depois jogamos papéis psicodramáticos a partir da história (dramatização).

“Essa é uma árvore chamada esquisita, é achatadinha. O tronco dela... E todo mundo fala que ela é esquisita. Ela fica triste e não faz nada com isso. Ela está triste. Ela vê todas as árvores bonitas e ela se acha feia.”

A árvore está no centro do desenho, é a maior figura e a criança no seu relato, traz algumas de suas características. Desta forma, ela é reconhecida pelo terapeuta como personagem central no desenho. Buscando explorá-la no percurso da história, o terapeuta diz que vai fazer de conta que é a árvore e em seguida assume papel psicodramático e começa a conversar com outro personagem, uma menina, e ela assume esse papel psicodramático.

árvore: Eu sou muito feia, esquisita, estou aqui no meio do jardim, sozinha e triste... Diga o que é que está feio em mim.

A pergunta possibilita que a criança observe com distanciamento suas outras características, como num espelho.

menina: Você não é muito feia...

a: Ah, sou sim, todos falam que sou esquisita...O que é mais esquisito em mim?

m: Bom, eu gosto das suas folhinhas...

a: Mas, e o meu tronco? Ele é muito esquisito, eu não gosto dele...

m: Ah, ele não é tão feio assim... Eu não gosto do meu cabelo.

Aqui a criança passou a mão em seu cabelo e traz aspectos do papel social para o dramático. Dialoga com a árvore no papel psicodramático, porém, com conteúdos do papel social.

a: Por quê? Ele é tão bonito!

m: Ele é armado, não vou tirar a tiara nunca!

a: Armado? Não parece, o meu até que é achatadinho, por isso que você gosta dele, não é?

m: É...o da minha irmã é bem lisinho.

a: Ah, achatadinho como o meu...Mas o seu não é encaracolado!

m: Eu sei, mas é muito preto e armado. Minha mãe tem cabelo loiro.

a: Você gosta do cabelo dela?

m: Gosto muito. O da minha irmã é quase loiro, é castanho claro. Ele é mais parecido com o a da minha mãe...bem lisinho e claro. Ela tem quatro anos e fica aprendendo todas as coisas comigo. É assim né: quando eu nasci, não tinha ninguém pra eu aprender, então, eu fui aprender a escrever só com cinco anos, quando eu fui pra escola. Escrevia meu nome, da mamãe e do papai. Minha irmã tem quatro anos e já sabe escrever essas coisas porque ela aprende comigo. Quando tem um irmão mais velho o outro vai aprendendo com a gente, né?!

a: Acho que sim, parece que ter irmão pode ser bom, mas eu estou sozinha aqui...

m: Não está não, tem a borboletinha aqui, sua amiga. Sabe que eu fui pra uma escola nova e estava muito triste porque não tinha ninguém lá, estava sozinha. Aí apareceu a Bia e eu fiquei amiga dela, mas eu dizia que estava triste ainda porque só tinha uma amiga. Ela me falou que era assim mesmo com todo mundo, primeiro a gente arruma uma amiga, depois vai arrumando outra.

a: Poxa você também aprendeu uma coisa legal com a sua amiga!,

m: É mesmo, e agora eu tenho outra amiga e nós andamos sempre juntas, somos as três maricotas

a: Que bom, aí você ficou menos triste porque agora tem amigas. (...)

No diálogo com a personagem árvore, no contexto dramático, a criança pôde se expressar com espontaneidade. Primeiro ela apresentou características da árvore que, pelos dados que se tinha da criança, também compunham parte

de características de seu Eu, dessa forma, o diretor ao assumir o papel de árvore, pôde realizar um duplo para a criança. Era um diálogo dela consigo mesma, por meio de um personagem. A técnica utilizada foi a de duplo e espelho. Duplo porque mantém um diálogo que vai trazendo novos conteúdos e espelho porque o diretor mantém as características indicadas anteriormente e possibilita à criança perceber aspectos que até então estavam mais difíceis de serem reconhecidos. Os novos conteúdos foram trazidos espontaneamente pela criança, ou seja, a quantidade e qualidade deles foram escolhas dela. Não foi utilizada a inversão de papéis pelo fato de que isso não era necessário: como o personagem árvore foi criado por ela, consideramos que contém aspectos seus e por isso a técnica foi somente o duplo e o espelho.

A criança pôde entrar em contato com aspectos que estavam difíceis de serem reconhecidos e elaborados nessa cena. Ela se apresentou como esquisita, feia, solitária, em desvantagem na relação fraterna. Dessa forma, sentia-se desprivilegiada no átomo familiar – a irmã se apresentava mais graciosa já que era mais parecida com a mãe e mais esperta (aprendendo com ela várias coisas), o que devia agradar aos pais e ser garantia de atenção, de amor.

Sua necessidade de confirmação mostra que seus papéis sociais de filha e irmã precisam ser mais desenvolvidos, ela fica insegura e ansiosa na família. Quando entrou em contato com isso, por meio do personagem árvore, pôde reconhecer alguns dos aspectos que contribuem para sua insegurança e ansiedade (ciúmes e inveja da irmã porque acha que seus atributos a fazem ser mais amada) e ao mesmo tempo também reconheceu que tem esses mesmos

privilégios na relação com as amigas (que também lhe ensinam coisas e a inserem no grupo privilegiado das ‘maricotas’).

Podemos compreender que essa sessão a auxiliou, em especial, a entrar em contato com seu papel social de irmã. O papel psicodramático (árvore) favoreceu a espontaneidade e ela pôde confirmar para si mesma que não era tão esquisita quanto se apresentava. Tem ciúmes da relação da mãe com a irmã, mas por outro lado, agora tem amigas que lhe fazem companhia e dão o conforto necessário para ficar bem na escola. Moreno cita que “(...) *O status psicológico dos indivíduos pode ser chamado de seus níveis de consciência sociométrica*” (1972, p. 84). Para essa criança, compreender o lugar que ocupa na família e nas outras relações sociais lhe traz segurança e mais tranquilidade.

Outras técnicas do psicodrama podem ser utilizadas com as crianças e relato, a seguir, uma sessão de Pedro, nove anos, em que a técnica da inversão de papéis foi utilizada.

“Inicia a sessão contando que fez provas escolares e tirou notas boas. Relata um episódio que sua mãe lhe contou: quando ela era criança tirou um zero em matemática. Primeiro ela omitiu e mentiu para sua mãe, mas quando esta soube, disse que iria apanhar por dois motivos: ter mentido e tirado o zero. Apanhou de cordão de ferro de passar roupa e teve que ficar de shorts para mostrar as marcas. Ele comenta que a avó foi severa, mas ao mesmo tempo deixa uma sensação de que achou o castigo merecido.

Pede para começarmos a história. Definimos o cenário e entramos no contexto dramático:

Afonsinho tem uma corrida decisiva – ou ganha ou terá que sair da equipe. Ele perde. Enquanto está na pista peço um solilóquio.

Ele pode revelar em voz alta o que pensa ou sente nesse papel. O 'monólogo' favorece que aflorem sentimentos e ideias que não surgiram antes, aspectos que se encontravam mais passivos ou paralisados.

A- Droga, esse carro foi quebrar, agora tenho que sair da equipe.

Vai até o Zequinha que é o dono da equipe (eu faço o papel do Zequinha, por solicitação da criança). Ele vem todo tristonho e cabisbaixo:

A- Bom Zequinha, eu perdi, você viu o que aconteceu, então me dê aqui a rescisão do contrato (estende a mão).

Solicito uma inversão de papéis. Com dez anos, a inversão de papéis pode e deve ser utilizada sempre que possível com a criança. Como visto nas sessões com crianças menores, é comum que elas determinem os papéis que o psicoterapeuta irá desempenhar e geralmente elas assumem o papel do protagonista e o psicoterapeuta todos os outros. Com Pedro não foi diferente, porém, sempre que há na cena algo importante ou determinante na sua condução, solicitar a inversão de papel se faz necessário. E nessa história fica claro que o psicoterapeuta, como ego-auxiliar, não tinha elementos suficientes para desempenhar o papel psicodramático sem realizar a inversão em determinados momentos.

(Pedro no papel de Zequinha): - Tudo bem Afonsinho, aqui está a rescisão do contrato, mas eu vou te contar um segredo: o carro tem um problema crônico no motor, então não foi culpa sua. Mas como você não tem sentimento de culpa, nós mentimos para você, para você ficar com culpa.

Peço novamente a inversão de papéis.

A.: - Ah é, pois tome então!: saca de uma arma e atira no Zequinha.

Afonsinho sai, fugindo. A secretária de Zequinha vê, chama um segurança, ligam para a polícia que pede para isolar a área. Ele faz papel da secretária e eu do segurança e da polícia que atende ao telefone. Encerramos esta cena: o local do crime está cercado com faixas de isolamento.

Afonsinho está escondido no meio de caixas. Vou até lá e peço um solilóquio.

O terapeuta transita entre ser ego-auxiliar, assumindo papéis psicodramáticos e diretor de cena.

A.: - Puxa, matei o meu amigo e agora não tenho uma equipe.

A polícia está atrás dele e em seguida ela chega.

Polícia: - Você é o Afonsinho? Ele dá documentos falsos que não convencem a polícia. Está preso e tem o direito de permanecer calado...

Afonsinho é preso, mas Lorena (sua atual esposa) paga sua fiança. Lorena pede explicações e ele conta; sua preocupação agora é arrumar outra equipe.

A criança vai criando a história no percurso da mesma e por vezes faz uma espécie de narração, pois ela é longa e elaborada – não haveria tempo hábil para dramatizá-la por completo.

Psicoterapeuta, no papel de diretor, solicita um tempo na história e diz que ele terá que ser julgado pelo crime que cometeu. Diretor traz um aspecto de realidade à história, possibilitando que ela entre em contato e verifique seus limites, alcances, sensações e conflitos que possam emergir. Pedro diz que ele foi absolvido por falta de provas. Retruco, e ele contrariado:

Pedro: - Mas na minha história pode, é assim mesmo.

Apesar da insistência do psicoterapeuta em aproximá-lo de elementos supostamente mais compatíveis com a realidade, a criança não aceita. Diante disso, cabe ao diretor respeitar essa decisão, trata-se de uma história criada espontaneamente e a sua 'coerência' no contexto dramático está baseada nas necessidades da criança.

Afonsinho sai em busca de outra equipe e vai para a do Paul Newman. Há toda uma recepção a ele – muito calorosa e uma corrida importante. Afonsinho ganha e todos fazem muita festa para ele. Lorena, o pessoal da equipe, todos os seus fãs e principalmente seus pais em São Paulo: Zé e Maria choram de felicidade (ele desempenha esses papéis).

Em diversos momentos peço solilóquios para Afonsinho e ele chora de felicidade e emoção da vitória; diz que vai dar uma entrevista para Globo. Preparamos o cenário: será uma entrevista individual que depois irá ao vídeo. Eu sou o repórter:

R – Como está se sentindo com essa vitória?

A – Muito feliz, aliviado, porque eu só vinha perdendo e agora consegui essa vitória.

R – Pois é, nós sabemos que você passou por um período difícil há pouco tempo – foi suspeito da morte do Zequinha, o dono da sua equipe anterior...

A – (com a voz “embargada” e chorando) Oh, eu tenho uma coisa pra confessar: fui eu que matei o Zequinha... choro...

R – Mas Afonsinho, essa é uma confissão muito séria, você sabe no que isto pode implicar?

A – Sim, eu sei...

Pedro se levanta e diz que Afonsinho foi condenado a três anos de prisão, mas teve que cumprir apenas um. Encerra-se a história e a sessão. Ele comenta: É, essa história começou triste e terminou triste.

Algumas características dessa sessão: foi Pedro quem distribuiu os papéis, foi dando a direção da história e é possível que inverta papéis, bem como faça solilóquios a partir dos mesmos. Os sentimentos que surgiram nessa história tais como culpa, raiva e tristeza, que se misturaram à alegria, mentiras e punição, foram recorrentes durante o período próximo à separação dos seus pais. Esses sentimentos são comuns e esperados como reação das crianças diante da separação ou divórcio parental (Souza, 1999, Filipini, 2003). O personagem Afonsinho representava os sentimentos ambíguos de Pedro em relação a diversas situações que vivia: ora sentia amor, ora ódio dos pais. E nessa ambiguidade os sentimentos de culpa comumente apareciam. No entanto, Pedro tinha grande dificuldade em conter seus impulsos e desejos, compreender e aceitar os limites alheios e os que a realidade lhe impunha. Nessa época morava com a mãe (obteve a guarda), mas queria muito ir para a casa do pai. Diante dessa condição criava diversas situações de conflito com sua mãe e cobrava do

pai atenção constante. Acredito que a fala do personagem Zequinha: “(...) *mas como você não tem sentimento de culpa, nós mentimos para você, para você ficar com culpa*”, esteja associado ao contexto conflituoso que vivia nesse papel de filho de pais separados.

É fato que nos solilóquios e mesmo nas inversões de papéis sua capacidade de entrar mais profundamente em contato com seus sentimentos não é tão grande. Isso se relaciona ao que Tassinari (1990) compreende como o processo de inversão: associado ao desenvolvimento de papéis. Pedro joga, desempenha bem os papéis, mas pouco cria a partir deles. Apesar da sua idade, apresenta algumas dificuldades de ordem socioafetiva e tem alguns comportamentos mais estereotipados. Isso dificulta seu processo criativo ao desempenhar papéis; por isso fiz a associação com a autora: Pedro já tem a capacidade de inversão, mas está aprendendo como se faz.

Porém, cabe um olhar para todo o conteúdo da história donde podemos sugerir algumas questões que puderam ser vivenciadas:

- As transgressões (mãe que omite e mente) podem levar a severas punições (surra de cordão); paralelamente: raiva incontrolada (Afonsinho perde e é ludibriado) pode gerar transgressão (mata o amigo), que por sua vez gera punição (é preso). Presença dos sentimentos de tristeza (as perdas), medo (punições) e raiva (da mãe porque foi mal na prova e mentiu, da avó porque foi severa, do Zequinha, porque mentiu). A raiva da mãe também pode ser associada a um fato comum entre as crianças de pais separados: a criança tem raiva da mãe (normalmente é ela que detém a guarda). Ao mesmo tempo, percebe o sofrimento da mãe e a ambiguidade de sentimentos se instala.

- É preciso desenvolver bem um papel para se apropriar dos seus atos, responsabilizar-se. Num primeiro momento Afonsinho foge da polícia, depois, quando se sente reconhecido e autorizado nesse papel (ganhou a corrida, seus familiares o valorizaram e se emocionaram com ele), p^ôde se responsabilizar e acatar as consequências de seu ato (sua confissão em vídeo). Presença de culpa (confissão) e tristeza (o seu choro) também foram sentimentos experimentados na história do Afonsinho.

Por meio do personagem Afonsinho, Pedro p^ôde vivenciar nesse período (foram muitas histórias com conteúdos semelhantes) sentimentos que são comuns às crianças quando vivenciam um processo de separação parental. Tristeza pela separação – perde-se uma condição que a princípio é considerada boa para a criança; raiva pela impotência em impedir que a separação ocorresse, bem como raiva dos pais ou de um deles; culpa (normalmente em crianças menores) perante a onipotência em se considerarem os causadores da separação: talvez o defeito “crônico” do carro representasse sua própria limitação para compreender alguns fatos; medo do que virá: as mudanças todas que ocorrem em função das perdas e dessa nova condição familiar.

Gonçalves (1988) analisa que as crianças rapidamente aprendem a usar as técnicas psicodramáticas e de alguma forma as utilizam a seu favor ou “contra” o terapeuta. Ela exemplifica essa questão com a experiência de Jonatham, filho de Moreno e Zerka, que negocia com a mãe por meio do papel psicodramático. Não vejo isso como um problema. De fato a criança apreende rapidamente as técnicas, mas não é a técnica que importa, mas o porquê ela

precisa fazer uso disso naquele momento. Pode ser apenas um *‘acting out’*¹⁰? Compreendo que às vezes, ou inicialmente (aquecimento) é um extravasar de emoções, mas, no contexto dramático isso tem uma função e é esperado que o psicoterapeuta não bloqueie essa ação pelo fato de que ele entende que não é um comportamento adequado. Viver no ‘como se’ o papel de um assassino não vai tornar a criança ‘ruim’; é o mesmo que dizer que brincar de ‘lulinhas’, jogos e desenhos mais agressivos, vai deixar a criança mais agressiva.

Compreendo que em algumas ocasiões é o oposto que ocorre. O que é vivido no ‘como se’ e compartilhado, encontrou um lugar de expressão e pode encontrar um caminho para a vivência dessas emoções e sensações, possibilitando que a espontaneidade seja liberada e a *tele* prevaleça na relação. Se o *Eu* se forma por meio dos papéis e a criança está em plena formação desse *Eu*, jogar papéis é favorecer a espontaneidade e criatividade e a construção de relações mais télicas. É possibilitar que a criança discrimine sua ação nos diferentes papéis e nas diferentes relações. Jogar papéis, inverter trazem para a criança maior, a escolar, a possibilidade de entrar em contato com aspectos do outro e da relação que não tinha antes.

No próximo relato, a sessão do menino Antonio, dez anos, assemelha-se a uma sessão de adultos. Apresento essa sessão para que se verifique a diferença na capacidade de uma criança da mesma idade em representar papéis, e ao mesmo tempo, apresentar a técnica da entrevista, assinalamento, concretização e da inversão de papéis.

¹⁰ “Moreno introduziu em 1928 o termo *acting-out* para expressar o “atuar para fora aquilo que está dentro do paciente”, contrapondo essa ocorrência à representação do papel teatral que é dado do exterior ao ator.” (Gonçalves, 1988, p. 81)

Antonio chegou para a psicoterapia depois de férias escolares. Entrou na sala, dizendo que tinha algo pra me contar. Eventualmente um pensamento o incomodava muito. Pergunta se eu assisto a determinada novela, digo que não, ele conta que teve uma cena em que uma mulher pegou uma faca e matou o marido. Diz que em sua casa tem uma faca igual àquela e que a partir daí começou a ter um pensamento:

Pega a faca, vai até o quarto do pai que está dormindo e o mata. Esse pensamento vem em muitos momentos e ele, por mais que pense em outras coisas, volta.

Psicoterapeuta propõe que isso seja visto dramaticamente; solicita que fique de pé e o aquecimento é iniciado com a construção do cenário, que contém elementos espaciais, temporais, etc. Demarcados os espaços importantes para a cena, o diretor entrevista o protagonista.

A entrevista é uma técnica verbal que consiste no diretor entrevistar o paciente no papel dramático que desempenha. Tem a função de elucidar conteúdos intrapsíquicos, bem como dar subsídios para o ego-auxiliar assumir esse papel e contracenar com o protagonista.

Em que lugar da sala você está quando o pensamento vem?

- aqui sentado no sofá e olhando a tv

Então sente-se aí agora, vai assistindo à tv e vamos ver como é que o pensamento chega.

- ele vem de repente.

Deixe ele vir agora e vai falando alto como ele é e o que vai fazendo com você.

- como assim?

Vai dizendo como é que ele vem à sua cabeça, que coisas diz.

- bom, o pensamento é que eu pego a faca e mato meu pai...

Como você faz isso?

- eu vou até o quarto dele, ele está dormindo e eu dou na barriga dele...

(enquanto fala isso, vai se abaixando, afundando no sofá)

E o que você sente quando esse pensamento vem?

- não sei...

Veja, conforme você foi falando, foi se abaixando, quase ficou deitado no sofá...

O que sentiu?

Nesse momento o diretor fez uso da técnica do assinalamento. O assinalamento é realizado pelo diretor ou ego-auxiliar. É uma técnica verbal que consiste em verbalizar ao paciente, conteúdos que surgem em forma de imagens, movimentos, palavras, expressões gestuais e que colaboram para a compreensão e elucidação do conflito presente.

- não sei... acho que tristeza.

Está certo. Agora eu vou fazer de conta que sou o seu pensamento e vou falando com você. (assumo o papel de pensamento e fico à frente dele, bem próximo)

Aqui é utilizada a técnica da concretização. Trata-se da representação de sensações, emoções, conflitos, ou seja, de abstrações; ou de objetos inanimados, partes corporais, doenças orgânicas, por meio de imagens, movimentos e falas dramáticos. Quem o faz é o próprio indivíduo ou ego-auxiliar, e permite que o conteúdo daquilo que era simbolizado apenas verbalmente, torne-se manifesto.

P: eu estou aqui...lembra da faca da novela? Tem uma lá na cozinha igualzinha, vai lá, pegue-a e vai até o quarto do seu pai. Ele está dormindo, esfaqueia a barriga dele, vai, vai.

A: (calado...)

P: então cara, eu estou aqui só pra te lembrar: pega a faca lá na cozinha, vai até o quarto do seu pai, ele está dormindo, esfaqueia ele na barriga.

A: (calado...)

Aviso que vou sair do papel e voltar a ser a terapeuta.

R: Então Antonio, o pensamento está falando com você e você está quietinho...

A: Estou me distraindo com outra coisa, pensando em outra coisa.

R: E funciona assim?

A: Mais ou menos, na verdade não...mas eu não sei o que fazer, então fico olhando os jogos...

R: Vamos voltar à cena.

Retomo o papel do pensamento.

P: vamos Antonio, não adianta se distrair com outra coisa não, eu estou aqui, vamos, vai lá na cozinha pegar a faca e matar o seu pai.

Ele vai ignorando o pensamento, procura se distrair, olhar a tv, mas o pensamento entra na sua frente, repete sempre a mesma coisa...

Vamos fazer assim: saia do seu lugar e agora você é o pensamento. Aqui usamos a inversão de papéis.

Ele como P: vai pegar a faca e matar seu pai...

Eu no papel de A: (calado... procurando se distrair e ver tv..)

P (A): vai... pega a faca e mata...

A (R): (calado... e afundado no sofá...)

Peço para trocarmos novamente, mas antes digo para ele pensar no que pode fazer agora, no nosso faz de conta, para entender esse pensamento, o que quer fazer com ele além de procurar distrair-se.

O pensamento retoma sua fala.

A: Pode parar porque eu não sou louco. (pensamento continua)

A: Eu não sou louco, N Ã O S O U L O U C O ! (soletra cada letra) . Não quero que você venha, você me deixa triste.

(pensamento insiste um pouco mais)

Saio rapidamente do papel e digo que ele falou coisas importantes agora; peço que as repita e vá dizendo e fazendo o que mais puder.

A: Eu não sou louco, vai embora, vai se ferrar! O meu pai é a pessoa que eu mais amo e não vou fazer isso nunca! Vai embora, vai se ferrar!

A: Se ele fosse alguém eu ia lutar igual o UFC!

Pego uma almofada maior e falo que pode lutar.

Ela vai dando uns golpes com as mãos, chutes e depois a ignora... Retoma o mesmo movimento por vezes e aí pega a almofada e a joga no canto dizendo: Vai se ferrar!

Ele olha pra mim e diz: Meu pai é a pessoa que eu mais amo, como esse pensamento vem? Nesse momento já saiu do contexto dramático e retomamos o contexto grupal.

Eu digo: Às vezes, quando estamos tristes vêm pensamentos desse tipo.

Tem alguma outra coisa te preocupando, ou deixando triste?

A: Não...não sei...

Você tem pensado no seu avô que morreu? (esse foi um dos motivos pelos quais os pais procuraram terapia para ele)

A: Não, ...é aniversário dele dia 02, o da minha avó é dia 03, então eu sempre lembro dele no aniversário dela (hoje é dia 31, faltam 2 dias)

R: Ah, falta bem pouco. Sabia que quando a gente perde alguém que gostamos muito, sempre que tem algo que nos lembra essa pessoa, como o aniversário dela, é comum a gente ficar mais triste?

A: Eu lembro dele sempre que ouço a música (x), só que ela é feliz, mas eu a ouço e parece triste. No dia que meu avô morreu meu pai ficou muito triste. Quando ele chegou em casa eu consolei ele um pouco..., ele estava muito, muito triste.

R: Ah, e no seu pensamento você ia ficar sem pai também.

A: É, mas o meu pai vai viver até 140 anos!

R: É, parece que esse pensamento vem pra te deixar igual ao seu pai, triste, muito triste.

A cena traz a possibilidade da transformação e o corpo é a expressão do *Drama* (Moreno, 1975). Para esse garoto, sair do mental e experimentar no corpo o que o pensamento lhe causava ajudou-o a identificar sentimentos e compreender seu significado no presente. Massaro (1996), discutindo sobre a importância da cena, traz o lugar do *corpo* no psicodrama:

“É no corpo que a espontaneidade se realiza, se expressa. É ele quem me coloca enquanto ser em situação. Na ação, o homem ganha consciência de seu projeto e pode se transformar, (...)” (p. 20).

Para o autor, a conquista simbólica do mundo, intermediada pela linguagem, se faz pelo corpo, pelas sensações e percepções. O corpo funciona como um agente de conhecimento capaz de nos fornecer o imaginário e trazer à tona sentimentos, desejos e, por vezes, realizá-los. Massaro complementa:

“(...) Pela e transcendendo a linguagem, o corpo traz codificações simbólicas oriundas de uma dobra do externo sobre nós mesmos, que nos permite manter relações com as coisas que nos rodeiam. Em outras palavras, os códigos que nos permitem contato com essa realidade externa encontram-se em nosso corpo.” (1996,p. 35).

O corpo em cena funciona como um centro virtual de ações, pois ele simboliza a existência, a realiza; permite a noção de temporalidade porque só se corporifica pelo presente e pelas sensações do momento; é um agente de conhecimento na medida em que possibilita decifrar o que se passa comigo por meio das sensações que produz; também funciona enquanto abertura, pois o corpo se abre ao fluxo criativo da imaginação. E na cena psicodramática é ele que permite a explicitação do imaginário, transformando pensamentos em coisas, desejos, fantasias e sonhos. O conflito pode vir à tona por meio da ação espontânea e revelar o imaginário.

Para Antonio, o pensamento recorrente foi concretizado no 'como se' dramático e permitiu que ele tivesse uma ação sobre ele. Além disso, entrou em contato com as emoções que ele provocava e fez associações importantes com sua história e suas relações afetivas. Ele deixou de ser um agente passivo do pensamento, aquele que apenas procurava subterfúgios para suportar o incômodo que lhe causava. A ação dramática o tornou ativo, conhecedor e proprietário de seus pensamentos e sensações do seu corpo.

Com essa sessão de Antonio, encerro a discussão sobre a dramatização como uma etapa da sessão psicodramática com crianças. As possibilidades não se encerram com o que foi apresentado, mas considero que os exemplos demonstraram que o trabalho com crianças não se diferencia muito do realizado com adultos, especialmente pela sessão da última criança. A idade, como todos os psicoterapeutas psicodramatistas concordam, é um diferencial na prática psicoterápica. Crianças pré-escolares tomam papéis e os representam, mas não invertem. Quanto maiores, maior a possibilidade de criação e consequentemente de inversão de papéis.

Outras características foram apresentadas no decorrer deste subitem e serão retomadas nas considerações finais deste trabalho. Discuto a seguir a última etapa da sessão psicodramática, o compartilhar.

3. Compartilhar

A última etapa do psicodrama é o compartilhar, na qual os sujeitos presentes são convidados a expressar pensamentos, sentimentos e experiências pessoais oriundas do trabalho psicodramático. Cada um fala a

partir de si e não do outro. É uma etapa essencial, pois é o momento em que o protagonista retorna ao grupo e as emoções são compartilhadas - ele tem a chance de ver sua criação dramática repercutindo no outro (Moreno, 1983, 1999). Esta etapa se dá no contexto grupal, mas Perazzo (1996) faz uma discussão a respeito, ampliando seu alcance e qualificando outros momentos da sessão psicoterápica em que ela ocorre.

A etapa do compartilhar às vezes é considerada desnecessária ou inexistente por psicodramatistas contemporâneos (Alegre, 1980; Gonçalves, 1988; Petrilli, 2000). Avalio que ela acontece numa sessão com crianças e o que determina sua explicitação verbal, ou não, é o próprio desenrolar da sessão psicodramática. Concorro com Perazzo (1996), que diz que o compartilhar está presente em todas as etapas de uma sessão e não somente na etapa formal. O autor reflete que no aquecimento inespecífico o compartilhar se faz em dois níveis:

“co consciente, por seu conteúdo manifesto e nível co inconsciente, apenas inferido, sem que haja uma explicitação do conteúdo latente, a trama oculta. É este processo de forças o processo co criativo capaz de construir o caminho para a dramatização num mesmo projeto dramático, do qual também participam o diretor e os ego-auxiliares com suas subjetividades, tanto co conscientemente quanto co inconscientemente.” (1996, p.2).

Estes conteúdos, ou seja, a subjetividade presente na criança e terapeuta quando se inicia a sessão, compõe o projeto dramático. O encaminhar da proposta, seja ela um jogo, uma brincadeira, um desenho, uma história, são coconstruídos. Esse movimento conjunto perpassa o aquecimento inespecífico, específico e se encaminha para a dramatização. A construção conjunta da proposta psicodramática possibilita o compartilhar. O terapeuta no contrapapel

transitará entre ser diretor e ego auxiliar e essa dupla função lhe oferece proximidade muito grande com a criança e com seus contrapapéis. A experiência com a criança já é em si um compartilhar e a sua explicitação se dá em vários níveis e não, exclusivamente verbal.

Na etapa formal do compartilhar, não importa se a criança verbaliza ou não, o clima afetivo está presente e é compreendido por ambos. Às vezes ouve-se um *Foi legal*, mas não importa se nem essas palavras surgiram após esse processo comum. O terapeuta, que desempenhou os papéis psicodramáticos como ego-auxiliar, pode explicitar o próprio percurso interno a partir desses papéis. A viabilização de um compartilhar constante, perpassando a sessão é que dá sentido, na prática, a uma concepção relacional contida na filosofia moreniana do momento. Perazzo conclui que:

“(...) compartilhar, não importa de que modo, dependendo da qualidade com que se interpenetram co consciente e co inconsciente num processo co criativo, poderá ser a parte visível e vivida daquilo que a filosofia do momento de Moreno chamaria de encontro, ou o seu desencadeante possível no presente ou num ponto futuro.” (p.6).

Por meio dos exemplos a seguir, será possível descrever o compartilhar segundo essa conceituação e sua função na psicoterapia psicodramática com a criança.

Na sessão com Giovanna, o terapeuta, ao assumir o primeiro papel psicodramático (sua irmã mais velha), compartilhava, não verbalmente, com a criança algo como: *“Nós duas sabemos que é difícil para você entrar em contato com algumas coisas que acontecem na sua vida. Também tem sido difícil para mim poder te ajudar, mas vamos lá, não vamos ficar paradas nisso porque você está sofrendo e sabemos disso também. Vou começar trazendo sua irmã mais*

velha.” Passada essa primeira ‘mensagem’ e iniciado um processo de aquecimento específico, Giovanna diz claramente: *“Você fez uma imitação barata da minha irmã.”* É como se dissesse: *“Não pense que vai ser fácil, preciso de muito mais que isso, mas não desista de mim.”* Terapeuta diz então, que outro personagem virá para a ação, sua irmãzinha, mas um pouco diferente, mais crescidinha na linguagem. O que fica implícito entre terapeuta e criança: *“Sabemos que está difícil com a pequeninha e você tem coisas a dizer e fazer com ela que só são possíveis aqui no nosso ‘como se’, então vamos lá!”* A partir disso a ação dramática se inicia. Todo esse processo inicial é uma forma de compartilhar, que se mantém no percurso da dramatização e na etapa formal ele é retomado verbalmente.

Depois de ela deixar pai, mãe e irmã mais velha amarrados e amordaçados e a irmãzinha isolada, encerramos a dramatização e retornamos ao contexto-grupal.

Arrumamos as almofadas, desfaz-se o cenário. Pergunto como foi fazer essa história, ela diz: - *Legal*. Eu digo o mesmo e compartilho a partir dos papéis que desempenhei. Falo que não foi muito fácil fazer o papel dos familiares porque ela estava muito brava e todos tinham apanhado muito; cada um tinha ficado surpreso com a reação dela, pois não tinham ideia de que ela estava tão brava e descontente. Depois ficaram assustados com sua reação. Como irmãzinha, eu tinha ficado com medo e estava muito triste por ter ficado sozinha lá no canto, sem poder nem brincar. Ela tem um semblante de entusiasmo, e sem dizer verbalmente, ‘diz’: *“Eu avisei que não era para mexer comigo; posso até virar um monstro de brava. Adorei bater em todos de mentirinha, fazê-los sentir um*

pouco de medo, de dor; fazer minha irmãzinha se sentir sozinha também. Eu precisava disso e sei que aqui eu posso!”

As etapas do psicodrama ocorreram tal como numa sessão com adultos: aquecimento, dramatização e compartilhar. O diretor quando faz uma associação da história ou aspectos dela com situações da vida real da criança, proporciona uma reflexão e elaboração desses conteúdos. Diferente das crianças menores, essas já distinguem realisticamente os fatos e podem fazer conexões importantes do que foi vivido no contexto dramático para o contexto social, ou seja, sua história real. Essa postura é compartilhada por Tassinari (1990).

Na história de “*Afonsinho*”, quando retomamos o contexto grupal, Pedro diz: “*É, essa história começou triste e terminou triste*”. Ele vivia um período difícil na vida familiar e, no percurso da história, várias vezes o terapeuta, por meio dos contrapapéis, compartilhou pensamentos e sentimentos que condiziam com aspectos do contexto social e que puderam ser explicitados no contexto dramático. As cenas possibilitaram identificar, entrar em contato com os sentimentos e explicitá-los.

Na história das duas famílias e os primos, no contexto grupal, o psicoterapeuta pergunta o que ela achou da história e ela, já fora do papel psicodramático diz que achou um ‘cocô’. Essa é uma resposta padrão. *Psicoterapeuta compartilha a partir do papel de primo, dizendo o quanto tinha sido difícil aquela situação pra ele. Ela foi lhe tratando muito mal porque queria o seu brinquedo; chegou a dar raiva dela. A mãe dela lhe parecia brava demais mesmo; ele também não gostou da atitude dela. Mas, percebeu também que parecia que a menina queria que a mãe lhe desse algo e*

não ele. Ele ficou triste por ela ter sido tratado daquela forma. Mas não ligou muito de saber que quando a mãe lhe deu o presente, ela ficou satisfeita, feliz, porque era isso que ela queria mesmo - a mãe era muito importante e ela precisava que lhe desse coisas; ele também gostava de receber coisas da mãe dele. Ela ouviu silenciosamente.

Seu compartilhar no aquecimento inespecífico foi falar de sua ambiguidade: “*Caguei na sua cabeça*” enquanto fazia corações para o psicoterapeuta. No final da dramatização, com semblante de satisfação diz que a história foi um “cocô”. Vivenciar no ‘como se’ conflitos e contradições e ouvir do compartilhar do primo (que era seu igual) pôde auxiliá-la a refletir sobre as questões: seu lugar sociométrico na família; a relação com sua mãe; seu papel de filha na relação com a mãe, com o pai; desejos e necessidades que surgem nessas relações e como ela tem lidado com isso, bem como as reações que incidem a partir de seu comportamento.

Na psicoterapia psicodramática com crianças o compartilhar segue o mesmo princípio da psicoterapia com adultos, o do *Encontro*, do projeto dramático sendo uma coconstrução de subjetividades. A subjetividade é explicitada pela ação, pelos pensamentos e sentimentos de ambos, na cena e fora dela. O que a criança pequena não consegue fazer por si, tem a ajuda do terapeuta. Nas cenas imaginárias, os personagens que surgem como contrapapéis, tomam vida através do ego-auxiliar e se colocam perante a criança, favorecendo que ela experimente e reorganize novas possibilidades de relação em função da espontaneidade. As exigências do papel social, seus desejos e necessidades em conflito e contradição com as leis são reveladas e transformadas

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Vimos neste trabalho que a psicoterapia é uma prática relativamente nova da saúde mental. Iniciou-se nas primeiras décadas do século passado com o público adulto e, com as crianças, um dos motivos que propiciaram seu surgimento, foi o fato de os psicoterapeutas perceberem que a infância era fonte de dificuldades adultas.

Assim sendo, as crianças passaram a ser sujeitos da psicoterapia. Da supremacia inicial da psicanálise e dos princípios profiláticos da psico-higiene, alcançamos, após a metade do século, várias possibilidades de psicoterapias com crianças. É nesse período que o Psicodrama se instala no Brasil como uma teoria e uma prática psicoterápica possíveis.

Os primeiros psicodramatistas brasileiros, que se interessaram em trabalhar com crianças, em geral, por terem formação anterior em psicanálise, basearam-se nesta para cobrir “lacunas” do psicodrama. Algumas críticas foram, e são feitas a Moreno, pelo fato de ele não ter criado uma teoria do desenvolvimento nem de psicopatologia. Apesar de médico, ele não tinha essa preocupação porque o seu foco de trabalho era no inter-relacional e não no intrapsíquico.

Mas, essa discussão ainda persiste entre os psicodramatistas e percebemos que isso favoreceu uma divisão entre os psicoterapeutas que trabalham com crianças. Alguns autores como Gonçalves (1988) e Petrilli (2000), buscaram contribuições de outras teorias psicológicas para compreender e fundamentar sua prática, e outros, em especial Tassinari (1990), consideraram que a socionomia traz suporte suficiente para a prática psicoterápica.

Entretanto, há um entendimento comum entre os psicodramatistas de que há uma diferenciação entre a psicoterapia de adultos e a de crianças, considerando que estas últimas têm recursos psicológicos e vivem num contexto diferente do adulto.

As ações que se referem à estrutura da prática psicodramática, implicam em considerar o que Moreno definiu como contextos, etapas e instrumentos. Estes três conceitos constituem uma estrutura que se repete na prática psicodramática, seja na sua modalidade psicoterápica ou socio educacional, individual ou grupal. A discussão da prática desse trabalho baseou-se nessa estrutura.

Contextualizar a criança no processo psicoterápico implica em considerar que sua vinda à psicoterapia é compulsória, mas, isso não se constitui como um problema, geralmente as crianças tomam o espaço psicoterápico como positivo. Ao mesmo tempo, enquanto para os adultos a família é apenas referida, com as crianças sua presença é frequente e importante no processo psicoterápico. Grande parte da demanda de minha prática clínica está voltada a questões familiares, e isso permitiu discutir aspectos específicos da criança inserida num contexto familiar em transição ou crise. Dessa forma, podemos compreender a limitação desse trabalho no que se refere às possibilidades de demandas psicoterápicas.

Neste trabalho, a prática da psicoterapia psicodramática foi discutida e fundamentada na teoria socionômica. A teoria da espontaneidade e criatividade, a sociometria, a teoria de papéis e a teoria do momento ofereceram subsídios para a ação dramática e para a compreensão do processo psicoterápico da criança. É importante para futuros trabalhos, pesquisar diferentes “queixas” para

que se verifique se a teoria e estrutura prática da socionomia dão suporte suficiente ao trabalho.

Tal como na psicanálise, os psicodramatistas, de forma geral, utilizam-se de brinquedos para o trabalho psicoterápico. Na psicoterapia psicodramática com crianças, a função principal do brinquedo é de aquecimento, tanto para aquecê-la para o papel dramático quanto para mantê-la aquecida durante a dramatização. Considera-se que o jogo dramático e o desempenho de papéis auxiliam a criança no enfrentamento de suas dificuldades e limitações, favorecendo o desenvolvimento de recursos para lidar com essa demanda. As crianças pré-escolares manifestam-se mais espontaneamente por meio do jogo dramático, o que não acontece necessariamente com as maiores, que precisam ser aquecidas, porque sua espontaneidade é intermediada pelas conservas culturais.

O cenário é considerado um instrumento essencial para o trabalho com crianças, porque ele contextualiza a ação, aquece psicoterapeuta e criança, e define papéis. A expressão da criança, como protagonista, ocorrerá por meio de cenas reais, imaginárias ou fantasiosas. Diferentemente dos adultos, especialmente as pré-escolares, não trazem cenas do seu cotidiano para serem trabalhadas, segundo minha prática. O psicoterapeuta psicodramatista de crianças necessita ter disponibilidade para dirigir e atuar ao mesmo tempo. Deve estar atento para o exercício dos contrapapéis que ora lhe são designados, ora têm que ser trazidos por meio de sua percepção e atenção ao movimento da criança, considerando que ela transita mais livremente entre os contextos. Isso significa que um psicoterapeuta psicodramatista necessita de aquecimento para acompanhar a criança que entra e sai rapidamente do contexto dramático.

O aquecimento é considerado da perspectiva de possibilitar que um projeto dramático aconteça. Assim, tem a função de manutenção dos contextos, a delimitação entre o dramático e o grupal, o jogo de papéis, e o desfecho da trama, que implicam num aquecimento contínuo de criança e psicoterapeuta.

A ideia de que o conflito está relacionado com a forma como estão estruturadas as relações dentro da coletividade, mostra a importância do contrapapel na encenação psicodramática (Moreno, 1975). No contexto dramático é possível emergir a estrutura vincular dos papéis que são jogados e o efeito terapêutico disso para a criança está associado à manifestação do inconsciente, ou seja, a cocriação da experiência vivida e compartilhada. Assim, a criança pode, por meio da relação com o psicoterapeuta, nos seus contrapapéis, experimentar novas formas e padrões de comportamento que são permitidos no 'como se', mas proibidos ou difíceis de serem realizados no contexto social. Para a criança, significa oferecer novas perspectivas de conhecimento, aprender a lidar com diferentes papéis sociais que têm *scripts* divergentes entre si e que ela aprende a escolher, dependendo de quando, como e com quem se relaciona.

Os psicoterapeutas de psicodrama com crianças consultados neste trabalho (Ferrari, 1985; Gonçalves, 1988; Tassinari, 1990; Petrilli, 2000; Filipini, 2005), são unânimes em dizer que a técnica do duplo é a mais utilizada com crianças pré-escolares. Com as maiores, as escolares, praticamente todas as técnicas podem ser utilizadas, inclusive a inversão de papéis. Contrariando Moreno e Zerka Moreno, todos concordam que as pré-escolares não têm condições de realizar a inversão de papéis tal como a técnica pretende. Ao mesmo tempo, consideram (Tassinari, 1990) que as crianças,

independentemente de sua idade, seguem o princípio do desenvolvimento de papéis para o desempenho dos mesmos, isto é, *role taking*, *role playing* e *role creating*.

Por meio da prática clínica com crianças, constatei que, quando a criança escolhe para o psicoterapeuta um papel simétrico ao seu, favorece o 'princípio do duplo espelho'. A função desse princípio é a mesma do duplo e espelho, ou seja, ampliar a capacidade de percepção da criança. Chamei esta ação de Técnica do Duplo-Espelho e verifiquei que ela é bem aceita tanto pelas crianças pré-escolares, como as escolares. Ela é de fácil manejo; pode ser empregada por iniciativa da criança, quando ela escolhe o seu contrapapel, ou sugerida pelo psicoterapeuta. Não há necessidade de interrupção de cena para que seja aplicada, ao contrário, está incluída na mesma por meio do desempenho de papéis psicodramáticos.

Outra questão pouco abordada pela maioria dos psicoterapeutas é a importância do compartilhar. Considero que esta etapa da sessão psicoterápica é semelhante à de adultos, porém, compreendida como Perazzo (1996, 1999) discorreu em seu trabalho: um compartilhar que se inicia no aquecimento, percorre toda a ação dramática e se encerra com a etapa formal de compartilhamento. Seu objetivo é o *Encontro*, a realização de um projeto dramático que se faz por uma co construção de subjetividades, a qual será explicitada pela ação, pelos pensamentos e sentimentos da criança e do psicoterapeuta, em seus devidos papéis e contrapapéis.

Este trabalho, além de discutir como os autores de psicoterapia psicodramática com crianças realizam seu trabalho, mostrou que a teoria socionômica tem uma estrutura teórica e prática que o fundamentam, tal como

afirmou Tassinari (1990). Considero que a ação dramática, onde os personagens surgem como papéis e contrapapéis, favorece que a criança experimente e reorganize novas possibilidades de relação em função da espontaneidade.

Poder refletir sobre minha prática de psicoterapia psicodramática com crianças me remeteu a uma frase de uma das crianças que acompanhei ao longo do meu trajeto profissional: *“Sabe quando você come um chocolate bem gostoso e que quando vai chegando no finzinho, você não quer que ele acabe?”* Essa criança se referia à sua paixão por uma outra. Creio que ela ilustra esse meu ‘pensar’ sobre a psicoterapia psicodramática com crianças.

Referências Bibliográficas

- Abrão, J. L. F. (2009) As Origens da Psicanálise de Crianças no Brasil: Entre a Educação e a Medicina. *Psicologia em Estudo*, Maringá, v. 14, n. 3.
- Aguiar, M. (1998) Teatro espontâneo e psicodrama. São Paulo, Agora.
- Alegre, C. A. (1982) Psicodrama para crianças (p.182-191). In Bustos, D.M. O Psicodrama: Aplicações da Técnica Psicodramática. Summus Editorial, São Paulo.
- Almeida, W. C. (1994) Prefácio do livro: *Ainda e Sempre Psicodrama* de S. Perazzo, São Paulo, Ágora.
- Almeida, W. C. (2006) Psicoterapia Aberta. São Paulo, Ágora.
- American Psychological Association, APA (2010) ARTMED Editora, Porto Alegre, P.765.
- Andrade, A.S. (1997) Uma Abordagem Psicodramática Moreniana para o Atendimento de Crianças com dificuldades de Aprendizagem nas Séries Iniciais da Escolaridade. São Paulo: FEBRAP, *Revista Brasileira de Psicodrama*, V. 5, No. 2, p. 93-106.
- Andrade, A.S. (1996) Psicodrama Moreniano com alunos portadores de deficiência mental. In: Goyos, A.C.; Almeida, M.A. e Souza, D. (orgs.) *Temas em Educação Especial III*, p. 568-574. São Carlos, Ed. Da UFSCar.
- Andrade, A.S. (1999) Psicodrama aplicado a grupos de crianças com dificuldades de aprendizagem. *Temas em Educação em Saúde I*, p. 33-42. Araraquara: Gráfica FCL/UNESP.
- Antunes, M. A. M. (org.) (2004) História da psicologia no Brasil: primeiros ensaios. Rio de Janeiro: EDUERJ.
- Antunes, Barbosa, Pereira, (2002) Psiquiatria, loucura e arte: fragmentos de história brasileira. EdUSP.
- Anzieu, D. (1981) Psicodrama analítico. Rio de Janeiro, Campus.
- Assunção, K. (2005) Uma história do psicodrama e algumas reflexões. Monografia de conclusão de curso de formação em Psicodrama, convênio Sociedade de Psicodrama de São Paulo e Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. São Paulo.
- Avellar, L. Z. (2001) Jogando na análise de crianças: Intervir – interpretar na abordagem Winnicottiana. Tese de Doutorado em Psicologia Clínica, Puc-SP.
- Bastos, O. (1998) Vida Associativa Psiquiátrica Brasileira: alguns dados históricos. *Jornal Brasileiro de Psiquiatria*, Rio de Janeiro, v. 47, n.5, p. 213-216.
- Benedito, V. I.; Baptista, T. T.; França, M. R. C.; Vero, J. (1988) Rematizando a relação pais-filhos. In Gonçalves (org.) *Psicodrama com crianças*, São Paulo, Ágora, p. 43-52.
- Bicudo, V. L. (1988) Aspectos Históricos do Desenvolvimento da Psicanálise da criança no Brasil. Parte I: Instituto de Psicanálise da S.B.P.S.P. *Revista Brasileira de Psicanálise*, São Paulo, n. 22. p. 661-672.
- Boccardo, M. D. (2011) Psicodrama e TDAH. In Payá, R. *Intercâmbio de psicoterapias – como cada abordagem psicoterápica compreende os transtornos psiquiátricos*. Ed. Roca, São Paulo.

- Boukobza, C. (1993). "Situação de Hermine Von Hug-Hellmuth". In: *L'enfant et la psychanalyse*. Tradução de Maria Aparecida Angélico Cabral. Paris, Édition Esquisses. Psychanalytique, p. 41-47.
- Brozek, J. e Massimi, M. (1998) Historiografia da Psicologia Moderna: a versão brasileira. Ed. Loyola, São Paulo.
- Caillois, R. (1958) Os jogos e os homens. Lisboa, Ed. Cotovia Ltda, 1990, 287 p.
- Calvente, C. (1993) Interpolação de Resistências. In Monteiro, R. (org.) *Técnicas fundamentais do psicodrama*. Ed. Brasiliense, São Paulo. P. 121-131
- Campos, R. H. F.; Bernardes, L. H. G. (2005) A revista Psicologia: Ciência e Profissão: um registro da história recente da Psicologia Brasileira. *Psicologia: Ciência e profissão*. Brasília, vol. 25, n. 4, p. 508-525.
- Castro, P. F. de (1999), Reflexões em Psicologia e Ciência: uma análise da pesquisa aplicada à psicologia clínica. *Psicologia: Teoria e Prática*, São Paulo, v.1, n. 1, p. 3-13.
- Cepeda, N. A. (2010) Masp 1970: o psicodrama/Norival Albergaria Cepeda, Maria Aparecida Fernandes Martin. São Paulo, Agora.
- Cesarino, A. C. (1999) "Brasil 70: psicodrama antes e depois". In: Almeida, W.C. (org). Grupos: a proposta do psicodrama. São Paulo, Agora.
- Chazaud, J. (1977) As Psicoterapias da Criança. Rio de Janeiro, Zahar Editores.
- Conselho Federal de Psicologia (2009), Ano da Psicoterapia: Textos Geradores, Coletânea, CFP, Brasília, p.17-18
- Costa, M. I. M. (2003) A Prática da psicoterapia infantil a partir do referencial teórico do Psicodrama, Gestalt Terapia e Abordagem centrada na pessoa, sob as óticas de Bermúdez, Ferrari, Oaklander e Axline. Dissertação de Mestrado em Psicologia Clínica – Pró Reitoria de Pós-Graduação, Universidade Católica de Pernambuco, Recife.
- Conte, F. C. S.; Regra, J. A. G. (2000) Psicoterapia Comportamental Infantil: novos aspectos. In: SILVARES, E. F. M.. (Org.). Estudos de Caso em Psicologia Clínica Comportamental Infantil. Campinas: Papirus, v. 1
- Echániz, José, (1970) "La sesión de psicodrama com grupos de niños", in Cuadernos de Psicoterapia, Genitor, Buenos Aires, vol. V, no. 1, pp. 53-59.
- Ferrari, D.C.A. e Leão, H.M.G. (1982) Psicodrama infantil: Teoria e prática. *Revista da FEBRAP*, ano 6, no. 2, pp.50-64.
- Ferrari, D. C. de A. (1985) "A Postura do Psicodramatista no Psicodrama de Criança". *Revista da FEBRAP*, 7(2): 55-60.
- Filipini, R. (1994) O "período das histórias da oncinha apaixonada" numa criança portadora da Síndrome de Asperger. Trabalho apresentado no II Congresso de Psicodrama da Infância e Adolescência. Curitiba.
- _____, (2003) Grupo de Apoio para crianças na situação de divórcio ou separação parental. Dissertação de Mestrado em Psicologia Clínica, PUC-SP.
- _____, (2005a) Divórcio ou separação parental – sociodrama como intervenção nos períodos de transição e crise. In Intervenções grupais na saúde, Fleury e Marra (org.) São Paulo, Ed. Ágora, p. 35-52.
- _____, (2005b) Psicodrama com crianças: algumas considerações sobre a prática. In Psicodrama: teoria e prática de Dalmiro M. Bustos, São Paulo, Ed. Ágora.
- _____, (2005c) Psicodrama com crianças nas transições familiares. *Revista Brasileira de Psicodrama*. Vol. 13, no. 1, ano 2005, p. 117-126.

- _____, (2009) Reconfiguração sociométrica da família na contemporaneidade: os desafios de crianças e adolescentes. In *Revista Brasileira de Psicodrama*, Vol. 17, no. 1, ano 2009, P.35-49.
- Fonseca, J. (1980) *Psicodrama da Loucura*. São Paulo, Ágora.
- _____, (1996) Ainda sobre a Matriz de Identidade. In *Revista Brasileira de Psicodrama*. V. 4, fasc. II, p. 21-34.
- _____, (2000) *Psicoterapia da Relação: elementos de psicodrama contemporâneo*. São Paulo, Agora.
- _____, (2012) Onde está o reconhecimento do ele na matriz de identidade? Interseções entre Moreno e Lacan. In *Revista Brasileira de Psicodrama*, vol. 20, no. 1, 2012, p. 115-134.
- Freud, A. (1971) *Infância Normal e Patológica: Determinantes do desenvolvimento*. Ed. Zahar, Rio de Janeiro.
- _____, (1996) *O ego e os mecanismos de defesa*. Rio de Janeiro, Civilização Brasileira.
- Freud, S. (1909) Análise de uma fobia em um menino de cinco anos. In: op. Cit., vol. X.
- Garrido Matín, E. (1984) *J. L. Moreno: Psicologia do Encontro*. São Paulo, Livraria Duas Cidades.
- Glenn, J., organizador (1996) – *Psicanálise e Psicoterapia de Crianças*. Porto Alegre, Artes Médicas.
- Goldsmid, R.; Féres-Carneiro, T. (2007) A função fraterna e as vicissitudes de ter e ser um irmão. *Psicologia em Revista*, Belo Horizonte, v. 13, n. 2, p. 293-308, dez. 2007
- _____, (2011) Relação Fraterna: constituição do sujeito e formação do laço social. *Psicologia USP*, vol. 22, n. 4. São Paulo, Oct. Dez.
- Gonçalves, C.S. & Wolff, R. J. & Almeida, W.C. (1988) *Lições de Psicodrama: Introdução ao pensamento de J. L. Moreno*. São Paulo, Ágora.
- Gonçalves, C.S. (org.) (1988) *Psicodrama com Crianças - Uma psicoterapia possível*, 2ª. ed. São Paulo, Agora.
- Gonçalves, C. (1993). Técnicas básicas: duplo espelho e inversão de papéis. In: Monteiro, R. (coord). *Técnicas fundamentais do psicodrama*. São Paulo: Brasiliense, p. 19-31.
- Gesell, A. (1985) *A criança dos 0 aos 5 anos*. Martins Fontes, São Paulo.
- Graham, G. (1960) "Sociodrama as a teaching technique". *Social Studies*, (51): 257-259, dec.
- Hazelton, T.; Price, B. e Brown, G. "Psychodrama, creative movement and remedial arts for children with special educational needs". *Association of Educational Psychologists Journal*, 5(1): 32-37.
- Hozman, M. E. F. e Silva, M. S. (1980) "Psicodrama aplicado à educação: diretrizes gerais para o desenvolvimento afetivo e psicomotor de alunos de 1o grau da Rede Municipal de Ensino de Curitiba" *Revista da FEBRAP*, 3(1): 24-26.
- Jardim, R. A. R. da V. (1988) Matriz de Identidade e desenvolvimento afetivo-emocional – dois esquemas. In Gonçalves, C. S. (org.) – *Psicodrama com crianças*, São Paulo, Ágora.
- Kazdin, A. E. (1987). Treatment of antisocial behavior in children: Current status and future directions. *Psychological Bulletin*, 102, 187-203.

- Kaufman, A. e Gonçalves, C. (1988) "Psicodrama Moreniano com Criança" IN: Gonçalves, C. S. Psicodrama com crianças: uma psicoterapia possível. São Paulo: Ágora, p. 65-75.
- Kestenberg, R. e Jeammet, P. O psicodrama psicanalítico. São Paulo, Papirus,.
- Klein, M. (1969) Psicanálise da criança, Mestre Jou, São Paulo.
- Knobel, A. M. (2004) Moreno em Ato: a construção do psicodrama a partir das práticas. São Paulo, Agora.
- _____, (2009) Em tempo presente: o co-inconsciente. Artigo não publicado.
- Malaquias, M.C. (2007) "Percurso do Psicodrama no Brasil: década de 40 – O pioneirismo de Guerreiro Ramos". In: *Revista Brasileira de Psicodrama*, São Paulo, v. 15, no. 1, p. 33-39.
- Malan, D. (1983) Psicoterapia individual e a ciência da psicodinâmica. Porto Alegre, Artes Médicas.
- Manhães, M. P. (1988) Aspectos Históricos do Desenvolvimento da Psicanálise da Criança no Brasil. Parte III: Sociedade Psicanalítica do Rio de Janeiro. *Revista Brasileira de Psicanálise*. São Paulo, Associação Brasileira de Psicanálise, n. 22, p. 659-.
- Marienau, R.F. (1992) Jacob Levy Moreno, 1889-1974: Pai do psicodrama, da sociometria e da psicoterapia de grupo. São Paulo, Ágora.
- Massaro, G. (1996) Esboço pra uma teoria da cena: proposta de ação para diferentes dinâmicas. São Paulo, Ágora.
- Massimi, M. (org.) (2004) História da Psicologia no Brasil no século XX. São Paulo, EPU.
- Mezher, A. (1980) Um Questionamento acerca da Validade do Conceito de Papel Psicossomático. *Revista da FEBRAP*, ANO 3º., 1: 221-223.
- Mira y López, E. (1967) Manual de Psicoterapia. São Paulo, Ed. Mestre Jou.
- Moraes, M. L. S., (1980) "O Faz-de-Conta e a Realidade Social da Criança", dissertação de mestrado, Instituto de Psicologia da Universidade de São Paulo, São Paulo.
- Moreno, J.L.(1972) Fundamentos de la Sociometria, Ed. Paidós, Buenos Aires.
- _____, (1974) Psicoterapia de grupo e Psicodrama. (Trad.: Antônio D. M. Cezarino Filho). São Paulo: Mestre Jou.
- _____, (1975) Psicodrama, Ed. Cultrix, 2ª ed., São Paulo.
- _____, (1983) Fundamentos do Psicodrama. São Paulo, Summus.
- _____, (1984) O Teatro da Espontaneidade. São Paulo, Summus.
- _____, (1987) Psicodrama. (Trad.: Álvaro Cabral). São Paulo: Cultrix.
- _____, (1992) Quem Sobreviverá? Fundamentos da Sociometria, Psicoterapia de Grupo e Sociodrama. Goiânia, Dimensão Editora, v.1,2 e 3
- _____, (1999) Psicoterapia de grupo e psicodrama, Campinas, Editora Livro Pleno.
- Moreno, Z. T. (1975a), Psicodrama de Crianças. Vozes, Petrópolis.
- Moreno, Z.; Blomkvist, L. D.; Rützel, T. (2000-2001) *A realidade suplementar e a arte de curar*. São Paulo. Ágora.
- Motta, J. M. C. (org.) (2008) Psicodrama Brasileiro: história e memórias. São Paulo, Agora.
- Naffah, A. (1980) Psicodramatizar. São Paulo, Agora.
- _____, (1982) As psicoterapia hoje: algumas abordagens. Organização Ieda Porchat; São Paulo, Summus.
- _____, (1994) – A psicoterapia em busca de Dioniso: Nietzsche visita Freud. Ed. Educ/Escuta, São Paulo.

- Narvaez, M. C. (1977) "Sicodrama en niños de 3 a 5 años". Cuadernos de Sicoterapia, Buenos Aires: Genitor, 11(1-2)-12(1-2): 183-198, Junio, 1976 - Mayo.
- Navarro, M. P. (1988) "Caminhos e descaminhos do poder no psicodrama no Brasil". Salvador, 1988 (texto baseado em palestra proferida no VI Congresso Brasileiro de Psicodrama, em Salvador, Bahia).
- Nery, M. P.; Conceição, M. I. G., org. (2012) – Intervenções grupais: o psicodrama e seus métodos. São Paulo, Ágora.
- Nunes, M. L. T., & Lhulier, A. C. (2003). Histórico da pesquisa empírica em psicoterapia. *Revista Brasileira de Psicoterapia*, 5, 97-112
- Oliveira, I. T. (1999) Psicoterapia Psicodinâmica Breve: dos precursores aos modelos atuais. *Psicologia: Teoria e Prática*, São Paulo, v. 1, n. 2, p. 9-19.
- Pamplona da Costa, R. (2001) "A chegada do Psicodrama no Brasil – Sua história de 1960 a 1970". In: *Revista Brasileira de Psicodrama*, São Paulo, v.9, no. 2.
- Pavlovsky, E. (1981) Psicoterapia de grupo em niños y adolescentes. Madrid, Fundamentos.
- Perazzo, S. (1994) Ainda e Sempre Psicodrama, São Paulo, Agora.
- _____, (1996) Compaixão e Compartilhar. Artigo apresentado no 10º. Congresso Brasileiro de Psicodrama, Caldas Novas (GO).
- _____, (1999) Fragmentos de um olhar psicodramático. São Paulo, Ágora.
- Pereira Rojas Boccacalandro, M. y Queiroz Pérez-Ramos, A. M. de. (2004) Clínica Psicológica "Ana Maria Poppovic". Notas sobre seu histórico e desenvolvimento atual. Boletim Academia Paulista de Psicologia [en línea] 2004, vol. XXIV [citado 2013-02-23]. Disponible en Internet: <http://redalyc.uaemex.mx/src/inicio/ArtPdfRed.jsp?iCve=94612361005>. ISSN 1415-711X.
- Peres, V. L. A. Psicodiagnóstico infantil: a utilização dos modelos psicanalítico e Psicodramático. *Revista da Febrap*, Ano 7, no. 3, p. 101-122.
- Petrilli, S.R.A. (1984) Abordagem psicodramática de uma criança e seus pais. *Revista da Febrap*, ano 1, no. 6, ano 1984, p. 106-109.
- _____, (1985) A postura psicodramática em um processo psicoterapia infantil e seu valor terapêutico familiar. 1985 – ano 7, no. 3, p 83-100.
- _____, (1992) Notas sobre o psicodiagnóstico de crianças na prática psicodramática. Apresentado no 8º. Congresso Brasileiro de Psicodrama, São Paulo.
- _____, (2000) Psicoterapia através da relação. In: Fonseca, J., Psicoterapia da Relação: Elementos de psicodrama contemporâneo. São Paulo, Agora, p. 335-389.
- _____, (2002) Psicodrama com crianças: raízes, transformações, perspectivas. Trabalho apresentado no XIII Congresso Brasileiro de Psicodrama, Costa do Sauípe.
- Piaget, J. (1946) A Formação do Símbolo na Criança. Trad. Álvaro Cabral, 3ª. Edição, Rio de Janeiro: Zahar, 1978, 370 p.
- Piaget, J. (1975) A Formação do Símbolo na Criança. (Trad.: Álvaro Cabral e Christiano Monteiro Oiticica). Rio de Janeiro: Zahar, Ed.
- Pichon-Rivière, E. (1985) Teoría del Vínculo. Buenos Aires, Ediciones Nueva Visión.
- Porchat, I. (1999) O que é psicoterapia. São Paulo, Ed. Brasiliense.

- Puttini, E. F. "O papel do professor da pré-escola: uma abordagem Psicodramática". In: E.F. Puttini, L.F. Passos, M.C.M. Da Costa e S. da C. Urt Psicodrama na Educação. Ijuí: Unijuí, pp.:61-93.
- Rebouças, R. M. S.. (2008) Os objetos intermediários e intra-intermediário na psicoterapia psicodramática infantil em um caso de transtorno global do desenvolvimento. In Psicodrama e Neurociência: contribuições para a mudança terapêutica, org. por Fleury, Khouri, Hug , São Paulo, Agora.
- Ribeiro, J. P. (1986) Teorias e técnicas psicoterápicas. Ed. Vozes, Petropolis.
- Rocheblave-Spenlé, A. M. (1969) La Notion de Rôle em Psychologie Sociale. 2ª. Edição, Paris, Presses Universitaires de France.
- Rodegheri, V. L. (2011) A Psicoterapia em 23 Periódicos Nacionais: uma contribuição à história da Psicologia no Brasil. Mestrado em Psicologia Social pela Puc-SP, São Paulo.
- Rojas-Bermúdez, J. G. (1970) Introdução ao Psicodrama. São Paulo, Editora Mestre Jou.
- Rosa, J. T.; Olivi, M. E. W. (1994) Evolução Histórica da Psicoterapia de Grupo no Brasil. *Mudanças: Psicoterapia e Estudos Psicossociais*, São Bernardo do Campo, n. 02, p. 101-111.
- Rossi, M. (1984) "Psicodrama: sensibilização e treinamento com atendentes de excepcionais". *Revista da FEBRAP*, 6(1): 128-130.
- Segal, H. (1975) Introdução à obra de Melanie Klein, São Paulo, Imago.
- Soares, F. C. (1992) Psicodrama com Crianças. Curso Ministrado durante o 8o Congresso Brasileiro de Psicodrama.
- Souza, R. M. (1995) Os filhos do divórcio. In Macedo, R. M. S. (org.) Terapia Familiar no Brasil: o estado da arte. São Paulo: APTF, p. 511-8.
- _____, (1997) A criança na família em transformação: um pouco de reflexão e um convite à transformação. *Psicologia Revista*, 6, p. 54-76.
- _____, (1999) As crianças e suas ideias sobre o divórcio. *Psicologia Revista*, 9, p. 103-20.
- _____, (2000) Depois que papai e mamãe se separaram: um relato dos filhos. *Psicologia: Teoria e Pesquisa*, 16, n. 3, p. 203-11.
- _____, (2006) Amor, casamento, família, divórcio... e depois, segundo as crianças. São Paulo, Summus.
- Tassinari, M. (1990) Psicodrama com crianças: Uma introdução à teoria da prática. Anais do VII Congresso Brasileiro de Psicodrama. Rio de Janeiro: FEBRAP.
- _____, (2006) Avaliação diagnóstica em psicodrama com crianças. Vol. 14, no. 2, p. 13-21.
- Teixeira, R. P.; Nunes, M. L. T. (2001) Psicoterapia: uma história sem registro? *Revista Brasileira de Psicoterapia*, v. 3, n. 1, p. 55-64.
- _____, (2005) Algumas questões Éticas da Psicoterapia. *Revista Brasileira de Psicoterapia*. V. 7, n. 2-3, p. 195-202.
- Vygotsky, L. S. (1984) Formação Social da Mente. (Trad.: José Cipola Neto, Luis S. Menna Barreto e Solange C. Afeche). São Paulo: Martins Fontes.
- Wechsler, M.P.F. (1999) Psicodrama e Construtivismo: uma leitura Psicopedagógica. FAPESP; AnnaBlume, São Paulo.
- _____, (1998) Relações entre Afetividade e Cognição: de Moreno a Piaget. FAPESP; AnnaBlume, São Paulo.
- Wechsler, M.; Nakano, T. C. (2012) O desenho infantil – forma de expressão cognitiva, criativa e emocional. São Paulo, Ed. Casa do Psicólogo.

Widlöcher, Daniel, Psicodrama Infantil, Vozes, Petrópolis.

Winnicott, D.W. (1975) O Brincar & a Realidade. Imago Ed. Ltda., Rio de Janeiro.